

Maria Pontillo
Stefano Vicari

L'ansia nei bambini e negli adolescenti

Riconoscerla e affrontarla



il Mulino

Farsi un'idea



Agitarsi durante un'interrogazione o una gara sportiva al punto da non riuscire a portarle a termine; evitare di confrontarsi con i coetanei per paura del giudizio; temere il futuro e vivere nel bisogno di continue rassicurazioni. Per bambini e adolescenti l'ansia a volte supera il livello di guardia e diventa un vero e proprio disturbo. Una guida autorevole per capire cause e forme dell'ansia, e gli interventi più appropriati per fronteggiarla.

Maria Pontillo – psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, dirigente psicologo presso l'Unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma – è docente di corsi di formazione e master in Psicologia dello sviluppo e presso scuole di specializzazione in Psicoterapia cognitiva.

Stefano Vicari insegna Neuropsichiatria infantile all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dirige l'Unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Fra i suoi libri: "Il filo teso" (Giunti, 2019) e "La sindrome di Down" (2007) in questa stessa collana.



il Mulino

e-book

Maria Pontillo, Stefano Vicari

L'ansia nei bambini e negli adolescenti

Riconoscerla e affrontarla



il Mulino

e-book

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Per altre informazioni si veda <http://www.mulino.it/ebook>

Edizione a stampa 2020
ISBN 9788815286758

Edizione e-book 2020, realizzata dal Mulino - Bologna
ISBN 9788815355027

Indice

[La storia di Chiara: quando l'ansia diventa un disturbo](#)

1.

Capire cos'è l'ansia

2.

Quanti tipi di ansia e a quali età?

3.

Dove nasce l'ansia?

4.

La valutazione diagnostica

5.

Le therapie

6.

Alcuni consigli pratici per genitori e insegnanti

[Conclusioni](#)

[Per saperne di più](#)

[Ringraziamenti](#)

La storia di Chiara: quando l'ansia diventa un disturbo

Chiara è una ragazza di 14 anni. A scuola passa molto tempo da sola e si rifiuta categoricamente di partecipare ai lavori di gruppo. Quando è interrogata, Chiara suda eccessivamente, avverte un forte senso di nausea, sente il cuore che le batte molto velocemente e ha mal di testa. Spesso non riesce in alcun modo a parlare e chiede di uscire dalla classe.

Al di fuori della scuola non partecipa ad attività sportive, preferisce uscire con i genitori e si sente a disagio tra persone e con i coetanei che non conosce. Da sempre Chiara si rifiuta di dormire fuori casa quando non sono presenti anche i genitori. Inoltre, in terza elementare ha attraversato un periodo in cui accusava mal di stomaco e nausea prima dell'ingresso a scuola. Proprio nel corso di quell'anno scolastico era stata effettuata presso un centro privato una valutazione cognitiva e degli apprendimenti che aveva evidenziato abilità completamente adeguate all'età e alla scolarità e nessun palese segnale di disagio psicologico.

Durante il colloquio con una psicologa, Chiara racconta di sentirsi sempre preoccupata. Teme possa accaderle qualcosa

di spiacevole come una brutta malattia o un incidente e ha paura di commettere errori sia nello studio, e prendere quindi dei brutti voti, sia nel modo in cui si comporta con i propri compagni di classe. La agita moltissimo il pensiero del giudizio altrui, non vuole apparire inadeguata o «non sufficientemente brava». Le interrogazioni orali rappresentano il momento peggiore per il terrore di sbagliare davanti ai compagni e per la paura che i compagni stessi notino i «segni» della sua eccessiva preoccupazione, che consistono in tremori, sudorazione e rossore in volto. Chiara racconta di avere bisogno di essere costantemente rassicurata dalla madre sui propri comportamenti e sui compiti scolastici. Dice di non riuscire mai a rilassarsi, di sentirsi fortemente agitata tutti i giorni e per tutto il giorno.

Siamo tutti un po' ansiosi ma, a volte, l'ansia, come nel caso di Chiara, diventa una rivale apparentemente invincibile. I sintomi di Chiara sono, infatti, pervasivi, occupano gran parte della sua giornata e ne limitano la quotidianità. La ragazza vive con estremo disagio la scuola, non frequenta attività sportive e non cerca di vedere i compagni al di fuori dell'orario scolastico.

In questo libro ci occuperemo dell'ansia nei bambini e negli adolescenti: vedremo quando l'ansia è uno stimolo utile e transitorio e quando, invece, supera il livello di guardia diventando un vero e proprio disturbo. Capiremo le cause dell'ansia, quali forme può assumere e quali possono essere gli interventi più appropriati per aiutare i ragazzi, grandi e

piccoli che siano, a fronteggiarla. Concluderemo con alcuni consigli pratici rivolti alle famiglie, soprattutto ai genitori, e agli insegnanti perché mettano in atto strategie e buone pratiche utili a favorire l'autoefficacia e il recupero della serenità perduta.

1.

Capire cos'è l'ansia

Una risorsa o un disturbo?

La storia di Chiara, raccontata nelle prime pagine di questo libro, è simile alla storia di tanti bambini e adolescenti che sperimentano l'ansia, ovvero uno stato emotivo a contenuto spiacevole caratterizzato da timori e preoccupazioni in assenza di un pericolo reale.

L'etimologia della parola «ansia», dal latino *angere* ossia «stringere», comunica molto bene la sensazione di disagio vissuta da chi ne soffre, ovvero la sensazione di costrizione, di imbarazzo e di incertezza sul proprio futuro.

L'ansia è una condizione emotiva molto frequente sia nei bambini che negli adolescenti. In determinati momenti dello sviluppo adattivo del bambino, essa è un'emozione fisiologica, prevedibile e ha carattere transitorio. Pensiamo, per esempio, al primo anno di vita del bambino e alle paure che manifesta per forti rumori, persone estranee oppure oggetti di grandi dimensioni. In epoca prescolare le paure più frequenti riguardano il buio, la possibile separazione dai genitori o il dormire da soli, mentre tra i 6 e i 9 anni può

manifestarsi la paura che accada qualcosa di spiacevole come farsi male o avere degli incidenti. In adolescenza, infine, l'ansia può riguardare soprattutto la performance scolastica e sociale. Infatti, in questa fascia d'età, lo sviluppo cognitivo ormai avanzato determina la prevalenza di paure di natura sociale, come ad esempio il timore di sbagliare o di fare brutta figura e la paura del rifiuto da parte dei coetanei. Sempre in questa fascia d'età, comune è infine l'angoscia relativa alla tematica della morte. La tabella 1 riassume le ansie «più comuni» nei bambini e negli adolescenti in base alla fascia d'età.

TAB. 1. Quali sono le ansie più comuni in età evolutiva?

Età	Paure
Infanzia 0-12 mesi	Forti rumori, estranei, oggetti di grandi dimensioni
1-3 anni	Buio, separazione dai genitori, dormire da soli
Età scolare	Lesioni, catastrofi naturali
Pre-adolescenza e adolescenza	Performance scolastica, performance sociale, preoccupazione per la propria salute e quella degli altri
Fonte: C. Rockhill e altri, <i>Anxiety Disorders in Children and Adolescents</i> , in «Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care», aprile 2010, 40, 4, pp. 66-99.	

Nel complesso, possiamo quindi affermare che la presenza di un timore o di una preoccupazione nei riguardi di qualcosa non è necessariamente segno di psicopatologia ma, nella maggior parte dei casi, è una condizione normale dello

sviluppo emotivo del bambino. Tuttavia, per poter avere ben chiaro quando i timori e le preoccupazioni fanno parte di una normale fase evolutiva e quando, invece, diventano una condizione clinica, può essere utile porre subito l'accento sulla distinzione tra i concetti di ansia e paura.

L'ansia spesso viene confusa con la paura, in quanto entrambe rappresentano delle risposte anticipatorie che il corpo e la mente producono nei confronti di un'emergenza reale o supposta tale. Seppur distintamente, ansia e paura inducono sensazioni corporee accompagnate da un notevole stato di inquietudine e agitazione. In un articolo del 1983 Russell M. Grieger e John D. Boyd definiscono la paura come una reazione di timore verso un evento esterno o una situazione che possono essere oggettivamente pericolosi, oppure oggettivamente inoffensivi ma tipicamente temuti da un bambino di una data età e con un dato sviluppo cognitivo. In quest'ottica quindi, il timore del buio di un bambino di 2 anni può definirsi semplicemente una paura prevedibile in base all'età e allo sviluppo del bambino. L'ansia invece è un'eccessiva reazione apprensiva alle possibili conseguenze di un evento e non all'evento di per sé. Quindi l'accento va posto sulla parola «conseguenze». Per esempio, un adolescente in ansia per l'esame di maturità teme le conseguenze di un eventuale fallimento come, ad esempio, ripetere l'anno scolastico, non poter accedere all'università o, addirittura, non poter entrare nel mondo del lavoro. La temuta conseguenza negativa porta con sé l'ansia, uno stato emotivo molto intenso e spiacevole.

Nella tabella 2 riassumiamo le principali analogie e differenze tra paura e ansia così come le hanno proposte gli psicologi Stanley Rachman (nel libro del 2004 *Anxiety*) e Moshe Zeidner e Gerald Matthews (nel libro *Anxiety 101* pubblicato nel 2010).

Nel complesso, dunque, la paura insorge quando una minaccia specifica è reale e sta per accadere in maniera imminente. Uno stato ansioso, invece, si manifesta a causa di un pericolo non oggettivo, e in questo caso, a differenza della paura, la minaccia percepita è irragionevole a fronte di input aspecifici e non concretamente identificabili. Si può affermare che un soggetto ansioso valuti una situazione allarmante come veritiera, ma essa in realtà ha minime probabilità di verificarsi, essendo solamente un'aspettativa mentale o un'immaginazione.

TAB. 2. Quali sono le principali analogie e differenze tra paura e ansia?

	Paura	Ansia
Presenza di anticipazione del pericolo o del disagio	Sì	Sì
Apprensione e inquietudine	Sì	Sì
Eccitamento elevato	Sì	Sì
Affetto negativo	Sì	Sì
Presenza di sensazioni corporee spiacevoli	Sì	Sì

	Paura	Ansia
La minaccia è presente e identificabile	Sì	No
È evocata da stimoli specifici	Sì	No
La connessione con la minaccia è ragionevole	Sì	No
Di solito è episodica (esordio e fine specifici)	Sì	No
Ha le caratteristiche generali di un'emergenza	Sì	No
Ha le caratteristiche generali di vigilanza sostenuta	No	Sì
Fonte: J. Ledoux, <i>Ansia. Come il cervello ci aiuta a capirla</i> , Milano, Raffaello Cortina, 2016.		

La distinzione tra ansia e paura risulta tuttavia non sempre applicabile nel caso di bambini e di adolescenti in quanto, a causa del loro sviluppo cognitivo ancora in divenire, fanno fatica a distinguere il reale dall'immaginario. Devono essere quindi anche altri i criteri da seguire per riuscire a discriminare efficacemente tra le normali paure del bambino e dell'adolescente e l'ansia patologica. Nel prossimo paragrafo vedremo nel dettaglio questi criteri.

Quando l'ansia diventa patologica

L'ansia è ritenuta «normale» se svolge una funzione adattiva: ciò significa che in certe condizioni e con certe caratteristiche l'ansia è funzionale alla sopravvivenza e all'adattamento all'ambiente. Infatti, in situazioni di percepito allarme, l'ansia consente a ciascuno di noi di rispondere attraverso l'attivazione di un sistema fisiologico

preposto al mantenimento dell'attenzione. Facciamo un esempio pratico.

Proviamo a immaginare un adolescente che non abbia il minimo timore di essere respinto a scuola né la minima preoccupazione rispetto a interrogazioni orali e compiti in classe. Probabilmente non passerà molto tempo sui libri, preferendo dedicarsi ad attività più piacevoli. Il risultato? Interrogazioni e compiti andati male e bocciatura più vicina. Un po' d'ansia, invece, nel sostenere i compiti scritti e le interrogazioni orali e di non fare brutta figura potrebbe facilitare una migliore preparazione, aumentando quindi le probabilità di successo e di buon profitto. Ecco cosa si intende quando si dice che livelli d'ansia moderati non sono affatto dannosi, ma svolgono una funzione adattiva.

Immaginiamo ora un'altra situazione. Il nostro adolescente, invece di avere solo un po' d'ansia, è paralizzato dalla paura di non farcela, di non sapere abbastanza, di essere mal giudicato dai docenti e dai compagni. Tutto ciò interferisce negativamente con la sua preparazione e la sua performance scolastica. Ecco che l'ansia, così espressa, ha una funzione disadattiva. Questa è la prima differenza fra ansia normale e patologica: quella normale è adattiva, quella patologica è disadattiva.

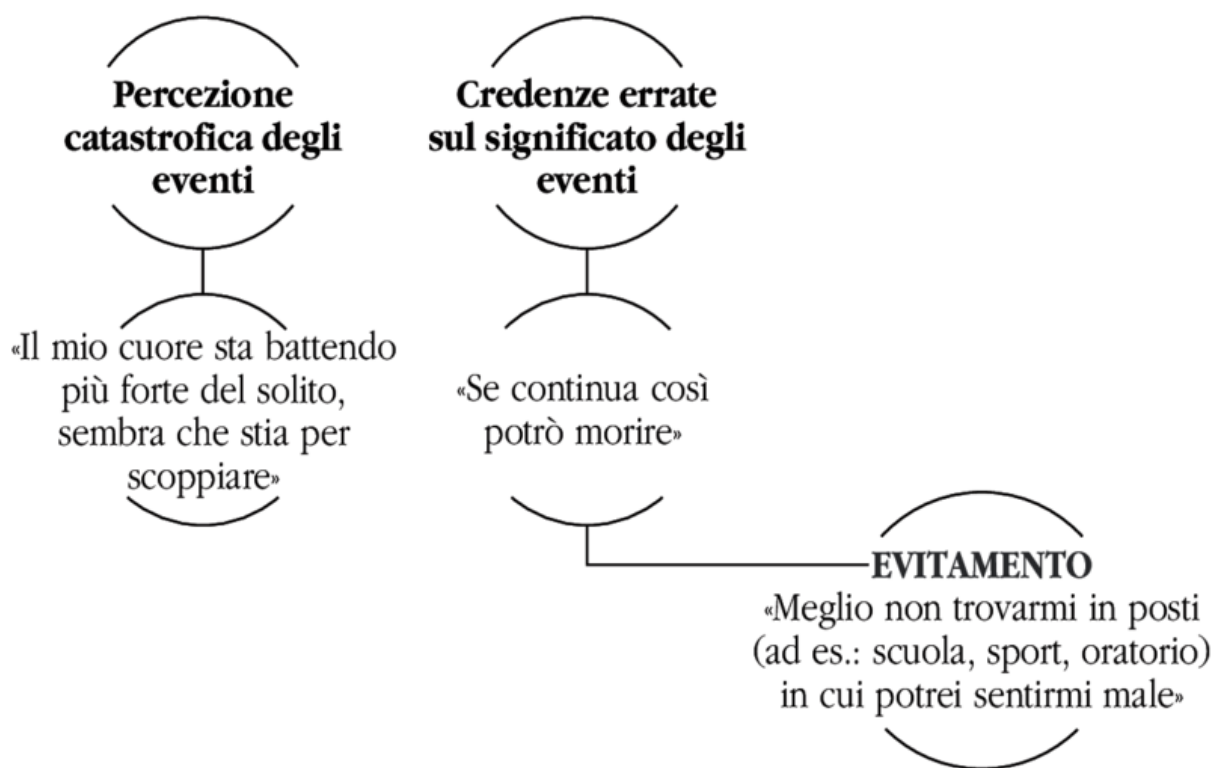


FIG. 1. Il circolo vizioso dell'ansia patologica.

Ma, nello specifico, quando si può parlare di Disturbo d'ansia e non di semplice disagio legato all'età?

Non si tratta solamente di un disagio legato all'età se si verificano alcune condizioni: una data paura persiste oltre l'età fino alla quale è considerata fisiologica (*criterio cronologico*) ed è molto intensa, dura a lungo e si manifesta con molta frequenza (*criterio temporale*). Altra condizione è quella per cui in virtù della paura stessa il bambino evita una serie di situazioni in cui potrebbe sperimentarla, compromettendo in modo significativo il proprio funzionamento sociale, scolastico e familiare (*criterio comportamentale*).

La figura 1 schematizza il circolo vizioso di rappresentazioni catastrofiche, credenze errate, stati emotivi negativi e comportamenti conseguenti che denotano l'ansia «patologica». Per esempio, un bambino o un adolescente ansioso potrebbe, in corrispondenza di un'accelerazione del proprio battito cardiaco, cominciare a pensare che si tratti del chiaro segnale di una malattia grave o, addirittura, della propria morte imminente. Può, perciò, arrivare a evitare quotidianamente una serie di situazioni come, ad esempio, le partite di calcio con gli amici, l'oratorio o i luoghi affollati perché teme di sperimentare la stessa sensazione, con la conseguente forte limitazione della propria vita sociale. In casi come questi sussistono dunque tutti i criteri per poter parlare di un Disturbo d'ansia.

La tabella 3 riporta alcuni esempi tipici dell'età evolutiva che pongono a confronto gli stati ansiosi considerati normali e ricorrenti nella quotidianità e le forme patologiche.

TAB. 3. Alcuni esempi di comportamenti legati all'ansia adattiva e a quella patologica

Ansia normale e adattiva	Ansia patologica
Preoccupazione da parte del bambino di rimanere a casa da solo o distante dalle figure di riferimento.	Rifiuto persistente e ostinato di separarsi dalle figure di riferimento, con sintomi somatici (ad es.: cefalea, nausea) che precedono l'eventuale separazione e rinuncia a quasi tutte le attività che prevedono l'assenza delle figure di riferimento.

Ansia normale e adattiva	Ansia patologica
Timidezza e imbarazzo nel relazionarsi con i propri coetanei all'interno di un contesto sociale.	Evitamento che persiste nel tempo di situazioni e interazioni sociali a causa della paura di essere giudicati negativamente, rifiutati e umiliati dal contesto circostante.
Tremori, tachicardia, sudorazione, preoccupazione nei momenti antecedenti a un compito in classe, un'interrogazione o una performance che richiede di parlare in pubblico.	Rifiuto netto di presentarsi a scuola il giorno dell'esame, lamentele somatiche prima di una verifica con la conseguente richiesta rivolta all'insegnante di poter tornare a casa. Abbandono scolastico.

Riassumendo quanto detto finora, l'ansia ha una rilevanza clinica e può essere considerata un disturbo sulla base dei parametri di frequenza, intensità, durata e compromissione del funzionamento associato. L'ansia è patologica quando si manifesta con una reazione eccessivamente apprensiva nei confronti di un evento esterno o di una situazione che non sono oggettivamente pericolosi (anche se a volte potrebbero potenzialmente esserlo). Tale reazione non risulta adeguata alla fase evolutiva del bambino. Per rendere ancora più chiaro quanto detto finora, nella tabella 4 vediamo alcune esemplificazioni delle differenze tra paura, ansia adattiva e ansia patologica.

TAB. 4. Alcuni esempi di paura, ansia adattiva e ansia patologica

	Esemplificazioni
--	------------------

	Esemplificazioni
Paura	Eleonora, 3 anni e mezzo, non si separa facilmente dai genitori al momento dell'ingresso a scuola. Teme di non rivederli all'uscita. Rassicurata e incoraggiata da genitori e insegnanti accetta l'ingresso mattutino e frequenta con regolarità la scuola. La paura di Eleonora si manifesta limitatamente ai primi mesi di scuola ed è prevedibile viste l'età e la fase di sviluppo.
Ansia normale e adattiva	Luca, 11 anni, ogni volta che ha una verifica a scuola prova un senso di agitazione, il cuore batte forte, le mani sudano. Appena inizia il compito tuttavia riesce a concentrarsi e il senso di agitazione tende a diminuire. Luca ha un profitto buono in tutte le materie, l'agitazione è di breve durata e non penalizza la sua performance scolastica.
Ansia patologica	Claudia, 15 anni, è in procinto di abbandonare la scuola. Ha deciso di lasciarla perché ogni mattina il pensiero di andare a scuola innesca stati d'ansia molto intensi che si manifestano con sintomi somatici quali nausea, cefalea e tremori. Il timore è quello di sbagliare, fare una brutta figura ed essere derisa. Gli stati d'ansia si manifestano da circa un anno tutti i giorni. Lo scorso anno Claudia è stata bocciata.

Ansia, paura e sistema nervoso

Seppur con analogie e differenze, paura e ansia sono due emozioni correlate, in quanto entrambe derivano da circuiti cerebrali che individuano (e rispondono a) minacce che pongono a rischio il benessere psicofisico della persona. Da ansia e paura inoltre scaturisce la risposta dell'organismo al pericolo presente o futuro, reale o immaginario, mediante un'azione di lotta o fuga.

Il fisiologo statunitense Walter B. Cannon ha definito «reazione di emergenza» la risposta attraverso la quale il sistema nervoso autonomo controlla la fisiologia del corpo in circostanze difficili come quelle rappresentate da minacce o da altri fattori di stress. Il sistema nervoso autonomo regola le funzioni organiche «autonome» nel senso di indipendenti dalla nostra volontà (come ad esempio le pulsazioni cardiache), e ha due componenti: il sistema simpatico e quello parasimpatico. Entrambi inviano fibre nervose ai vari tessuti e organi del corpo regolandone il funzionamento e svolgono funzioni diverse. Il sistema simpatico prende il controllo in situazioni che richiedono la mobilitazione di energia, per esempio quando è in pericolo la vita o il benessere, mentre il parasimpatico si contrappone alla risposta del simpatico e ristabilisce nel corpo l'equilibrio (detto anche *omeostasi*) quando il pericolo è passato. Il sistema simpatico contribuisce, dunque, all'incremento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, della sudorazione e della dilatazione delle pupille. L'attivazione del sistema parasimpatico, invece, determina sintomi correlati all'ansia a livello gastrointestinale e urinario.

Affinché possa svolgere la propria funzione, il sistema nervoso simpatico libera adrenalina nel circolo sanguigno. L'adrenalina viene rilasciata anche dal sistema endocrino che è costituito da ghiandole situate in tutto il corpo, come ad esempio la tiroide, l'ipofisi, i testicoli, le ovaie e le ghiandole surrenali. Ognuna di esse produce particolari sostanze chimiche, gli ormoni, che svolgono funzioni differenti e sono

introdotte direttamente nel circolo sanguigno sino a raggiungere gli organi bersaglio della loro azione. Importanti sono le ghiandole surrenali, denominate così perché collocate sui reni; esse si suddividono in due porzioni, una interna midollare e l'altra di copertura esterna e corticale. La prima è attivata in caso di emergenza dal sistema simpatico e genera adrenalina, mentre la seconda produce il cortisolo che, analogamente all'adrenalina, attiva l'organismo e lo predispone all'innalzamento dei livelli di attività fornendogli tensione e ottimizzando la qualità di vita. È stato dimostrato che l'incremento di adrenalina e cortisolo migliora le capacità di attenzione, concentrazione, memoria, apprendimento e *problem solving*. Tale effetto positivo si manifesta solo se i due ormoni sono emessi in tempi e quantità adeguati, poiché in caso di rilascio in quantità eccessive il risultato è l'aumento del livello di tensione e di ansia patologica.

Ma quali sono, nello specifico, le aree del nostro cervello coinvolte nella risposta d'ansia?

I progressi in ambito genetico, psicofisiologico, neurochimico e delle tecniche di *neuroimaging* hanno contribuito alla comprensione delle basi biologiche relative alla paura, all'ansia e ai disturbi associati.

L'ansia, come spiegato precedentemente, emerge mediante manifestazioni sintomatologiche a livello somatico e psichico, e coinvolge differenti circuiti neuronali. Le principali aree neuroanatomiche coinvolte nel «circuitto della paura» e nella modulazione dell'ansia sono il talamo, l'amigdala, la corteccia

prefrontale e l'ippocampo, ognuna delle quali svolge una funzione specifica.

- Il *talamo* è la zona primaria di collegamento tra i sistemi visivi, uditivi, somatosensoriali e le aree della corteccia cerebrale. In questi sistemi sensoriali afferiscono i circuiti neuronali che danno origine all'ansia e alla paura, mentre le aree della corteccia cerebrale sono coinvolte nell'elaborazione dello stimolo ansiogeno. Gran parte delle informazioni correlate agli stimoli che causano ansia e paura è in un primo momento elaborata nella corteccia sensoriale e, in seguito, inviata alle strutture sottocorticali implicate nelle risposte somatiche, affettive e comportamentali.
- L'*amigdala* svolge un ruolo centrale nella modulazione dell'ansia, regola cioè i comportamenti automatici messi in atto a seguito di uno stimolo minaccioso, e interagisce con le strutture corticali e limbiche che determinano la risposta emozionale e involontaria allo stress. Essa riceve gli stimoli non elaborati dal talamo sensoriale, gli conferisce un significato emotivo ed è responsabile della risposta alla paura attraverso alcuni nuclei (nucleo centrale, nucleo amigdaloidale laterale e nucleo basale), e due circuiti: uno breve (*via bassa*), rapido e automatico ma che non prevede l'elaborazione di informazioni relative agli stimoli percepiti, e uno lungo (*via alta*), più lento ma ricco di informazioni. Per poter comprendere al meglio questo passaggio ricorriamo a un esempio. Stiamo camminando nel bosco e vediamo un

serpente tra le foglie. All'istante la nostra sarà una reazione automatica e immediata di allontanamento dal pericolo. Ciò avviene grazie al funzionamento della via bassa. Infatti lo stimolo rappresentato dal serpente, attraverso le vie sensoriali visive, viene recepito dal talamo che subito invia input all'amigdala che attiverà la risposta fisiologica di fuga, per esempio sollecitando l'aumento della frequenza cardiaca cui seguirà l'attivazione muscolare. La contemporanea attivazione della via alta farà sì che lo stimolo visivo del serpente venga inviato alla corteccia visiva che ne elaborerà le caratteristiche e ci renderà coscienti del pericolo, avvalorando così la risposta di fuga emessa (cfr. fig. 2).

- La *corteccia prefrontale mediale* svolge l'importante ruolo di attenuare le risposte indotte dalla paura, inviando dei feedback all'amigdala quando il rischio e il pericolo sono terminati.
- L'*ippocampo*, infine, svolge una funzione importante nella percezione dell'ansia. È stato dimostrato infatti che la parte inferiore (*ventrale*) di questa struttura cerebrale è deputata alla memorizzazione delle componenti emotive di eventi o stimoli recenti e alla loro successiva rievocazione. Nei disturbi d'ansia in particolare, la sua iperattivazione determinerebbe un'«associazione permanente» tra un determinato stimolo o evento e l'emozione di paura e ansia che esso ha innescato nel tempo. In altre parole, se un evento o uno stimolo viene percepito come negativo e

minaccioso, ciò viene «appreso» tramite la parte inferiore dell'ippocampo, per cui qualunque rievocazione dello stesso stimolo o evento determinerà l'attivazione dell'emozione di ansia o paura.

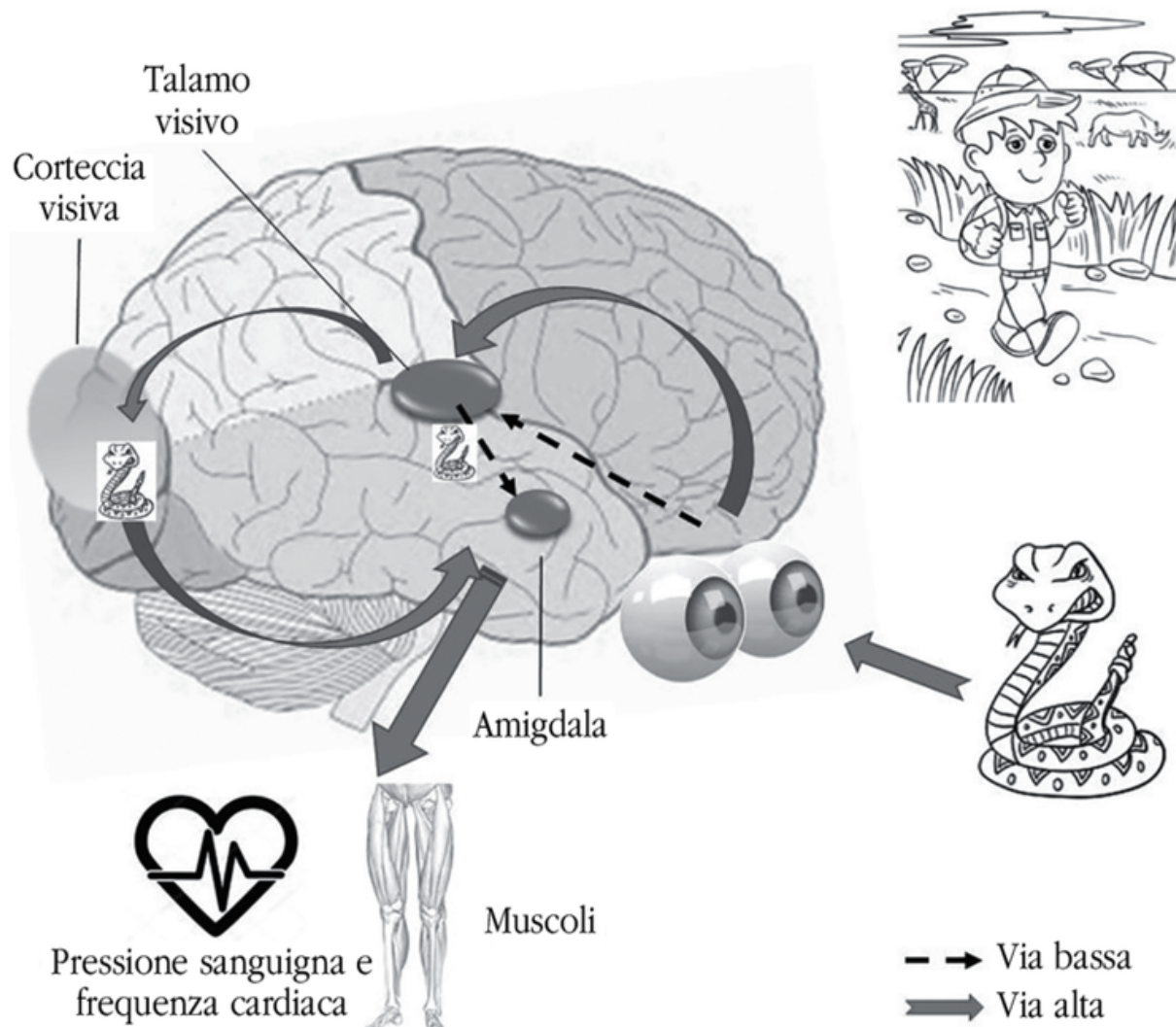


FIG. 2. Il funzionamento della via bassa e della via alta.

Bisogna aggiungere che i comportamenti attuati di fronte alla minaccia percepita dipendono anche da una vasta gamma di variabili come le caratteristiche biologiche, il temperamento e le esperienze passate dell'individuo.

L'interpretazione corticale dello stimolo stressogeno subisce quindi l'influenza del contesto circostante e della valutazione soggettiva attribuita all'evento. In tal caso la risposta emozionale si verifica in corrispondenza del lobo limbico, zona nella quale avviene anche l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), con il conseguente aumento della risposta neurovegetativa. La risposta automatica e involontaria innescata dalle vie del «circuitto della paura» implica il coinvolgimento dei sistemi simpatico e parasimpatico come descritto precedentemente.

Dal punto di vista neurotrasmettitoriale, l'esposizione alla minaccia o a una situazione di stress comporta una diminuzione della funzione inibitoria dell'acido γ -amino butirrico (GABA). Il GABA infatti, in condizioni di benessere, inibisce il rilascio a livello dell'ippocampo e del lobo limbico di quei trasmettitori (noradrenalina e serotonina) implicati, se rilasciati in eccesso, nell'attivazione degli stati ansiosi.

Quali sono i principali disturbi d'ansia in età evolutiva?

Come detto precedentemente, la paura e l'ansia possono raggiungere un'intensità, una frequenza e una durata tali da causare un disagio elevato nel bambino e nell'adolescente limitandone le capacità di vita quotidiana. Quando ciò accade siamo in presenza di un Disturbo d'ansia.

L'etichetta generale di «disturbi d'ansia» e i criteri temporale, cronologico e comportamentale, prodotti proprio

al fine di differenziare le condizioni non adattive e patologiche da quelle normali ed evolutive, sono dettati dal *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali* (DSM) redatto dall'Associazione Americana di Psichiatria. Si tratta di un sistema di classificazione dei problemi mentali costruito sulla base delle evidenze scientifiche e giunto alla quinta edizione (per questo viene citato come DSM-5) dopo un'accurata rivisitazione delle versioni precedenti. L'obiettivo di tale sistema di classificazione è quello di fornire per ciascun disturbo psicopatologico, non solo quindi per i disturbi d'ansia, dei criteri validati dalla ricerca scientifica e condivisibili tra differenti operatori della salute mentale (neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti...). Nello specifico, per quanto riguarda i disturbi d'ansia, il riferimento al DSM-5 deve avvenire tenendo comunque conto del fatto che alcune forme di disturbo d'ansia possono avere un esordio molto precoce, già in epoca prescolare – come il Mutismo selettivo e l'Ansia da separazione – e altre possono avere un esordio più tardivo e inerente all'età scolare – come il Disturbo d'ansia generalizzata, il Disturbo di panico, il Disturbo d'ansia sociale, la Fobia specifica e l'Agorafobia –. Nonostante questa suddivisione, va tenuto conto tuttavia del fatto che forme di Mutismo selettivo e di Disturbo d'ansia da separazione possono manifestarsi, sebbene in maniera più rara, anche all'inizio del primo ciclo di scuola elementare.

Nella tabella 5 elenchiamo i principali disturbi d'ansia in età evolutiva così come proposti dal DSM-5, facendo riferimento

alla distinzione tra forme infantili e forme comuni a bambini e adolescenti. Nella versione precedente del DSM, nota come DMS-IV, erano inclusi tra i disturbi d'ansia anche il Disturbo ossessivo-compulsivo e il Disturbo da stress posttraumatico. Per entrambe queste condizioni cliniche si è ritenuto opportuno creare, nella quinta versione, delle sezioni distinte. Tale decisione ha ragioni cliniche ben precise sostenute dalla letteratura scientifica: innanzitutto l'ansia non è il sintomo principale ed esclusivo né del Disturbo ossessivo-compulsivo né del Disturbo da stress posttraumatico e, soprattutto, per entrambe queste due condizioni i trattamenti psicoterapici non coincidono del tutto con quelli utilizzati per i disturbi d'ansia *tout court* e sono specifici per il quadro clinico, come ad esempio il paradigma di esposizione con prevenzione della risposta per il Disturbo ossessivo-compulsivo e il paradigma cognitivo-comportamentale *trauma-focused* per il Disturbo da stress posttraumatico.

TAB. 5. I principali disturbi d'ansia in età evolutiva

<i>Forme infantili</i>	<i>Forme comuni a bambini e adolescenti</i>
Mutismo selettivo	Fobia specifica
Disturbo d'ansia da separazione	Disturbo di panico
	Disturbo d'ansia generalizzata
	Disturbo d'ansia sociale (Fobia sociale)
	Agorafobia

Un po' di numeri

Alcuni studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti indicano che circa il 25% dei bambini e degli adolescenti soffre di disturbi d'ansia; inoltre, un'indagine condotta da Ronald C. Kessler e colleghi nel 2012 ha evidenziato che a 18 anni il 78% degli adolescenti ha avuto esperienza di un Disturbo d'ansia nel corso della propria vita. La prevalenza è due volte superiore nel sesso femminile rispetto a quello maschile. Nella maggioranza dei casi (circa i due terzi), il disturbo è transitorio, non grave e non causa una significativa alterazione del funzionamento. Tuttavia il 4% degli adolescenti ha un Disturbo d'ansia severo e un altro 4% manifesta sintomi d'intensità moderata con associata compromissione del funzionamento sociale, scolastico o familiare. Per quanto riguarda l'evoluzione e il decorso clinico dei disturbi d'ansia, alcune ricerche evidenziano che un Disturbo d'ansia che insorge in età evolutiva e su cui non si interviene adeguatamente rischia di cronicizzarsi e persistere quindi in età adulta. Infatti, adulti che soffrono di disturbi d'ansia molto spesso riferiscono che l'esordio delle loro difficoltà è avvenuto durante l'infanzia o l'adolescenza: più precisamente, la presenza di Fobia specifica, Ansia sociale, Agorafobia, Disturbo da panico durante l'infanzia o la prima adolescenza rappresenterebbe un fattore di rischio per l'emergere di ulteriori disturbi psicopatologici quali la depressione, l'abuso di alcol e altre sostanze, il suicidio in tarda adolescenza o in giovane età adulta.

I neuropsichiatri infantili Gabriele Masi e Letizia Favilla insieme ad alcuni collaboratori hanno messo in luce come un

terzo degli ansiosi sia a rischio di presentare, in fasi di vita successive, un Disturbo depressivo; la relazione tuttavia è anche inversa, nel senso che due terzi delle persone con Disturbo depressivo sarebbero a rischio di manifestare un Disturbo d'ansia.

Una ricerca epidemiologica condotta dall'équipe di Alessandra Frigerio nel 2009 su un campione esteso di 3.418 preadolescenti di età compresa tra i 10 e i 14 anni ha dimostrato che 8 ragazzi su 100 presentano un disturbo psicopatologico. In particolare, i disturbi internalizzanti, come l'ansia e la depressione, sarebbero presenti nel 6,5% della popolazione esaminata, facendo registrare dunque una prevalenza più alta rispetto ai disturbi esternalizzanti come quelli della condotta e il Disturbo oppositivo provocatorio, che interessano invece l'1,2% della popolazione. Infine, a soffrire di disturbi d'ansia sarebbero soprattutto le femmine. Tuttavia gran parte dei bambini e degli adolescenti presenta altri disturbi associati all'ansia. Particolarmente elevata risulta essere l'associazione tra i differenti disturbi d'ansia (nel 30-40% dei casi): non sono rari infatti i casi in cui il Disturbo d'ansia sociale coesiste nello stesso bambino o adolescente con il Disturbo di panico o quelli in cui il Disturbo ansioso generalizzato coesiste con la Fobia specifica. La stessa ricerca ha sottolineato, inoltre, la frequente associazione tra disturbi d'ansia e disturbi dell'umore (20-30% dei casi).

Un elemento su cui è importante riflettere è il fatto che i disturbi d'ansia spesso si associano ai disturbi

dell'apprendimento. L'ansia è infatti il più frequente sintomo emotivo riportato da ragazzi con dislessia e la presenza di sintomi riconducibili all'ansia scolastica è riscontrabile in circa il 70% dei bambini con difficoltà di apprendimento. Si tratta di bambini che vivono con ansia tanto i compiti scolastici quanto il giudizio di compagni e insegnanti. Consapevoli delle loro difficoltà di apprendimento questi bambini avvertono la discrepanza tra le richieste della scuola e le loro risorse; da qui l'ansia si manifesta inizialmente in relazione a compiti e verifiche scolastiche con attenuazione durante i periodi di vacanza o di minore carico scolastico. Però, se non opportunamente trattati, questi stati d'ansia rischiano di divenire pervasivi fino a diventare dei veri e propri disturbi.

TAB. 6. La prevalenza dei disturbi d'ansia su un campione di 3.418 bambini e adolescenti italiani di età compresa tra i 10 ed i 14 anni

Disturbo da ansia di separazione	2,5-4,5%
Disturbo d'ansia generalizzato	3,5-4%
Disturbo d'ansia sociale	2%
Disturbo di panico	2%

Fonte: A. Frigerio e altri, *Prevalence and Correlates of Mental Disorders among Adolescents in Italy: The PrISMA Study*, in «European Child & Adolescent Psychiatry», 18, 4, aprile 2009, pp. 217-226.

2.

Quanti tipi di ansia e a quali età?

Quali sono i segni dell'ansia?

Il modo in cui i disturbi d'ansia si manifestano in età evolutiva è legato all'età e al particolare livello di sviluppo. Per esempio, come abbiamo già avuto modo di accennare, durante l'infanzia tendono a essere più frequenti sintomi somatici come mal di pancia o mal di stomaco e mal di testa. Possono poi manifestarsi forti preoccupazioni circa la propria sicurezza e soprattutto quella dei propri cari, la richiesta di dormire con i genitori, frequenti incubi notturni, difficoltà di concentrazione sia a scuola che nello sport e una difficoltà a prendere decisioni con costante richiesta di rassicurazione da parte dei genitori. In adolescenza, invece, possono manifestarsi un forte rifiuto a frequentare regolarmente la scuola, nervosismo e preoccupazione quando si è fuori casa, difficoltà nel parlare o nell'incontrare persone nuove, preoccupazione eccessiva per alcune situazioni specifiche prima ancora che accadano, ad esempio, viaggi, cambi di scuola e in generale cambiamenti nella routine quotidiana, difficoltà nel parlare durante le interrogazioni a scuola e/o davanti ai coetanei, bisogno eccessivo di rassicurazioni circa

le proprie capacità e alterazioni del ritmo sonno-veglia. Da non sottovalutare infine la preoccupazione circa la prestazione scolastica: un segnale di ansia che attraversa tutta l'età evolutiva.

TAB. 7. *Le forme del disturbo d'ansia in età evolutiva tipicamente infantili e quelle comuni a bambini e adolescenti*

Disturbi	Sintomi fisiologici	Sintomi comportamentali e cognitivi	Sintomi soggettivi
<i>Tipicamente infantili</i>			
Disturbo d'ansia da separazione	Mal di testa, mal di stomaco, nausea, vomito, tensione muscolare e addominale.	Pianto e panico in seguito alla separazione dalle figure genitoriali, tentativi di fuga da scuola.	Ansia eccessiva, esagerata a seguito di quotidiani allontanamenti dai familiari e dagli ambienti di casa, riluttanza a dormire da soli. Ripetuti incubi notturni legati alla separazione. Preoccupazione che un evento spiacevole possa accadere alle figure di riferimento.

Disturbi	Sintomi fisiologici	Sintomi comportamentali e cognitivi	Sintomi soggettivi
Mutismo selettivo	Rossore in volto.	Costante incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche in cui ci si aspetta che si parli, come ad esempio a scuola, nonostante si sia in grado di parlare in altre situazioni.	Ansia e preoccupazioni eccessive nel parlare in contesti circoscritti.
<i>Comuni a bambini e adolescenti</i>			
Disturbo d'ansia generalizzata	Disturbi del sonno, stanchezza, disturbi gastrointestinali, tensioni muscolari, spasmi e dolori, mal di testa.	Preoccupazione eccessiva riguardo alle proprie capacità, evitamento di luoghi o situazioni considerati pericolosi, percezione del pericolo sproporzionata rispetto alla reale minaccia.	Sentirsi tesi, preoccupati, difficoltà a rilassarsi, concentrarsi, vuoti di memoria.
Disturbo d'ansia sociale	Batticuore, sudorazione, arrossamento, disturbi gastrointestinali, tremore, voce tremante.	Comportamenti e pensieri evitanti, scoppi di collera, immobilizzazione (<i>freezing</i>), aggrappamento (<i>clinging</i>), ritiro sociale.	Sentirsi in imbarazzo, rifiutati o semplicemente osservati, incapacità di parlare davanti ai compagni o durante le interrogazioni, rifiuto di partecipare a eventi sociali come, ad esempio, feste.

Disturbi	Sintomi fisiologici	Sintomi comportamentali e cognitivi	Sintomi soggettivi
Disturbo da attacchi di panico	Fiato corto, sensazione di soffocamento e di svenimento, dolori al petto, disturbi gastrointestinali, vertigini, brividi.	Evitamento di situazioni in cui potrebbe non essere disponibile aiuto in caso di necessità (ad es.: uscire da soli), preoccupazione persistente per l'insorgere di altri attacchi.	Sentire di non avere il controllo, di impazzire o di morire, confusione.
Fobie specifiche	Batticuore, sudorazione, tremore, disturbi gastrointestinali.	Comportamenti di evitamento e fuga di fronte allo stimolo fobico, immobilizzazione (<i>freezing</i>), aggrappamento (<i>clinging</i>).	Spavento e timore di subire danni fisici da parte di oggetti (animali, estranei) o situazioni (altezze, piccoli spazi, buio) specifiche.
Agorafobia	Sintomi simili a quelli dell'attacco di panico.	Evitare di utilizzare trasporti pubblici, di stare in spazi aperti o chiusi, in fila o tra la folla, di trovarsi fuori casa da soli. Pensare di essere impossibilitati a fuggire da tali situazioni e che non potrebbe essere disponibile un soccorso.	Paura o ansia sproporzionata rispetto al reale pericolo posto dalla situazione agorafobica o al contesto socioculturale.

Nella tabella 7 suddividiamo questi sintomi in fisiologici, comportamentali, cognitivi e soggettivi e li elenchiamo così come si manifestano in ciascuno dei differenti disturbi d'ansia in età evolutiva.

I *sintomi fisiologici* sono le manifestazioni «corporee» dell'ansia, risultano da un aumento dell'attività del sistema nervoso autonomo e consistono in: aumento della sudorazione, tensione addominale, rossore in viso ecc. I *sintomi comportamentali* sono solitamente i tentativi che il bambino e l'adolescente attuano al fine di evitare situazioni minacciose o fuggire da esse. I *sintomi cognitivi* fanno riferimento ai pensieri tipici che compaiono nei bambini con un dato disturbo d'ansia e i *sintomi soggettivi* descrivono cosa prova il bambino o l'adolescente ansioso.

Nelle storie che seguono descriveremo, a titolo esemplificativo, i differenti disturbi d'ansia in età evolutiva procedendo per ordine così come proposto dal DSM-5; inizieremo dunque con le forme infantili quali il Disturbo d'ansia da separazione e il Mutismo selettivo per poi procedere con la descrizione delle forme comuni a bambini e adolescenti. Infine, descriveremo la Fobia scolare, una condizione clinica non inclusa nel DSM-5 ma molto frequente e, soprattutto, con un forte impatto negativo sul funzionamento del bambino o dell'adolescente dato che è tra le principali cause di abbandono scolastico.

La storia di Greta: il Disturbo d'ansia da separazione

Greta ha 7 anni e ha una sorella maggiore di 15 anni. Nata da parto eutocico, dopo una gravidanza decorsa regolarmente, la bambina presenta fin dalla nascita buone condizioni di salute. Sin da piccola Greta ha un sonno irregolare

caratterizzato da frequenti risvegli notturni. Per questo motivo i genitori decidono di fare dormire Greta con loro e non in camera con la sorella. Questo ha fatto sì che Greta non si abituasse a riposare da sola nel proprio letto e, al momento della valutazione, dorme ancora con i genitori (*co-sleeping*). Prima di addormentarsi chiede che le si tenga la mano e le si raccontino delle favole. Dal punto di vista relazionale, Greta non riesce a socializzare e a distaccarsi dai familiari. Ad esempio, alle feste di compleanno o al parco giochi, si dimostra poco collaborativa con i coetanei e ricerca ripetutamente la vicinanza materna, rinunciando al divertimento tipico della sua età.

Quando arriva alla nostra attenzione frequenta la seconda classe della primaria e negli ultimi mesi si è rifiutata di andare a scuola, proprio come era accaduto l'anno precedente per un periodo di due mesi. Greta, prima di recarsi a scuola appare tesa, riferisce di provare nausea e questa sensazione aumenta al pensiero di ritrovarsi da sola senza i suoi genitori. Proprio per questo supplica i genitori di non andare al lavoro e di non lasciarla a casa con persone che non siano familiari. A ciò si aggiunge la paura che i genitori possano morire e lasciarla sola a causa di incidenti e/o malattie.

Tale quadro compromette il funzionamento di Greta non solo a livello familiare e scolastico ma anche a livello sociale: non pratica attività extrascolastiche e non ha amici.

Come si può evincere dalla storia di Greta, il quadro clinico descritto sembra soddisfare i criteri per un Disturbo d'ansia

da separazione.

Questo disturbo insorge di solito precocemente, intorno ai 6 o 7 anni con una prevalenza del 2,5-4,5%, e si caratterizza per il forte disagio che il bambino prova quando prevede e sperimenta la possibilità di allontanarsi dai genitori e dal contesto in cui vive, anche per un breve lasso di tempo. Questa preoccupazione è associata al pensiero che un accadimento spiacevole come un incidente, una malattia o una catastrofe causi al bambino stesso e ai suoi familiari qualcosa di grave sino alla conseguente perdita o separazione da essi. Il disagio è pervasivo e tale da non permettere al bambino di stare a casa da solo; i più grandi d'età talvolta esprimono riluttanza nell'uscire autonomamente, si rifiutano di andare a scuola o in altri luoghi senza le figure di riferimento. A scuola, a volte lamentano di stare male e chiedono agli insegnanti di chiamare uno dei genitori. Le attività di gioco sono spesso interrotte per controllare la vicinanza di chi sta loro accanto. I bambini e gli adolescenti, inoltre, non vogliono dormire né da soli nella propria abitazione né altrove, soprattutto nel caso in cui abbiano incubi ricorrenti, legati al tema della separazione. Durante la fase di addormentamento insistono affinché le persone care stiano loro a fianco, spesso si svegliano nel cuore della notte per raggiungere il letto dei genitori o di uno dei fratelli. Di sera, i bambini più piccoli possono riferire percezioni insolite, come la sensazione che nella stanza siano presenti persone estranee o creature bizzarre che li osservano.

Il Disturbo d'ansia da separazione è più frequente nelle bambine. Le manifestazioni variano con l'età, l'esordio può risalire all'età prescolare ed è molto meno frequente in epoca adolescenziale, sebbene l'evitamento di alcune situazioni (allontanamento dal nucleo familiare, trasferimenti per studio/lavoro) possa verificarsi anche in età adulta.

La storia di Elisa: il Mutismo selettivo

Elisa ha 5 anni. È nata da parto eutocico, dopo una gravidanza decorsa regolarmente; le tappe dello sviluppo psicomotorio risultano nella norma. La bambina frequenta l'ultimo anno di scuola dell'infanzia e vive il contesto scolastico con difficoltà perché non parla – nessuno ha mai sentito la sua voce – e manifesta timidezza nel rapporto con i compagni. Durante il primo anno di scuola materna si è trovata da subito a disagio e le numerose crisi di pianto inconsolabili hanno indotto la madre a ritirarla da scuola.

Elisa ha iniziato a integrarsi maggiormente nel gruppo classe solo a metà del secondo anno, facendo emergere la sua passione e bravura per le attività di disegno. Un miglioramento si è potuto rilevare anche dal punto di vista relazionale: a livello non verbale interagisce adeguatamente con gli altri bambini della classe, mantiene il contatto oculare con essi e collabora nel gioco.

Nonostante questi progressi, Elisa non riesce comunque a parlare con gli insegnanti e i compagni, e gli insegnanti sono particolarmente preoccupati per il passaggio alla scuola

primaria. Al fine di fronteggiare il problema viene interpellata la pedagoga della scuola che si occupa di prendere contatto con una psicologa. La madre, consapevole delle difficoltà della figlia, si dimostra collaborativa facendo partecipare la bambina ai colloqui, durante i quali non si evidenziano problemi di linguaggio. A tal proposito la madre riferisce che la bambina a casa comunica normalmente e non ha alcuna difficoltà nell'esprimere i propri bisogni.

Il caso di Elisa è riconducibile al Mutismo selettivo data la sua incapacità di parlare nel circoscritto contesto scolastico.

Il Mutismo selettivo, infatti, esordisce di solito in una età compresa tra i 2 e i 4 anni e comporta una costante incapacità dei bambini di dialogare in una (o anche più di una) situazione sociale, sebbene essi siano in grado di parlare in altri ambienti. In momenti specifici arrestano la comunicazione e nella relazione non interagiscono verbalmente, negando ogni possibilità di iniziare un discorso. La più frequente e caratteristica situazione in cui il disturbo si manifesta è la scuola; per essere certi che si tratti di Mutismo selettivo, è necessario che lo sviluppo del linguaggio sia adeguato all'età e il mutismo non sia dovuto ad altri disturbi psicopatologici. Inoltre, la durata del sintomo deve essere di almeno un mese e non limitata alle prime quattro settimane di scuola, periodo in cui una certa inibizione del linguaggio verbale può essere presente nei bambini timidi ma tende a scomparire dopo la familiarizzazione con il nuovo contesto.

Il bambino con Mutismo selettivo di solito usa il canale comunicativo non verbale per esprimersi, lo fa attraverso la scrittura e il disegno o partecipando ad attività sociali in cui non è primario parlare.

Il disturbo si manifesta in entrambi i sessi con uguale frequenza. L'incapacità di parlare in alcune situazioni, tipica di questa condizione, può derivare dalla paura o dall'ansia indotte da situazioni specifiche (come ad esempio la scuola). Proprio questo fa sì che il Mutismo selettivo sia a tutti gli effetti incluso tra i disturbi d'ansia.

La storia di Michela: la Fobia specifica

Michela è una bambina di 9 anni, secondogenita di tre figli. Nata da parto eutocico, dopo una gravidanza decorsa regolarmente, ha percorso le tappe dello sviluppo psicomotorio in maniera conforme all'età.

Al momento della visita, Michela, che frequenta la quarta elementare, ha un buon rendimento scolastico ed è ben inserita all'interno del gruppo classe.

I genitori richiedono il sostegno di uno psicologo perché Michela assume a casa comportamenti molto diversi da quelli che mette in atto a scuola o in altre situazioni sociali. Fuori casa ha tanti amici, pratica nuoto cavandosela molto bene e in maniera autonoma, il papà infatti la lascia a inizio lezione in piscina e la bambina riesce a tornare a casa da sola. All'interno del contesto familiare, invece, Michela si comporta

in maniera opposta: dipende dai genitori anche per il vestirsi, chiede di essere accompagnata se deve attraversare il corridoio di casa ed è sempre alla costante ricerca di attenzioni.

Michela tende ad agitarsi, soprattutto la sera, prima di addormentarsi: ha una forte paura del buio, non dorme senza la luce accesa, suda, trema e ha bisogno della presenza di uno dei due genitori durante la notte. La sera lamenta di avere pensieri legati al possibile ingresso di ladri nella casa in cui vive. La fobia del buio compromette significativamente il funzionamento della bambina nel contesto familiare soprattutto la sera.

Le manifestazioni sintomatologiche di Michela soddisfano i criteri per la diagnosi di Fobia specifica.

Il disturbo emerge, infatti, come una paura eccessiva e irragionevole verso specifici oggetti o situazioni (si parla di «stimoli fobici», nel caso di Michela il buio e l'addormentarsi da sola al buio).

Gli stimoli fobici possono riferirsi alla categoria «animale», ovvero al terrore di cani, insetti e serpenti; all'«ambiente naturale», vale a dire alla paura per l'acqua, i temporali e le altezze; al «sangue-infezioni-ferite», cioè allo spavento per aghi, iniezioni o procedure mediche. Lo stimolo può essere inoltre «situazionale» e comportare preoccupazione per i luoghi chiusi, gli ascensori e gli aerei o riguardare «altro» come i rumori, il timore dei personaggi in maschera e di ciò

che potrebbe provocare nausea o soffocamento. Di conseguenza il bambino, mediante l'esposizione a tali fattori, manifesta una forte e intensa paura che ha la peculiarità di presentarsi in forma sproporzionata rispetto al pericolo reale.

Il bambino può reagire alla vista o al contatto con lo stimolo fobico mediante scoppi di pianto, rabbia, immobilizzazione (*freezing*), aggrappamento (*clinging*), o evitando attivamente e intenzionalmente il contatto con ciò che teme.

Per poter diagnosticare una Fobia specifica è essenziale che le reazioni di fronte allo stimolo fobico si differenzino da quelle originate da timori transitori e tipici dell'età evolutiva. La paura inoltre può insorgere sia in anticipo sia quando si è esposti direttamente allo stimolo fobico. Si parla di Fobia specifica solo se l'ansia si attiva ogni volta che il bambino o l'adolescente sono a contatto con l'oggetto fobico, e non solo occasionalmente, e se i sintomi persistono per più di sei mesi.

La storia di Marco: il Disturbo d'ansia sociale

Marco, 15 anni, frequenta il primo anno del liceo scientifico con ottimi voti nei compiti scritti e nelle interrogazioni orali. Anche per lui nulla di significativo per quanto riguarda il decorso della gravidanza, il parto e le tappe di sviluppo. Da circa due mesi, però, Marco si rifiuta di andare regolarmente a scuola e, al momento della visita, ha deciso di abbandonarla definitivamente. I genitori non riescono a comprendere il motivo di tale rifiuto. Infatti, il ragazzo ha da sempre un buon profitto scolastico ed è ben integrato nel gruppo classe.

Marco pratica calcio da anni e in ambito sportivo si è sempre molto impegnato sia durante l'allenamento sia durante le partite. Ultimamente, però, anche in questo contesto appare intimorito dallo scontro diretto con le squadre avversarie e preferisce non mettersi alla prova. L'allenatore ha informato recentemente i genitori del rifiuto di Marco di giocare da titolare nelle partite del campionato giovanile; il ragazzo avrebbe espresso la paura di esporsi, di poter essere causa dell'insuccesso della propria squadra e di essere giudicato male e deriso dai compagni per questo motivo.

A scuola Marco sente lo stomaco chiudersi, la testa scoppiare, ha bisogno di alzarsi e andare via. Anche in questo contesto teme di essere preso in giro, ridicolizzato e, infine, escluso dal gruppo.

La storia di Marco fa pensare al Disturbo d'ansia sociale.

Il Disturbo d'ansia sociale, denominato anche «Fobia sociale», ha un esordio tra i 6 e i 12 anni. I ragazzi con Disturbo d'ansia sociale presentano un'intensa e marcata paura per tutte quelle situazioni collettive che prevedono il doversi relazionare e il dover intrattenere una conversazione con i propri coetanei, con gli adulti e con persone sconosciute. Temono di essere valutati e giudicati negativamente durante un'interazione o lo svolgimento di un'azione o di una prestazione. Le preoccupazioni di questi ragazzi insorgono quando devono parlare in pubblico, partecipare alle attività didattiche proposte in classe, esprimere le proprie opinioni e

recarsi a eventi sociali. Questi bambini e adolescenti hanno inoltre paura di essere rifiutati a causa dei sintomi evidenti correlati alla loro ansia (rossore, tremore, sudorazione, mancanza di respiro, confusione di parole).

La gravità e il tipo di queste paure variano sulla base delle differenti occasioni a cui sono esposti. Ad esempio, un bambino o un adolescente consapevole del tremolio alle mani tende a non bere, mangiare o scrivere in presenza di qualcuno; quando suda evita di stringere la mano, e, se solitamente arrossisce, preferisce non mettersi in evidenza in pubblico o discutere di argomenti personali. L'evitamento può essere estremo, fino al rifiuto scolastico e dei contesti sociali, oppure limitato, e in questo caso il ragazzo evita il contatto oculare e distoglie l'attenzione da ciò che gli crea ansia. Può essere presente inoltre una sensazione di ansia anticipatoria per un evento futuro (un'uscita con gli amici, una recita scolastica ecc.) con preoccupazioni sproporzionate e intense che riguardano il timore di essere giudicati negativamente nel corso della situazione prospettata.

Nei bambini la paura di confrontarsi con gli altri in situazioni pubbliche come la scuola e/o il contesto sportivo è espressa con pianti, rabbia, immobilizzazione o aggrappamento alle figure di riferimento. Gli adolescenti, invece, tendono a manifestare il rifiuto netto a partecipare alle situazioni sociali e, se costretti, tendono a isolarsi e a evitare la relazione con l'altro. Solitamente questi bambini e adolescenti tollerano le situazioni sociali solo in presenza di

figure a loro familiari, come un genitore, un insegnante considerato punto di riferimento o un amico.

Perché si possa diagnosticare un vero e proprio Disturbo d'ansia sociale, l'ansia, la paura o l'evitamento devono persistere per sei mesi o più e causare un grave disagio che compromette significativamente il funzionamento del ragazzo, in particolar modo le relazioni sociali, le attività scolastiche ed extrascolastiche.

Alla base di un Disturbo d'ansia sociale possono esservi traumi specifici, come ad esempio un cambio di casa, il trasferimento in un'altra città o in un'altra scuola, tensioni con gli insegnanti e i compagni, malattie con assenze prolungate ed episodi di bullismo.

La storia di Claudio: il Disturbo di panico

Claudio è un ragazzo di 15 anni e frequenta il secondo anno del liceo scientifico. Gli insegnanti contattano i genitori perché nell'ultimo mese il rendimento scolastico è peggiorato con un marcato calo della performance.

Sin dalla nascita, Claudio ha presentato buone condizioni di salute. I genitori raccontano tuttavia di incubi notturni abbastanza frequenti nel periodo tra i 4 e i 6 anni. Inoltre, all'inizio della scuola elementare è stato difficile per lui affrontare la separazione dai genitori, tanto che la mattina, prima dell'ingresso in classe, lamentava mal di testa e dolori addominali accompagnati da crisi di pianto. Al momento

della visita, Claudio e i genitori raccontano di uno stato di agitazione che si manifesta in maniera improvvisa con la comparsa di sintomi fisici come tremori, palpitazioni e sudorazione che raggiungono la massima intensità nel giro di pochi minuti; in quei momenti Claudio riferisce la costante paura di perdere il controllo di sé stesso. Questi stati di agitazione sono presenti tutti i giorni e possono essere definiti attacchi di panico. Claudio è costretto a vivere la propria quotidianità con la costante paura che essi si manifestino. Di conseguenza, il ragazzo limita le sue relazioni sociali, spesso rifiuta la scuola e ha abbandonato l'attività sportiva per paura che gli attacchi si ripresentino nel corso di competizioni.

Il Disturbo di panico consiste nella comparsa di attacchi caratterizzati da un'improvvisa e inaspettata paura intensa in assenza di un pericolo reale. Solitamente si tratta di episodi brevi dal punto di vista temporale ma percepiti come molto intensi da chi li sperimenta.

I sintomi possono essere di tipo fisico – come palpitazioni, sudorazione, tremori, sensazione di soffocamento o svenimento, dolori al petto, brividi, formicolii in varie parti del corpo (*parestesie*), vertigini, vampate di calore – ed essere associati a sintomi psicologici e/o cognitivi – come derealizzazione (percezione di irrealtà), depersonalizzazione (sensazione di essere distaccati dal proprio corpo o di essere un osservatore esterno dei propri processi mentali), paura di perdere il controllo e senso di morte imminente.

L'attacco di panico può insorgere in qualsiasi momento, in assenza di un fattore scatenante e con frequenza, durata e intensità variabili (quotidianamente, una volta a settimana, ogni due mesi). Si parla di Disturbo di panico quando a seguito del primo attacco se ne ripresentano altri in modo ricorrente, inaspettato e con una gravità ritenuta completa, vale a dire con la manifestazione di quattro o più dei sintomi elencati.

Il Disturbo di panico insorge solitamente nel periodo adolescenziale, ha un decorso cronico e la maggior parte delle volte è associato a un altro Disturbo d'ansia o a un Disturbo dell'umore. Si tratta di una condizione che limita notevolmente il funzionamento dei bambini e degli adolescenti che ne soffrono. Infatti, il timore che l'attacco di panico sopraggiunga da un momento all'altro li induce a limitare notevolmente la propria vita relazionale e, in alcuni casi più gravi, a rifiutare in maniera decisa la frequenza scolastica.

La storia di Matteo: l'Agorafobia

Matteo, 12 anni, manifesta un'ansia intensa ogni volta che si trova in spazi aperti o in luoghi affollati dai quali pensa non sia possibile allontanarsi rapidamente né avere vie di fuga. Le piazze o i concerti lo spaventano perché teme di non poter fuggire né ricevere soccorso nel caso si verifichi un avvenimento spiacevole (malessere, attentati). La paura compromette la sua autonomia a tal punto da richiedere alla

madre di accompagnarlo non solo a scuola ma anche in altri luoghi, come ad esempio i centri sportivi. Matteo evita di prendere i mezzi pubblici da solo perché quando si trova in spazi chiusi prova una sensazione di soffocamento, si agita e inizia a tremare; motivo per cui preferisce frequentare determinate zone in orari non affollati.

La storia di Matteo fa pensare a una condizione nota come Agorafobia.

L'Agorafobia può essere definita come la paura o l'ansia marcata verso almeno due delle seguenti cinque situazioni: utilizzo dei trasporti pubblici; trovarsi in spazi aperti; trovarsi in spazi chiusi; stare in fila o tra la folla; essere fuori casa da soli. Chi soffre di Agorafobia è convinto che in queste circostanze possa accadere un evento terribile dal quale non riuscirebbe a fuggire. Siamo cioè in presenza di una percezione sproporzionata del pericolo rispetto alla realtà dei fatti, accompagnata dalla paura che non vi sia la possibilità di richiedere soccorso in caso di necessità.

Le situazioni agorafobiche sono, quindi, temute ed evitate attivamente perché causano la manifestazione di sintomi invalidanti simili a quelli dell'attacco di panico che abbiamo descritto precedentemente. Il picco d'insorgenza si sviluppa nel periodo della tarda adolescenza e il genere femminile è doppiamente soggetto ad Agorafobia rispetto a quello maschile. Nei casi più gravi, l'Agorafobia costringe a rimanere chiusi in casa e a dipendere dagli altri per svolgere le attività di ogni giorno.

La storia di Marta: il Disturbo d'ansia generalizzata

Marta è una ragazza di 15 anni da sempre in buone condizioni di salute.

La gravidanza, il parto e lo sviluppo psicomotorio hanno avuto un decorso regolare.

Marta ci racconta di sentirsi da circa un anno costantemente preoccupata, di non riuscire mai a rilassarsi, di provare nausea e tensione prima di recarsi a scuola o quando deve affrontare le gare di atletica. I genitori ci dicono inoltre che la ragazza chiede continue rassicurazioni perché teme di non comportarsi in maniera corretta, di non riuscire a completare gli studi o che possa capitare ai genitori un evento spiacevole (un incidente o la perdita del lavoro). Questo disagio compromette significativamente il funzionamento di Marta: a scuola non riesce a concentrarsi e a essere lucida durante i compiti in classe e le interrogazioni; non frequenta più atletica; quando esce con gli amici chiede spesso di essere riaccompagnata a casa per il manifestarsi della sintomatologia ansiosa.

La storia di Marta fa pensare al Disturbo d'ansia generalizzata.

Il Disturbo d'ansia generalizzata si caratterizza per timori e preoccupazioni difficili da gestire e controllare, relativi a una quantità di accadimenti e situazioni quotidiane.

Le paure espresse più frequentemente fanno riferimento alle catastrofi naturali, alle relazioni sociali e alle prestazioni

o performance riguardanti l'ambito scolastico e/o sportivo. I bambini e gli adolescenti che presentano ansia generalizzata, il più delle volte si prefiggono di ottenere risultati elevati e sono eccessivamente critici verso sé stessi qualora non riescano a raggiungerli. Essi tendono al perfezionismo e ad aderire alle regole, motivo per cui si distanziano dall'opportunità di cimentarsi in nuove attività se non sono certi di poter conseguire gli standard prestabiliti.

I bambini e gli adolescenti con questo disturbo tendono ad assumersi il peso di situazioni non conformi alla loro età, ricercano continuamente rassicurazioni, accertandosi di mantenere la situazione sotto controllo. Ad esempio, chiamano i familiari più volte nell'arco della giornata per assicurarsi del loro stato di salute, richiedono una costante approvazione e l'assistenza durante i compiti al fine di eseguirli correttamente. Il disturbo compromette il funzionamento familiare, sociale e scolastico e per poter essere diagnosticato deve essere presente da almeno sei mesi.

E infine, la Fobia scolare: la storia di Alessandro

Alessandro ha 9 anni e frequenta la quarta elementare. Nella sua storia clinica non sono presenti malattie di rilievo. La gravidanza, il parto e lo sviluppo psicomotorio hanno avuto un decorso regolare. I genitori, però, ci raccontano che Marco è molto angosciato al pensiero della scuola. Il bambino dice di sentirsi incapace, di avere sempre paura di sbagliare e

di prendere brutti voti e, conseguentemente, di fare brutta figura davanti ai compagni.

Alessandro ha questi pensieri negativi sin dalla sera prima, insieme ad alcune manifestazioni fisiche come dolori addominali, nausea, cefalea e disturbi del sonno che lo inducono a chiedere ai genitori di poter stare a casa o di non entrare in classe. Il bambino lamenta spesso di annoiarsi durante le lezioni e trova le richieste scolastiche eccessive per quanto riguarda la mole di compiti assegnati.

Tali manifestazioni sono circoscritte al contesto scolastico; Alessandro infatti affronta serenamente altre situazioni come quelle sportive (pratica basket) o relazionali come il gruppo scout.

Inoltre, nei periodi di vacanza dalla scuola tali sintomi scompaiono del tutto e il bambino riesce ad affrontare ancora più serenamente le attività quotidiane.

La storia di Alessandro fa pensare a una Fobia scolare.

La Fobia scolare può presentarsi in concomitanza ai passaggi di ciclo scolastico: agli inizi della scuola primaria (tra i 5 e i 7 anni), della scuola secondaria di primo grado (tra i 10 e gli 11 anni) e della scuola secondaria di secondo grado (tra i 13 e i 14 anni).

Questa fobia è principalmente legata alla prestazione scolastica e comporta un'elevata paura di sbagliare, una bassa autostima, il timore di ricevere voti negativi, di non farcela, di

deludere le aspettative dei genitori e degli insegnanti e la sensazione di fare una brutta figura davanti ai compagni. Tra i sintomi citiamo tachicardia, tremori, blocco mentale e crisi prima di entrare in classe. Tali aspetti influiscono sul rendimento scolastico con una perdita d'interesse nello studio e nella relazione con l'altro. Questi bambini e adolescenti si sentono infatti ansiosi, agitati e non tollerano le frustrazioni, reagendo spesso in maniera aggressiva.

Dove nasce l'ansia?

Tre tipi di cause

Gli studi scientifici degli ultimi vent'anni sono concordi nell'individuare tre tipi di fattori in grado di contribuire all'insorgenza e al mantenimento dei disturbi d'ansia in età evolutiva. Si tratta in particolare dei fattori genetici e neurobiologici, di quelli ambientali e sociali e, infine, di quelli temperamentali. Essi non devono essere considerati cause dirette del disturbo ma fattori di vulnerabilità, ovvero la loro presenza e, soprattutto, la loro interazione contribuiscono a rendere il bambino maggiormente esposto al rischio di sviluppare il disturbo stesso. Infatti, diversi psicologi, tra i quali ricordiamo Ron Rapee che insegna alla Macquarie University in Australia, sottolineano come l'interazione tra questi tre tipi di fattori sia critica soprattutto in determinati periodi dello sviluppo, che coincidono con l'epoca prenatale, la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza. Nei paragrafi che seguono esamineremo nello specifico i fattori genetici e neurobiologici, quelli ambientali e sociali e quelli temperamentali e ne chiariremo il possibile ruolo nei disturbi d'ansia in età evolutiva.

Fattori genetici e neurobiologici

Alcuni studi hanno evidenziato come i figli di genitori che presentano un Disturbo d'ansia abbiano un rischio almeno sette volte maggiore di presentare anch'essi lo stesso disturbo già in età evolutiva. In modo ancora più incisivo, un'indagine condotta da Gabriele Masi nel 2000 ha evidenziato che un bambino o un adolescente è a rischio di un Disturbo d'ansia anche se il genitore presenta disturbi psicopatologici di altro tipo. In particolare Masi ha rilevato che, all'interno di un campione di 220 bambini e adolescenti con Disturbo d'ansia, 21 di essi presentavano un Disturbo di panico a esordio precoce e il 90% aveva almeno un genitore con un Disturbo d'ansia o un Disturbo dell'umore e oltre il 50% un genitore con Disturbo depressivo in cura con trattamento farmacologico. È importante però sottolineare che altri studi attribuiscono alla componente genetica un peso differente e variabile in base alle tipologie di Disturbo d'ansia. Per esempio una ricerca condotta sui gemelli evidenzierebbe il ruolo significativo della componente genetica solo per i casi di Fobia specifica. Viceversa, per la Fobia sociale e il Disturbo d'ansia da separazione il ruolo della genetica sarebbe meno evidente, mentre sarebbero più incisivi altri fattori, *in primis* quelli ambientali.

Dunque, la base genetica non è l'unica causa dei disturbi d'ansia. Da qui diventa, quindi, interessante guardare anche al ruolo causale di altri fattori, a cominciare da quelli neurobiologici.

Studi condotti sugli animali e sull'uomo hanno evidenziato, infatti, come ai disturbi d'ansia si accompagni una disfunzione dei circuiti neuronali che connettono la corteccia prefrontale e l'amigdala. Questi circuiti svolgono un ruolo importante nell'apprendimento e nel riconoscimento di emozioni quali, ad esempio, la paura. Ebbene, nei pazienti che presentano un'elevata propensione all'ansia, questi circuiti sono alterati e caratterizzati da una maggiore attività dell'amigdala e una minore attivazione della corteccia prefrontale.

Quanto incidono le esperienze vissute e l'ambiente?

Nel corso della seconda metà del Ventesimo secolo, numerosi studi condotti con gemelli omozigoti ed eterozigoti hanno consentito di confermare come le esperienze vissute e l'ambiente abbiano un'enorme influenza sulla comparsa di un Disturbo d'ansia.

Immaginiamo di poter osservare due gemelli omozigoti – Luca e Matteo – dalla nascita alla preadolescenza. La mamma di Luca e Matteo soffre di un Disturbo d'ansia generalizzato mentre il papà non presenta difficoltà di tipo psicopatologico. La gravidanza dei bambini si è svolta senza particolari problematiche, ma al momento del parto si scopre che Luca ha un giro di cordone ombelicale intorno al collo che ne ostacola la nascita. Si decide per un taglio cesareo d'urgenza: Matteo nasce senza alcuna complicazione, mentre Luca, nell'immediato post partum, fatica a respirare e il suo pianto

non è subitaneo. Fortunatamente si tratta di un problema transitorio e sia Luca che Matteo, a poche ore dal parto, sono in buone condizioni di salute.

Lo sviluppo procede senza problemi particolari. Quando i gemelli frequentano la scuola elementare, i genitori, per motivi lavorativi, sono costretti a separarsi e decidono che Luca rimarrà con la mamma mentre Matteo si trasferirà con il papà in un'altra città. La mamma ricopre Luca di mille attenzioni: prima della scuola controlla che nello zaino ci sia tutto il materiale, gli chiede spesso se ha mal di pancia o mal di testa, la notte dormono insieme nel lettone così che possa intervenire subito nel caso Luca abbia qualche necessità. La mamma preferisce accompagnare personalmente Luca in palestra o alle feste degli amici preoccupandosi che non ci siano pericoli per il bambino e che tutto proceda per il meglio.

Matteo, invece, gioca spesso con il papà, insieme vanno al parco dove il bambino ha conosciuto nuovi amici e, se il papà è troppo impegnato con il lavoro, Matteo passa il pomeriggio con la baby-sitter che lo aiuta nei compiti e lo accompagna in palestra. La sera Matteo è sicuro nel suo letto perché sa che se ha bisogno il papà è nell'altra stanza pronto a intervenire.

Nella nuova scuola, inoltre, Matteo ha trovato una maestra che non interroga i bambini a sorpresa e non li sgrida davanti ai compagni se non conoscono bene un argomento. Povero Luca, invece, che nella vecchia scuola deve essere sempre attento e pronto per non subire le prese in giro dei compagni!

A questo punto, chi presenta il più alto rischio di sviluppare un Disturbo d'ansia tra i due bambini? Molto probabilmente è il piccolo Luca, in quanto è esposto a maggiori fattori di rischio tra cui *in primis* lo stile genitoriale materno centrato sull'ipercontrollo e sull'iperprotezione.

Proprio gli stili genitoriali sembrano essere fattori ambientali critici nello sviluppo dell'ansia in età evolutiva. Comportamenti genitoriali ansiosi, iperprotettivi o eccessivamente critici possono contribuire allo sviluppo di ansia patologica nei bambini, nella misura in cui non agevolano la loro autonomia quotidiana.

Uno stile educativo assertivo, invece, prevede che il genitore sia capace di promuovere l'autonomia e la responsabilità del bambino, svolga il ruolo di guida in modo proattivo, sia una presenza attiva nella relazione e stimoli la collaborazione e la partecipazione del proprio figlio alle attività di vita quotidiana. In quest'ottica, Rapee evidenzia che l'avere un genitore che mette in atto comportamenti prevalentemente di tipo ansioso aumenta il rischio che il bambino manifesti un Disturbo d'ansia. In particolare, analizzando i risultati di uno studio condotto nel 2014, la presenza e la reiterazione di comportamenti ansiosi da parte della madre soprattutto nei confronti dei figli in età prescolare sembrerebbero essere predittive della presenza del Disturbo d'ansia sociale e del Disturbo d'ansia generalizzata all'età di 15 anni.

Un ruolo importante nell'eziologia dei disturbi d'ansia in età evolutiva è svolto dall'aver sperimentato durante la

crescita eventi di vita stressanti. Quando parliamo di «eventi di vita stressanti» ci riferiamo, ad esempio, a episodi ripetuti di bullismo o di cyberbullismo da parte del gruppo dei pari, all'avere un genitore con una grave malattia, con problemi interpersonali quali l'isolamento e una chiusura relazionale rigida ed eccessiva, all'appartenenza a una classe sociale svantaggiata, al crescere in una famiglia conflittuale o ancora in condizioni di scarsa protezione, di incuria o di vero maltrattamento fisico.

Secondo Miriam A. Schiele (2018), l'infanzia costituisce una fase di vita in cui la vulnerabilità al disagio psicologico è più alta in quanto il cervello è ancora in via di sviluppo, più sensibile alle esperienze esterne e si modifica sulla base di esse. Quindi, l'esperienza di eventi fortemente traumatici ha effetti duraturi nel tempo sui processi del neurosviluppo. L'essere vittima di maltrattamento in età evolutiva espone a un rischio maggiore per i disturbi d'ansia, in particolare per il Disturbo d'ansia sociale. Le esperienze di abuso fisico o psicologico, l'incuria fisica o emotiva, le esperienze di perdita o separazione e i traumi di natura sessuale sono associati a un rischio di circa 2-4 volte maggiore di sviluppare nel corso della vita un Disturbo da panico, un Disturbo d'ansia sociale o un Disturbo d'ansia generalizzata. Tuttavia, molte persone, seppure esposte a tali avversità, non sviluppano un disturbo psicopatologico. In questi casi svolgerebbero un ruolo fondamentale alcuni fattori che possono contrastare gli effetti negativi dell'aver vissuto esperienze particolarmente stressanti. In particolare, buone capacità cognitive, una buona

autostima e, in ultimo, ma fondamentale, un buon livello di integrazione nel gruppo dei pari proteggono il benessere psicologico del bambino e dell'adolescente aumentandone le capacità di fronteggiare eventuali eventi stressanti.

Il ruolo del temperamento

I fattori temperamentali svolgono un ruolo fondamentale nel causare i disturbi d'ansia. Potremmo definire il temperamento come quella disposizione di base, presente in ciascun individuo sin dalla nascita, che modula l'espressione delle emozioni, il livello di attività, la qualità dell'umore e la propensione alle relazioni sociali. Il temperamento è evidente già molto precocemente ed è stabile durante il corso della vita. Il temperamento ha quindi basi biologiche, al contrario del carattere che dipende, invece, dall'influenza che l'ambiente esercita su un individuo durante il corso dell'infanzia e dell'adolescenza ed è legato alla storia personale e al patrimonio culturale appreso durante il corso dello sviluppo. Per meglio comprendere il rapporto fra temperamento e carattere, potremmo dire che un bambino ha un temperamento inibito se è timido, preferisce attività in solitudine e non cerca la relazione con i pari. Nel tempo questo bambino potrebbe sperimentare, in base a queste sue caratteristiche, esperienze sociali di rifiuto e di mancata integrazione nel gruppo, per cui potrebbe imparare che, per evitare uno stato di sofferenza emotiva, è bene essere riservati con gli altri e non avere atteggiamenti espansivi.

Quindi è sulla base di questo apprendimento che nel bambino si strutturerà nel tempo un carattere più chiuso e riservato.

Il temperamento e il carattere concorrono alla strutturazione della personalità di un individuo nel tempo. In particolare, nel bambino e nell'adolescente riscontriamo dei tratti temperamentali che in età giovane-adulta si consolideranno nella personalità vera e propria dell'individuo.

Secondo il modello tripartito delle emozioni elaborato dagli psicologi Lee A. Clark e David Watson nel 1991, supportato da evidenze scientifiche più recenti, fattori temperamentali come l'affettività positiva, l'affettività negativa e l'iperattivazione fisiologica sarebbero correlati alla presenza di sintomatologia sia ansiosa che depressiva. In particolare la presenza di un'alta affettività negativa, che consiste in una maggiore vulnerabilità e una maggiore sensibilità alle emozioni negative, associata a un'alta iperattivazione fisiologica, può essere considerata fattore di rischio per lo sviluppo di Disturbo d'ansia in bambini e adolescenti. Proprio queste caratteristiche, associate a una timidezza eccessiva, costituiscono il temperamento inibito che da diverse ricerche è stato messo in relazione proprio con lo sviluppo di sintomi d'ansia.

In accordo con questi dati, uno studio di Pessi Lyyra e Tiina Parviainen condotto nel 2018 conferma l'influenza del temperamento nell'esordio della sintomatologia ansiosa. In particolare, lo studio si poneva l'obiettivo di indagare il ruolo di un'elevata sensibilità enterocettiva nell'insorgenza di un

Disturbo d'ansia. La «sensibilità enterocettiva» rappresenta l'insieme di informazioni che giungono dall'interno del nostro corpo (come ad esempio la percezione del battito cardiaco), mentre la «sensibilità esteroceettiva» riguarda tutte quelle sensazioni che provengono dal mondo esterno sotto forma di sensazioni o stimoli (ad esempio il caldo, il freddo, il dolore). I risultati dimostrano che la presenza di un'alta sensibilità enterocettiva è correlata positivamente con la presenza di altri tratti temperamentali predittori della sintomatologia ansiosa, quali ad esempio l'affettività negativa, un'alta intensità emotiva e l'introversione. Possiamo di conseguenza dedurre che i ragazzi con Disturbo d'ansia siano biologicamente più attenti a ciò che avviene all'interno del loro corpo e ai cambiamenti fisiologici cui esso va incontro. Pensiamo, ad esempio, a un adolescente ansioso che è particolarmente spaventato dall'idea di poter avere una malattia e di non esserne a conoscenza. La sua preoccupazione principale è quella di dover scoprire il prima possibile se ha contratto una malattia fisica in modo da poter intervenire tempestivamente. In altre parole, proprio la sua alta sensibilità enterocettiva lo porterà a prestare particolare attenzione a tutto ciò che accade all'interno del suo corpo ed egli finirà con l'attribuire un significato di malattia anche a cambiamenti del tutto fisiologici come possono essere le variazioni del battito cardiaco o della pressione arteriosa.

I bambini e gli adolescenti con temperamento estroverso, sensibili ai bisogni altrui e con una buona socialità sembrerebbero avere minori possibilità di presentare un

Disturbo d'ansia. Possiamo quindi considerare l'estroversione un fattore protettivo, in quanto permette di instaurare relazioni positive innanzitutto con i genitori, favorendo quindi la relazione di cura e la tranquillità familiare. Inoltre i bambini estroversi hanno maggiori probabilità di instaurare numerose relazioni sociali, sia con i pari che con gli adulti, all'interno della comunità di appartenenza. Si tratta quindi di bambini e adolescenti che molto probabilmente disporranno di maggiori figure di riferimento e di un supporto sociale più ampio, e che proprio grazie a questi fattori riusciranno a fronteggiare meglio le situazioni di pericolo o di necessità.

La valutazione diagnostica

Riconoscere precocemente l'ansia: il ruolo del pediatra

Una delle questioni più rilevanti, nel campo della psicopatologia dello sviluppo, riguarda il corretto riconoscimento di un Disturbo d'ansia. Infatti, quando un bambino e un adolescente manifestano preoccupazioni o ansia, per prima cosa è necessario verificare se nel loro ambiente familiare, scolastico e sociale qualcosa stia causando direttamente queste emozioni. Per esempio, l'ansia e i comportamenti di evitamento, come il rifiuto della scuola o delle uscite in pubblico, possono essere manifestazioni di disagio in ragazzi che sono vittime di bullismo, che hanno sperimentato gravi eventi traumatici o che vivono in famiglie abusanti. È solo dopo aver appurato che non esiste alcuna minaccia reale per il bambino e aver stabilito che l'ansia crea una significativa disfunzionalità nella sua vita, che si può ipotizzare la presenza di un Disturbo d'ansia. Non dimentichiamo che i bambini e gli adolescenti ansiosi hanno spesso difficoltà a trovare le parole per esprimere le loro sensazioni. In effetti, essi riferiscono spesso di avere mal di testa, nausea, dolore al petto, di sentirsi stanchi e sono

proprio questi i motivi per i quali la maggior parte dei bambini e degli adolescenti ai quali poi verrà diagnosticato un Disturbo d'ansia si rivolge inizialmente al pediatra insieme ai genitori. Proprio i pediatri, quindi, sono chiamati ad ascoltare i ragazzi e a cercare un possibile significato per il disturbo fisico riferito. Per esempio, gravi crampi allo stomaco prima di andare a scuola o mal di testa prima di impegnarsi in un evento sportivo porteranno a ipotizzare un possibile Disturbo d'ansia e a prospettare il ricorso ai servizi presenti sul territorio per l'avvio dell'assessment psicopatologico e l'eventuale prescrizione di un trattamento.

Il pediatra è una figura fondamentale per un inquadramento diagnostico precoce dei sintomi riferiti e svolge un ruolo centrale nella prevenzione, nell'educazione sanitaria e nella promozione della salute globale del bambino, dell'adolescente e delle rispettive famiglie.

Nello specifico, il compito del pediatra consiste innanzitutto nel prestare attenzione allo sviluppo fisico, psichico, relazionale e cognitivo del bambino all'interno del contesto sociale e culturale a cui appartiene e nel consigliare alla famiglia, qualora lo ritenesse necessario, quali strutture specialistiche o quale medico specialista consultare per un approfondimento diagnostico.

Nel caso dei disturbi d'ansia, è di fondamentale importanza che il pediatra si ponga come figura che faciliti il riconoscimento del disagio mentale. In particolare, in una prima fase di inquadramento della sintomatologia, potrebbe

essere utile porre alla famiglia domande dirette su possibili cambiamenti comportamentali intercorsi nell'ultimo periodo, quali, ad esempio, una diminuzione del rendimento scolastico o mutamenti nelle abitudini alimentari o relative al sonno. Nel caso dei disturbi d'ansia, potrebbe essere utile indagare la tendenza a preoccuparsi eccessivamente, la presenza di eventuali difficoltà nella frequenza scolastica, la comparsa di malesseri (mal di pancia, mal di testa ecc.) non riconducibili a specifiche problematiche organiche o presenti esclusivamente in concomitanza a eventi particolari, quali l'ingresso a scuola, il partecipare ad attività di gruppo o l'esibirsi in pubblico.

TAB. 8. I segnali da non sottovalutare della possibile comparsa di un disturbo psicopatologico

<i>Modificazioni emotive, cognitive e comportamentali</i>
Incapacità di far fronte alle attività di vita quotidiana con la solita efficienza
Cambiamenti nelle abitudini alimentari e/o nel ritmo sonno-veglia
Eccessive lamentele per disturbi fisici
Cambiamento nella prestazione scolastica con calo dei voti nonostante il costante impegno
Perdita di interesse nelle attività o nelle compagnie di amici che solitamente divertono
Aumento significativo del tempo trascorso da soli
Eccessiva preoccupazione o ansia

Riportiamo nella tabella 8 i cambiamenti emotivi, cognitivi e comportamentali che dovrebbero allertare i genitori, gli insegnanti e il pediatra di riferimento in quanto sentinelle

della possibile comparsa di un disturbo di tipo psicopatologico.

Il pediatra, come dicevamo, ha il compito prezioso sia di comprendere se la problematica riportata dal bambino, dall'adolescente o dalla famiglia possa essere inquadrata all'interno di un disturbo psicopatologico, piuttosto che di natura prettamente medica, sia di capire se l'entità e la gravità della sintomatologia riferita necessitino di approfondimento psicologico o neuropsichiatrico. Tale decisione deve essere presa in base alla presenza e alla durata della sintomatologia riferita e al grado in cui essa compromette il normale svolgimento delle attività quotidiane da parte del ragazzo – come la frequenza scolastica e lo svolgimento dei compiti assegnati, la pratica di uno sport, la vita di relazione con gli amici, i familiari ecc. È necessario inoltre escludere eventuali cause fisiologiche attraverso la prescrizione di esami di *screening* (ad esempio esami ematici, ECG ecc.). Nel caso in cui vi sia la necessità di invio a figure specialistiche, quali lo psicologo o il neuropsichiatra infantile, e venga posta una diagnosi vera e propria di Disturbo d'ansia, è utile che il pediatra instauri una collaborazione con lo specialista e supporti il bambino e la famiglia, mantenendo un rapporto costante con gli enti di competenza. Egli è chiamato inoltre a documentarsi e aggiornarsi sul disagio presentato dal ragazzo al fine di fornire risposte adeguate e un appropriato supporto ai genitori.

Nel caso specifico dei disturbi d'ansia, e nelle condizioni considerate lievi, il pediatra può consigliare alla famiglia strategie utili a fronteggiare i sintomi ansiosi del bambino o dell'adolescente. Potrà dunque mettere in atto un primo intervento di tipo psicoeducativo volto a spiegare al ragazzo e ai genitori il tipo di Disturbo d'ansia che è stato diagnosticato e a sottolineare l'importanza di ricevere assistenza dai servizi di salute mentale. Un'azione di questo tipo incrementa la possibilità che il ragazzo e la famiglia accettino con maggiore motivazione l'avvio di interventi specialistici, quali la psicoterapia cognitivo-comportamentale, e siano concordi e collaborativi rispetto a un eventuale trattamento farmacologico.

Il pediatra, inoltre, può iniziare ad agire consigliando libri che possano facilitare la famiglia nella comprensione del disturbo e nella messa in atto di strategie di auto-aiuto appropriate; potrebbe inoltre fornire consigli sulla modifica di alcune abitudini come la regolazione del sonno, il tempo dedicato all'uso dei dispositivi elettronici che espongono il bambino e l'adolescente all'innalzamento dei livelli di ansia e stress.

Sottolineiamo che tali strategie sono applicabili dal pediatra solo nel caso in cui si abbia la certezza di un Disturbo d'ansia di lieve entità che non compromette il funzionamento del ragazzo nella vita di tutti i giorni e sia presente un nucleo familiare collaborante e in grado di supportarlo adeguatamente dal punto di vista emotivo. Nel caso il

pediatra abbia la percezione di una condizione di maggiore gravità è consigliabile partire subito con l'approfondimento mediante il consulto con uno specialista per giungere il prima possibile a una diagnosi appropriata e alla definizione di un adeguato piano terapeutico.

SUGGERIMENTI PRATICI

Concludiamo riportando alcuni suggerimenti per un approccio di cura primaria e di competenza pediatrica al trattamento di bambini e adolescenti con disturbi di natura psicopatologica. Questi consigli, così come la classificazione dei disturbi d'ansia vista nel secondo capitolo, sono tratti dalla quinta edizione del *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*.

- Instaurare un'alleanza terapeutica con il ragazzo e i genitori.
- Chiedere informazioni supplementari per garantire una corretta diagnosi.
- Intervistare gli adolescenti da soli per consentire loro una maggiore libertà di espressione.
- Osservare il ragazzo nell'interazione con lo specialista e con i genitori.
- Spiegare alla famiglia l'importanza del trattamento precoce e cercare di approfondire eventuali timori od ostacoli

all'avvio di un approfondimento diagnostico o di un percorso di cura specialistica.

La costruzione di un quadro psicopatologico

Quando parliamo di *assessment* ci riferiamo a quella valutazione che viene effettuata dal neuropsichiatra infantile o dallo psicologo allo scopo di individuare l'eventuale disturbo psicopatologico presente e comprendere il funzionamento mentale e quotidiano del bambino e dell'adolescente, i suoi punti di forza, le aree da potenziare e le risorse personali e ambientali di cui si dispone.

La valutazione si pone, quindi, due obiettivi principali. Il primo riguarda l'*identificazione del problema*, ovvero rispondere alla domanda se si tratti di un disturbo vero e proprio o di un semplice disagio di carattere transitorio e reattivo, e condurre a una presa di decisione riguardo all'avvio di un eventuale trattamento. Il secondo obiettivo concerne l'*analisi del problema*: se infatti viene appurata la presenza di un disturbo vero e proprio si procede con l'identificazione delle aree disfunzionali, dei comportamenti disadattivi e dei meccanismi cognitivi da modificare per raggiungere gli scopi del trattamento.

Durante la conduzione della valutazione psicopatologica è bene tenere presenti alcune considerazioni di base.

Un *assessment* completo in età evolutiva necessita di informazioni provenienti da più fonti, quali ad esempio il

bambino o l'adolescente, i genitori o i familiari più vicini, gli insegnanti o gli eventuali specialisti che hanno già preso in carico il ragazzo.

È bene ricordare poi che alcuni comportamenti sono tipici di un determinato livello di sviluppo. Come già esplicitato, è più frequente che si manifesti ansia da separazione durante l'inserimento scolastico alla scuola materna anziché alle scuole medie. Inoltre, come espresso nei capitoli precedenti, alcune paure tendono a diminuire con il passare degli anni e a scomparire naturalmente. Ad esempio potremmo considerare accettabile la paura del buio in un bambino di 3 anni, ma totalmente inappropriata in un ragazzo di 12 anni.

Di conseguenza anche i sintomi legati all'ansia variano a seconda dell'età. Se è più frequente riscontrare l'ansia da separazione nei bambini più piccoli, negli adolescenti sarà più frequente l'ansia generalizzata (o fobia sociale).

Anche lo sviluppo cognitivo del bambino e dell'adolescente, legato alle abilità di comprensione e di comunicazione, è un elemento da tenere bene in considerazione. Un bambino piccolo, infatti, potrebbe non essere in grado di fornire una descrizione accurata di ciò che sente dal punto di vista emotivo e delle conseguenti reazioni comportamentali. Ad esempio, potrebbe dire che durante le recite scolastiche sente battere forte il cuore e le gambe tremare ma non riuscire a esprimere il timore che prova per il giudizio dell'altro. Inoltre si potrebbero osservare delle discrepanze tra il riferito del bambino o dell'adolescente e quanto sostengono i genitori e

gli insegnanti. Questo potrebbe avvenire per vari motivi: in primo luogo il ragazzo potrebbe essere restio a parlare apertamente dei suoi problemi con uno sconosciuto oppure potrebbe non essere consapevole di mettere in atto determinati comportamenti. Così, un bambino piccolo potrebbe riferire di voler stare sempre vicino a mamma e papà, mentre i genitori potrebbero spiegare che il bambino mostra agitazione precedente alla separazione vera e propria, ad esempio la sera prima di andare a scuola. Al contrario, un adolescente potrebbe riferire stati ansiosi interni con preoccupazioni eccessive, ad esempio relative al giudizio dei coetanei, mentre il genitore potrebbe osservare semplicemente una maggiore permanenza a casa negli ultimi mesi.

In generale, un *assessment* psicopatologico completo prevede una fase iniziale di accoglienza della famiglia, di analisi del problema per cui è stata richiesta la consultazione e di raccolta anamnestica. La fase successiva sarà invece dedicata all'approfondimento psicopatologico mediante colloquio clinico, condotto separatamente con i genitori e con il bambino o l'adolescente, all'osservazione clinica, alla somministrazione di strumenti diagnostici e alla restituzione della diagnosi con le indicazioni per il trattamento.

È molto importante che tutte queste fasi del percorso di *assessment* psicopatologico, con particolare riferimento alla scelta degli strumenti di *screening* e di approfondimento psicopatologico da utilizzare, vengano condotte riferendosi a

linee guida accreditate e costruite sulle più recenti evidenze scientifiche relative ai disturbi psicopatologici in età evolutiva: solo così è possibile raggiungere una buona accuratezza diagnostica.

Con «linee guida» si intende un insieme di indicazioni proposte dalla comunità scientifica, sviluppate sistematicamente e basate su conoscenze continuamente aggiornate e valide redatte allo scopo di assistere gli operatori sanitari e gli utenti nel percorso di diagnosi e cura. Allo stato attuale, le linee guida più accreditate per la diagnosi dei disturbi d'ansia e degli altri disturbi psicopatologici in età evolutiva sono quelle proposte dall'American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP, 2007) e dal National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2013). Come vedremo nel prossimo capitolo, tanto le linee guida AACAP che quelle NICE offrono indicazioni non solo sul percorso diagnostico da seguire ma anche sui trattamenti più indicati in base alla diagnosi effettuata.

Il primo colloquio. Fin dal primo colloquio, che dovrebbe coinvolgere entrambi i genitori e il bambino o l'adolescente, è importante attivare una buona relazione di fiducia clinico-famiglia comunicando come la valutazione abbia l'obiettivo di facilitare il processo terapeutico attraverso un'attenta diagnosi e la formulazione condivisa degli obiettivi di trattamento a breve e a lungo termine.

È importante in questa fase individuare l'aspetto problematico per cui è stata effettuata la richiesta d'aiuto.

Questa procedura, denominata «analisi della domanda», deve avvenire secondo una modalità duplice: da una parte bisogna accogliere «il problema» che genitori e ragazzo verbalizzano e chiedere loro di essere espliciti sul perché della domanda di visita e sui principali motivi di preoccupazione, dall'altra bisogna cogliere eventuali modalità relazionali disfunzionali intrafamiliari e/o comportamenti incongrui del ragazzo rispetto ai quali non vi è piena consapevolezza né del ragazzo né della famiglia. L'individuazione dell'aspetto problematico consente infatti di avviare il percorso di diagnosi differenziale.

Ad esempio, la famiglia di una ragazza di 16 anni potrebbe chiedere aiuto in seguito alla comparsa di numerosi comportamenti che denotano ansia, come l'eccessiva preoccupazione in ambienti pubblici, angosce sproporzionate riguardo all'adeguatezza dei comportamenti e richieste di rassicurazione. I sintomi riferiti sono relativi a diversi disturbi quali, ad esempio, il Disturbo d'ansia generalizzato, il Disturbo d'ansia sociale, il Disturbo da stress post-traumatico oppure il Disturbo ossessivo-compulsivo. È bene dunque cercare di comprendere i pensieri alla base di tali comportamenti. Ad esempio, la ragazza potrebbe riferire che ha timore nel frequentare ambienti molto affollati in quanto ha paura che gli altri la possano giudicare per come si veste o parla e per questo tende a chiedere continuamente ai genitori e agli amici più fidati se quello che fa o dice va bene o se il suo modo di vestire la fa sembrare carina. Sulla base di questi comportamenti si potrebbe supporre dunque la presenza di

un Disturbo d'ansia sociale che sarà indagato con maggiore cura nelle fasi successive.

Raccolta anamnestica. Nella seconda parte del primo colloquio, successivamente all'ascolto, all'accoglienza e alla comprensione della richiesta di aiuto, è buona prassi procedere con una raccolta anamnestica. Si tratta di un'intervista aperta, non direttiva, volta alla ricostruzione della storia clinica del bambino o dell'adolescente.

Riportiamo di seguito i punti principali da indagare per condurre un colloquio anamnestico.

- *Anamnesi sintomatologica:*
 - insorgenza, durata, frequenza e intensità del sintomo;
 - interferenza nel funzionamento adattivo, intellettuale ed emotivo generale.
- *Anamnesi familiare:*
 - breve raccolta di informazioni sul contesto familiare: lutti, separazioni, traumi, condizione di disagio socio-economico, incuria, discoria e ipercuria familiare, relazioni affettive e clima affettivo familiare;
 - familiarità con patologie, in particolare di tipo neuropsichiatrico;
 - unione genitoriale, presenza di fratelli/sorelle.
- *Anamnesi personale fisiologica:*

- gravidanza: decorso della gravidanza, consanguineità genitoriale;
- parto: modalità di parto (eutocico/distocico con specificazione), età gestazionale, peso alla nascita, circonferenza cranica, lunghezza alla nascita, peso alla nascita, indice di Apgar 1'/5', periodo neonatale;
- nutrizione: allattamento (materno o artificiale) con durata, svezzamento (età di inizio, età di inserimento glutine, età di inserimento latte vaccino);
- sviluppo neuromotorio: controllo del capo, posizione seduta, deambulazione autonoma, prime parole, controllo degli sfinteri;
- vaccinazioni.
- *Anamnesi patologica remota:*
 - precedenti ricoveri/procedure chirurgiche;
 - malattie infettive o altri eventi patologici;
 - presenza di allergie o intolleranze.
- *Anamnesi patologica prossima:*
 - terapia in atto eventuale per sintomatologia descritta nell'anamnesi sintomatologica;
 - documentazione medica personale (ad esempio bisogna domandare: «Sono stati già richiesti altri consulti di tipo psicologico? Il paziente ha ricevuto altre diagnosi?»).

SUGGERIMENTI PRATICI

Chiudiamo questo paragrafo riassumendo alcuni suggerimenti utili per la conduzione dell'*assessment* psicopatologico in età evolutiva.

- Ottenere informazioni da più fonti: bambino, ragazzo, genitori, familiari, insegnanti.
- Usare strumenti diagnostici validati e proposti dalla letteratura scientifica di riferimento per i disturbi psicopatologici in età evolutiva.
- Somministrare questionari i cui risultati saranno utilizzati durante le sedute di psicoterapia.
- Usare chiare rappresentazioni grafiche dei punteggi ottenuti per spiegare i risultati sia al paziente che ai genitori.

Il colloquio clinico

Il colloquio clinico è parte centrale e fondamentale dell'*assessment* psicopatologico in età evolutiva.

L'obiettivo principale del colloquio clinico sono l'osservazione del funzionamento mentale individuale del bambino o dell'adolescente, il riconoscimento degli stati emotivi e dei comportamenti che consentono di individuare un'eventuale diagnosi, nonché la rilevazione delle risorse e delle criticità del ragazzo e del contesto familiare.

Il colloquio psicologico *DSM-5 Oriented* (APA, 2013), proposto tra l'altro anche dalle linee guida precedentemente citate, è un utile strumento per la valutazione psicopatologica in età evolutiva. È consigliabile che esso venga condotto separatamente per bambino e genitori facendo riferimento al criterio dell'età proposto nei principali strumenti di *screening* psicopatologico.

Secondo tale criterio, nel caso di bambini fino agli 11 anni, il colloquio diagnostico è dapprima condotto con i genitori e successivamente con il bambino; nel caso di età superiore agli 11 anni è bene avviare il colloquio diagnostico direttamente con il ragazzo e successivamente dare spazio ai genitori. Intervistare il bambino o l'adolescente in assenza dei genitori è un modo per favorire lo sviluppo di una migliore alleanza e di una maggiore sincerità nelle risposte. Ovviamente tale indicazione deve essere calibrata in base a ogni singola situazione: non bisogna imporre la separazione dal genitore a bambini e adolescenti che preferiscano non rimanere soli con il medico.

Va inoltre tenuto presente che i bambini più piccoli, o quegli adolescenti che sembrano essere immaturi dal punto di vista dello sviluppo, solitamente vengono intervistati con maggiore successo quando i genitori sono presenti e hanno un atteggiamento rassicurante.

Colloquio clinico con i genitori. Il colloquio con i genitori è volto a un'indagine più dettagliata del problema riferito e, in particolare, è utile per giungere a una descrizione più

approfondita del problema del bambino o dell'adolescente e di come esso viene percepito dai genitori.

Un ulteriore obiettivo è la raccolta di informazioni relative al ruolo svolto dai genitori nel mantenimento della sintomatologia e della loro influenza nell'evoluzione del disturbo.

È molto utile in questa fase cercare di individuare e comprendere le percezioni errate che i genitori hanno del problema, gli atteggiamenti irrazionali o i comportamenti inadeguati che mettono in atto, così come le risorse e le doti personali di ciascun genitore. Ad esempio, i genitori di un bambino di 8 anni che presenta significativi tratti di ansia da separazione con rifiuto netto a partecipare alle attività scolastiche ed extrascolastiche senza la loro presenza potrebbero spiegarsi tali comportamenti attribuendoli a una presunta ostilità degli insegnanti e dei coetanei nei confronti del bambino. Sarà compito del clinico quindi esaminare in maniera obiettiva il riferito dei genitori, raccogliendo dati sul loro stile educativo, e servirsi eventualmente di altre fonti di informazione (ad esempio chiedendo una relazione da parte degli insegnanti o concordando un colloquio telefonico con loro).

Non dimentichiamo infatti che proprio le cosiddette «teorie naïve» dei genitori, ovvero le interpretazioni che loro danno del problema del ragazzo, svolgono un ruolo fondamentale all'interno del processo terapeutico, in quanto potrebbero

infiare la partecipazione del genitore e l'aderenza alle prescrizioni del terapeuta.

È importante che i genitori e il terapeuta inizino a considerare il problema del ragazzo o l'eventuale disturbo psicopatologico secondo la stessa ottica, condividendone quindi la spiegazione razionale.

In questo momento di confronto con i genitori è necessario inoltre indagare nello specifico le modalità attraverso le quali il problema riferito si manifesta e condurre un'analisi dettagliata della frequenza, dell'intensità e della durata degli episodi di ansia nonché dei comportamenti, per esempio sotto forma di evitamenti, che il ragazzo esibisce per fronteggiarla.

Oltre al problema riferito è necessario indagare anche la presenza di eventuali sintomi associati al problema principale, quali ad esempio alterazioni del tono dell'umore, cambiamenti nell'alimentazione o nel ciclo sonno-veglia, difficoltà di interazione con i pari. Pensiamo, ad esempio, a un ragazzo panicoso di 16 anni che presenta anche una grave forma di Agorafobia, quindi una forte difficoltà nel frequentare luoghi aperti o chiusi da cui pensa non sia possibile allontanarsi rapidamente nel caso in cui si senta male. Non riesce così ad andare alle feste, a frequentare con gli amici centri commerciali, a partecipare alle manifestazioni cittadine o alle assemblee di istituto, e potrebbe avere difficoltà a entrare in un cinema o in un parco giochi. Immaginiamo che ogni volta debba inventare una scusa per

rifiutare gli inviti dei compagni. Non è raro riscontrare in questi ragazzi episodi di tristezza e sentimenti di autosvalutazione relativi a un senso di fallimento rispetto al non riuscire a svolgere una vita «normale», ovvero come quella dei coetanei. È evidente dunque che questo stato di tristezza è secondario alla sintomatologia ansiosa e agli evitamenti a essa associati.

Infine, non va dimenticato che il colloquio con i genitori è anche un momento importante attraverso il quale comprendere eventuali difficoltà psicologiche che uno dei due potrebbe avere, verificare la presenza di problemi relazionali relativi alla vita di coppia e approfondire lo stile educativo utilizzato da entrambi.

Colloquio con il bambino o l'adolescente. Durante il colloquio condotto con il bambino o l'adolescente è importante che il terapeuta riesca a stabilire una buona relazione con il ragazzo, in modo da favorire una maggiore fiducia e una maggiore veridicità delle informazioni condivise. È quindi importante che l'ambiente fisico e l'atteggiamento del terapeuta mettano il ragazzo a suo agio e siano accoglienti, in modo da facilitare l'instaurarsi di un rapporto positivo e collaborativo. In particolare gli adolescenti devono trovare nel terapeuta una persona che li ascolti, che li faccia sentire non giudicati, che sia soprattutto attento alle loro opinioni e al loro punto di vista.

In questa fase è di fondamentale importanza che il terapeuta sappia adattare il proprio stile comunicativo e

relazionale alle esigenze del bambino o dell'adolescente e al suo profilo di sviluppo; deve innanzitutto chiarire il suo ruolo presentandosi e spiegando con parole semplici qual è il suo compito, ad esempio dicendo: «Ascolto i bambini per aiutarli a cambiare qualche comportamento che li infastidisce o a diminuire le loro paure».

All'inizio del colloquio è bene che siano spiegati i termini di riservatezza, ad esempio dicendo: «Quello che diremo rimarrà confidenziale, a meno che non ci sia un rischio per la tua sicurezza, in tal caso parlerei con un tuo genitore su come tenerti meglio al sicuro».

Il terapeuta inizierà ascoltando il ragazzo e la descrizione della problematica per cui ha chiesto aiuto. In questa fase è importante che venga raccolto il maggior numero di dettagli utili a capire come il bambino o l'adolescente percepisce il suo problema. Sono utili tutte le informazioni su situazioni specifiche in cui si manifesta il problema. Ad esempio se esso è maggiore a scuola oppure a casa, o se è più frequente in concomitanza a eventi particolari come l'ingresso a scuola, le interrogazioni o le uscite con gli amici.

Anche con il bambino o l'adolescente può essere utile indagare le cause e le convinzioni che ha relativamente al problema esperito, cercando di esplorare, come fatto con i genitori, la presenza di «teorie *naïve*» che potrebbero ostacolare il processo terapeutico.

Con il bambino e l'adolescente potrebbe essere utile indagare le conseguenze dei comportamenti riferiti (a partire dalle frasi: «non voglio uscire di casa», «la maestra mi manda a casa con i miei genitori», «non partecipo alle recite»), in modo da indagare eventuali benefici esperiti dalle reazioni di genitori e insegnanti alle manifestazioni ansiose. Ad esempio, una bambina di 6 anni con ansia da separazione potrebbe trovare il modo di rimanere a casa, e non andare a scuola, mettendo in atto vere e proprie crisi similpanicose e passare tutto il giorno a guardare i cartoni animati e giocare insieme ai nonni.

Per indagare questi aspetti in bambini e adolescenti che presentano sintomatologia ansiosa è consigliabile che vengano poste domande dirette e specifiche, come: «Quali sono le cose che ti spaventano di più?»; «Cosa fanno i tuoi genitori quando dici che hai paura?»; «In quale situazione ti senti più agitato o preoccupato?»; «Cosa fai quando ti senti particolarmente agitato?».

In questo modo il bambino e l'adolescente si sentiranno maggiormente compresi e avranno modo di spiegare con più accuratezza i loro sintomi.

Altri aspetti da tenere presenti nella conduzione del colloquio clinico con il bambino e l'adolescente sono:

- Eventuali cambiamenti recenti avvenuti soprattutto nel funzionamento sociale, scolastico e familiare del ragazzo.

- Accurata indagine dei rischi per la sicurezza del ragazzo e di chi lo circonda; si possono porre ad esempio queste domande: «Pensi spesso di far del male a te stesso? Ti sei mai fatto del male, per esempio tagliandoti o percuotendoti? Hai mai tentato di ucciderti? Quanti tentativi hai fatto? Che cosa hai fatto? Quali cure mediche o psichiatriche hai ricevuto dopo questi tentativi? Ti capita spesso di diventare tanto sconvolto da minacciare di far del male ad altre persone, animali o danneggiare delle cose non tue? Hai mai fatto del male a persone o animali, distrutto proprietà, ingannato altre persone, o rubato delle cose?».
- Presenza di eventuali sintomi correlati, ad esempio chiedendo: «In quest'ultimo periodo ti sei sentito particolarmente triste o irritabile?»; «Ti capita mai di non voler mangiare o al contrario di mangiare più del solito?»; «Nell'ultimo periodo ti è mai capitato di avere difficoltà nell'addormentarti oppure di invertire il giorno e la notte?»; «Ti sei mai sentito improvvisamente spaventato, nervoso o ansioso senza nessun motivo? Se è così, me ne puoi parlare?».

Alla fine del colloquio è utile dare al ragazzo una restituzione iniziale di quanto emerso, chiedendo anche se sono stati tralasciati alcuni aspetti importanti, ad esempio dicendo: «Le domande che ti ho fatto riguardavano ciò che ti preoccupa maggiormente? Ho tralasciato qualcosa di importante o c'è qualcosa che dovrei davvero sapere per capire meglio quello che stai attraversando?».

Alla fine del colloquio clinico, condotto separatamente con genitori e bambino o adolescente, il clinico potrebbe ritenere utile organizzare un colloquio di approfondimento in cui siano presenti tutti i membri della famiglia, in modo tale da osservare, in maniera più dettagliata rispetto a quanto già rilevabile nella fase di accoglienza, la modalità di interazione e lo stile comunicativo presenti all'interno della famiglia.

Osservazione clinica. Parte integrante del colloquio clinico è l'osservazione clinica diretta delle modalità relazionali del bambino o dell'adolescente, del nucleo familiare e del funzionamento mentale (eloquio e gioco spontaneo, capacità di autoregolazione emotiva e di relazione con l'adulto estraneo, forma e contenuto del pensiero, aspetto fisico, comportamento, stato emotivo generale e stati o livelli di consapevolezza soggettiva, attenzione, linguaggio, orientamento spazio-temporale).

Gli strumenti diagnostici

Vi sono differenti strumenti diagnostici volti a individuare la presenza di un Disturbo d'ansia e la sua gravità. Essi sono soprattutto interviste semistrutturate che fungono da guida per il colloquio clinico e questionari di autovalutazione rivolti al ragazzo e di cui esistono anche versioni per i genitori.

Nella tabella 9 riassumiamo gli strumenti diagnostici che le linee guida AACAP (2007) e NICE (2013) propongono come prima scelta per la valutazione psicopatologica in età evolutiva.

Per quanto a discrezione del clinico, la somministrazione dei test è parte integrante delle (e di supporto alle) varie fasi del processo diagnostico. Sarà infatti l'integrazione tra i dati derivanti dai colloqui clinici, dall'osservazione clinica e dagli stessi strumenti diagnostici a consentire la formulazione della diagnosi.

La diagnosi

L'assessment psicopatologico si chiude con la fase di restituzione, ovvero quella in cui viene comunicata alla famiglia la diagnosi formulata dal clinico sulla base dei dati emersi dalle differenti fonti di informazione utilizzate (colloqui, osservazione, questionari, report degli insegnanti ecc.).

TAB. 9. Gli strumenti per la valutazione dell'ansia in età evolutiva

Strumenti di valutazione	Descrizione
K-SADS-PL 5 Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children - Present and Lifetime V edizione	Intervista diagnostica semistrutturata basata sui criteri diagnostici del DSM-5 rivolta a bambini di età compresa tra i 6 e i 18 anni e ai loro genitori.

Strumenti di valutazione	Descrizione
MASC 2 Multidimensional Anxiety Scale for Children II edizione	Questionario compilato direttamente da bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni al fine di indagare la presenza di: ansia da separazione e fobie, ansia generalizzata, ansia sociale, ossessioni e compulsioni, sintomatologia fisica ed evitamento del pericolo. Ne esiste anche una versione per i genitori con domande analoghe e inerenti al vissuto del bambino. In questo modo è possibile confrontare le percezioni del bambino e dei genitori sulla sintomatologia ansiosa del bambino stesso.
CDI 2 Children's Depression Inventory II edizione	Questionario autosomministrato per bambini e adolescenti dagli 8 ai 17 anni e per i genitori, volto a indagare problemi emotivi e problemi funzionali correlati alla sintomatologia depressiva. Come per la MASC 2 ne esiste anche una versione per i genitori.
CBCL 6-18/YSR 11-18 Child Behaviour Checklist	Questionario di <i>screening</i> per bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni e per i loro genitori, per la valutazione psicopatologica del comportamento attraverso l'indagine della sintomatologia internalizzante ed esternalizzante.
SAFA-A Scale psichiatriche di autovalutazione per fanciulli e adolescenti	Questionario autosomministrato per bambini e adolescenti dagli 8 ai 18 anni volto a indagare la sintomatologia ansiosa, in particolare: ansia generalizzata, ansia sociale, ansia da separazione e fobia scolare.

In questa fase è importante accompagnare i genitori e il bambino o adolescente a una prima accettazione della diagnosi mediante una chiara spiegazione del disturbo

diagnosticato e una piena disponibilità nel rispondere ai possibili dubbi sulle ragioni del disturbo, sulla sua possibile evoluzione e sulle possibili conseguenze nella vita di tutti i giorni. Vanno anche accolti i vissuti emotivi della famiglia relativamente alla comunicazione degli esiti della valutazione. L'ultimo passo consiste nell'orientare la famiglia a un'eventuale presa in carico terapeutica, prescrivendo trattamenti da svolgersi in maniera conforme a quanto proposto dalle linee guida internazionali. Non va infine esclusa la necessità, per alcuni pazienti, di approfondire particolari aspetti emersi durante la valutazione. In questo caso è bene indicare alla famiglia gli ambiti diagnostici su cui è opportuno fare chiarezza e dare indicazioni sui servizi in grado di effettuare gli approfondimenti clinici ritenuti utili a una maggiore chiarificazione del quadro.

I criteri per l'invio a ulteriori servizi specialistici, per esempio gli istituti ospedalieri di terzo livello, sono la gravità del quadro clinico, la compromissione funzionale associata e la concomitante presenza di patologie organiche.

Infine, la percezione, sin dalla fase iniziale di *assessment*, di rischi per la sicurezza del ragazzo, come nel caso di gravi forme ansioso-depressive con ideazione suicidaria, deve indurre all'avvio immediato del paziente e della famiglia a un pronto soccorso specializzato in patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva.

Le terapie

Perché è importante intervenire

Riconoscere precocemente la presenza di un Disturbo d'ansia nei bambini è di fondamentale importanza al fine di diminuire il rischio di insorgenza, nelle fasi di vita successive come l'adolescenza, la tarda adolescenza e l'età adulta, di disturbi psicopatologici più gravi. Ad esempio, riprendendo ancora una volta qualche dato proveniente dalla letteratura scientifica, studi eseguiti da Peter Lewinsohn nel 2008 evidenziano che ben il 78% dei bambini che ricevono una diagnosi di Disturbo d'ansia da separazione durante l'infanzia è a rischio per lo sviluppo di disturbi psicopatologici più gravi nelle fasi di vita successive. In particolare, questi bambini, se non opportunamente seguiti, sarebbero a elevato rischio di manifestare disturbo di panico e/o disturbo dell'umore in epoca adolescenziale. Se, sulla base di ciò, diviene chiara l'importanza di individuare e trattare precocemente i disturbi d'ansia che insorgono in età evolutiva, va tuttavia sottolineato come un buon intervento terapeutico non possa prescindere dal considerare la stretta relazione tra il bambino e il suo contesto familiare ed extrafamiliare. Si parla infatti di

intervento in «setting multipli» o «multisetting» per riferirsi alla realizzazione dell'intervento in contesti differenziati e con il coinvolgimento di operatori di differenti professionalità integrati tra loro (psicologo, fisioterapista, logopedista, neuropsichiatra infantile). In questo modo, le differenti difficoltà e problematiche del bambino vengono fronteggiate attivando tutte le risorse presenti nei vari contesti in cui egli è inserito. In termini pratici, ciò significa realizzare interventi terapeutici che non siano costruiti esclusivamente sul bambino o sull'adolescente ma anzi coinvolgano attivamente anche i loro genitori e le altre figure significative (nonni, insegnanti, istruttori sportivi ecc.). In questo modo è possibile supportare il ragazzo consentendogli di acquisire la gestione dei sintomi ansiosi e, soprattutto, un certo grado di funzionamento sociale, scolastico e familiare. Per rendere più chiaro ciò, pensiamo a un ragazzo che ha appena ricevuto la diagnosi di Disturbo d'ansia sociale. In questo caso sarà importante non solo pianificare incontri individuali di supporto psicologico ma anche lavorare direttamente sui contesti di vita quotidiana in cui il ragazzo ha paura di esporsi e ricevere un giudizio negativo dagli altri. Saranno quindi fornite indicazioni di supporto ai genitori ma anche agli insegnanti e alle altre figure che ruotano intorno al ragazzo. Così, a scuola si potranno creare situazioni «intermedie» di esposizione come le interrogazioni orali, da svolgersi solo in presenza di alcuni compagni, e in famiglia i genitori potranno supportare i piccoli tentativi di esposizione del bambino o dell'adolescente come riprendere a uscire con i coetanei,

aumentando gradualmente il tempo trascorso fuori casa e promuovendo la partecipazione a situazioni sociali «protette» come i gruppi scout e i gruppi teatrali. Interventi di questo tipo aiutano il bambino ad aumentare progressivamente la capacità di gestire il proprio sintomo con effetti positivi a cascata sul funzionamento nei diversi contesti come la scuola, la famiglia e la relazione con i pari.

L'utilità di pianificare un intervento multisetting nel caso di disturbi d'ansia in età evolutiva è confermata dalle linee guida AACAP (2007) e NICE (2013). In entrambi i casi si sottolinea come d'elezione per il trattamento dei disturbi d'ansia in età evolutiva sia un approccio terapeutico che comprenda la psicoeducazione al bambino e ai genitori circa la natura del disturbo, un lavoro di consulenza con la scuola e con i pediatri di base, lo svolgimento di un trattamento psicoterapico e, nei casi in cui il disturbo è severo e in grado di compromettere in maniera significativa il funzionamento del bambino, l'introduzione di una terapia farmacologica.

Nel corso di questo capitolo proveremo a definire al meglio questo tipo di approccio per setting multipli e/o multisetting chiarendo il più possibile il ruolo delle figure sanitarie – come il neuropsichiatra infantile, lo psicoterapeuta o il pediatra – e dei genitori e degli insegnanti coinvolti nel trattamento, nonché la cornice (la psicoterapia cognitivo-comportamentale) a oggi considerata di maggiore efficacia per i disturbi d'ansia in età evolutiva.

La terapia cognitivo-comportamentale

I dati disponibili in letteratura scientifica suggeriscono come la terapia cognitivo-comportamentale (*Cognitive-Behavioural Therapy*, CBT) rappresenti l'intervento di maggiore efficacia nel trattamento dei disturbi d'ansia di bambini e adolescenti. Premessa della CBT è il principio per cui i pensieri, le emozioni e i comportamenti sono aspetti del funzionamento umano strettamente interconnessi tra loro, che si influenzano reciprocamente. Inoltre, sempre secondo la prospettiva cognitivo-comportamentale, l'individuo reagisce soprattutto alla propria rappresentazione dell'ambiente piuttosto che all'ambiente di per sé; da qui, il disagio del paziente è in gran parte il prodotto di credenze/rappresentazioni disfunzionali dell'ambiente e del sé che si mantengono nel tempo a dispetto della sofferenza che egli sperimenta e delle possibilità e opportunità di modificarla.

Nel complesso dunque, ciò che caratterizza e distingue la psicoterapia cognitivo-comportamentale è la spiegazione dei disturbi emotivi attraverso l'analisi della relazione tra pensieri, emozioni e comportamenti.

Scopo della terapia è aiutare le persone che vi ricorrono a modificare gli schemi e le frequenti rappresentazioni disfunzionali con cui interpretano la realtà, al fine di sostituirli o integrarli con convinzioni più funzionali.

Uno dei principali precursori dell'approccio cognitivo-comportamentale è stato, all'inizio degli anni Sessanta, Albert

Ellis. Qualche anno dopo sono stati pubblicati i contributi di Aaron Beck, che per primo si è occupato delle rappresentazioni distorte dell'ambiente e del sé che sottendono i disturbi depressivi. Tra le evidenze più rilevanti a conferma dell'efficacia dell'approccio cognitivo-comportamentale nel trattamento dei disturbi d'ansia in età evolutiva vi sono, negli anni Novanta, gli studi di Philip C. Kendall, professore di psicologia della Temple University a cui si deve il modello di intervento individuale più diffuso per bambini e adolescenti di età compresa tra i 7 e i 14 anni, denominato *Coping Cat Program*. In questo modello le sessioni terapeutiche si articolano tenendo in considerazione quattro aree principali:

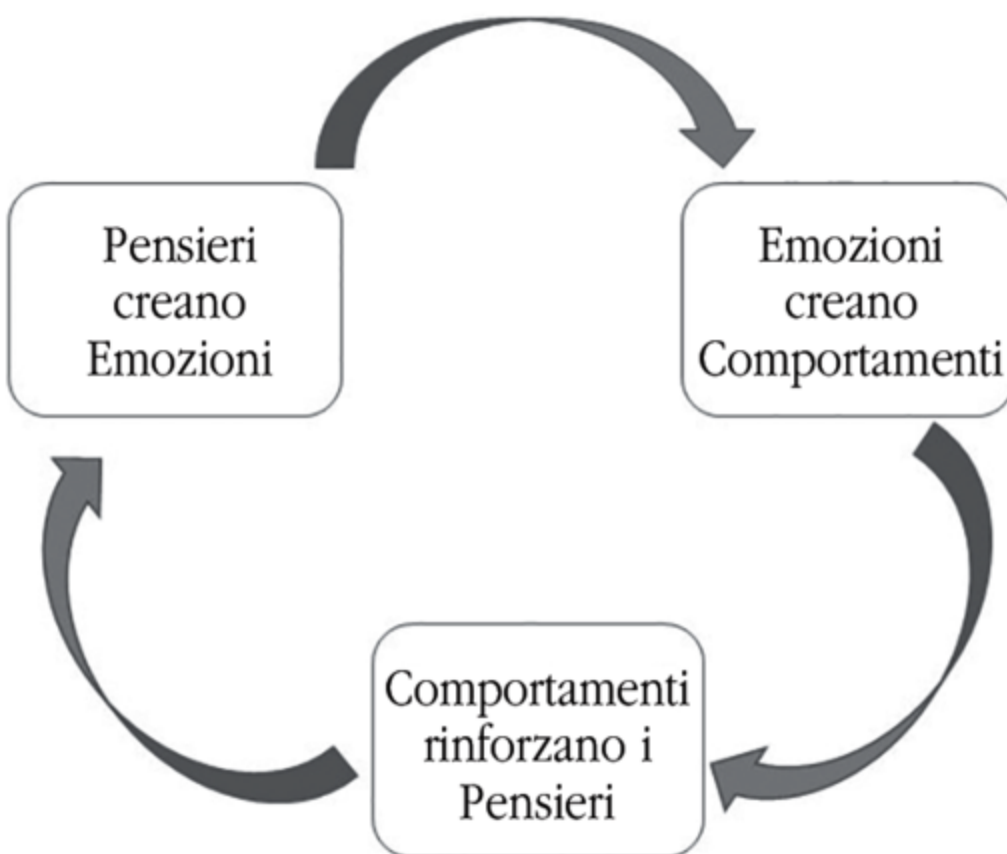


FIG. 3. La terapia cognitivo-comportamentale (www.apc.it).

1. riconoscere l'ansia e i sintomi somatici associati;
2. chiarire i pensieri e le rappresentazioni (molto spesso non realistiche e negative) delle situazioni che provocano ansia;
3. sviluppare un piano di *coping* per far fronte alla situazione ansiogena;
4. valutare le performance e utilizzare gli autorinforzi.

Gli autorinforzi sono essenzialmente i supporti che la persona concede a sé stessa: il lodarsi, l'auto-approvazione, il senso di soddisfazione e di successo personale.

All'interno della terapia cognitivo-comportamentale sono previsti generalmente due incontri con i genitori, finalizzati a strutturare il programma di trattamento e a definire i compiti genitoriali attinenti all'esposizione dei figli alle situazioni ansiogene. Sin dai primi studi di efficacia si è evidenziata una riduzione della sintomatologia ansiosa nel 64% dei casi trattati con questo programma. L'applicazione della terapia cognitivo-comportamentale nei disturbi d'ansia del bambino e dell'adolescente si è rivelata infine efficace anche nell'indurre una riduzione significativa dei sintomi depressivi spesso associati al disturbo d'ansia. Questo dato, corroborato da diversi studi e sostenuto da Lara Picchi e Filippo Muratori, potrebbe essere legato al fatto che sia la stessa riduzione dell'ansia a determinare un miglioramento nel senso globale

di benessere del bambino, con conseguente riduzione dei sintomi depressivi. Nei paragrafi che seguono vedremo da vicino le differenti fasi della psicoterapia cognitivo-comportamentale per il trattamento dei disturbi d'ansia in età evolutiva. Faremo nello specifico riferimento anche al ruolo dello psicoterapeuta e alle tecniche comunemente usate.

Il ruolo dello psicoterapeuta

I bambini o gli adolescenti con un Disturbo d'ansia evitano spesso le situazioni che rappresentano la causa del loro malessere. Così si rifiutano di andare a scuola, di dormire da soli, di allontanarsi dalle figure di riferimento evitando viaggi di istruzione, occasioni sportive, cene fuori con i coetanei ecc. Queste strategie di evitamento non li aiutano tuttavia a superare il problema: l'ansia sembra infatti diminuire ma solo momentaneamente, per poi ripresentarsi non appena la situazione evitata si verificherà di nuovo. Inoltre, il perpetuarsi degli evitamenti finirà con il rinforzare un progressivo isolamento sociale e una progressiva perdita di autonomia da parte del bambino o dell'adolescente.

In questi casi quindi, è essenziale attivare un percorso di psicoterapia e il ruolo dello psicoterapeuta diviene fondamentale al fine di aiutare i bambini e i genitori a far fronte al Disturbo d'ansia nei vari contesti di vita.

Nella visione di Philip C. Kendall (1993), ripresa da Mario Di Pietro (1995), lo psicoterapeuta cognitivo-comportamentale per l'età evolutiva svolge nel corso delle differenti fasi del

percorso terapeutico ben tre funzioni: quella di diagnosa, di consulente e di insegnante.

- Lo psicoterapeuta è un diagnosa. Il primo compito che il terapeuta deve svolgere è quello di diagnosa, ovvero deve raccogliere dati sullo sviluppo del bambino, sulle attuali e pregresse condizioni di cura e su eventuali episodi di disagio psicologico pregresso. Al fine di trarre delle conclusioni circa la natura del problema per cui avviene la richiesta d'aiuto da parte della famiglia del bambino o dell'adolescente, molto spesso lo psicoterapeuta è chiamato ad andare oltre la definizione del problema fornita dal genitore o da altre figure, come gli insegnanti per esempio. Da non dimenticare, infatti, come i problemi riferiti spesso possano essere il risultato di interazioni familiari disfunzionali, per cui l'atteggiamento educativo dei genitori costituirà il primo target d'intervento. Insomma, lo psicoterapeuta svolge la funzione di diagnosa nel momento in cui trae informazioni sul bambino o sull'adolescente da varie fonti disponibili, si serve della propria osservazione clinica ed esamina questi dati alla luce di modelli e linee guida di riferimento al fine di definire la natura e il tipo di disagio riferiti e poter scegliere la linea di trattamento più adeguata.
- Lo psicoterapeuta è un consulente. Nella sua funzione di consulente, lo psicoterapeuta non fornisce soluzioni dirette su come affrontare e gestire il disturbo. Infatti, dire apertamente al bambino o all'adolescente quali

comportamenti assumere non è la soluzione migliore. Risulta molto più efficace aiutare il ragazzo a potenziare determinate capacità, quali valutare adeguatamente le situazioni problematiche e individuare le strategie corrette con cui fronteggiarle (abilità di *problem solving*). Lo psicoterapeuta «allena» dunque il bambino a individuare i pensieri negativi che tende ad attivare nelle situazioni per lui ansiogene e a sviluppare strategie che gli consentano di gestirle più adeguatamente dal punto di vista emotivo e comportamentale. Nella figura 4 proponiamo un possibile modello di *problem solving* da attuare con il bambino o con l'adolescente.

- Lo psicoterapeuta è un insegnante. Il terapeuta ha il compito di aiutare il bambino o l'adolescente a padroneggiare strategie efficaci per gestire le sue emozioni e il suo comportamento, stimolandolo ad apprendere modi di pensare a sé e alle situazioni più efficaci. Sempre nella sua funzione di insegnante, il terapeuta guiderà il bambino o l'adolescente nel riconoscere i suoi punti di forza e nell'accettare quelli di debolezza come aree da potenziare e non come dei limiti.

Complessivamente, un intervento cognitivo-comportamentale può dirsi qualitativamente valido se il terapeuta integra e decodifica tutti i dati a disposizione (diagnosta), supporta il ragazzo affinché trovi modalità efficaci per fronteggiare le difficoltà (consulente), e gli fornisce gli strumenti che favoriscono l'apprendimento di strategie

(insegnante). L'obiettivo è modificare in modo costruttivo i comportamenti futuri e il significato attribuito all'esperienza. Condizione fondamentale affinché il terapeuta riesca a svolgere le tre funzioni descritte è la costruzione di una buona relazione terapeutica che consenta di creare un rapporto improntato sull'empatia, sull'alleanza e sulla fiducia. Sarà infatti proprio la qualità di questa relazione a influire in maniera determinante sull'andamento e sull'efficacia del trattamento. Non va dimenticato che un bambino gravemente ansioso potrebbe vivere con molta ansia anche il primo incontro con lo psicoterapeuta. È importante quindi non aspettarsi che sia subito parte attiva del trattamento ma cercare di comprendere i motivi di tale ansia, che potrebbero essere dovuti a rappresentazioni distorte del setting terapeutico o ad atteggiamenti ansiogeni da parte dei genitori nei riguardi dell'avvio del percorso di cura.

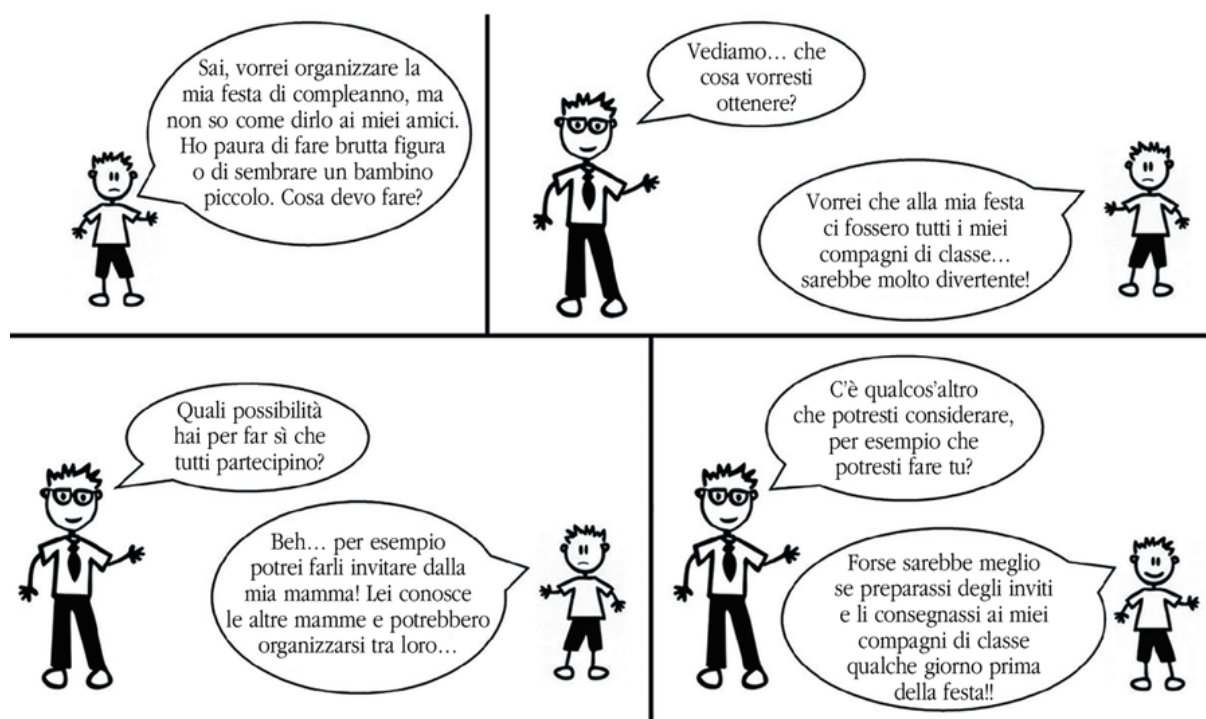


FIG. 4. Un esempio di *problem solving*.

Sono soprattutto gli adolescenti a mostrare indecisione e ambivalenza nei confronti del percorso da intraprendere, specie quando minimizzano le difficoltà e si rifiutano di recarsi costantemente agli incontri prefissati. In questi casi può essere opportuno, per diminuire il livello d'ansia e la probabilità di abbandono del trattamento, non assumere un atteggiamento eccessivamente direttivo ma anzi contrattare con loro tempi e modalità del percorso, aiutandoli a mettere a fuoco l'area di maggior disagio su cui essi sentono di necessitare di un aiuto specialistico.

Lo psicoterapeuta ha a disposizione una varietà di risorse per promuovere una relazione favorevole, tramite la messa in pratica di alcuni accorgimenti che creano alleanza all'interno del contesto d'intervento. Importante è predisporre l'ambiente dove avvengono gli incontri, renderlo accogliente e familiare. Il linguaggio utilizzato con il ragazzo deve essere adeguato alla sua età, al suo livello cognitivo e culturale. È fondamentale, inoltre, che tanto il bambino quanto l'adolescente siano a conoscenza del motivo per cui sono stati accompagnati in terapia, comprendano il ruolo del terapeuta, e siano informati sulle peculiarità della terapia e sui contenuti che verranno affrontati con i genitori in sua assenza. Lo psicoterapeuta, infine, non deve creare false aspettative al bambino, all'adolescente o ai genitori sull'efficacia del trattamento ed è chiamato a definire obiettivi realistici che consistono in una migliore gestione dei pensieri e delle

emozioni negative con conseguente diminuzione degli evitamenti delle situazioni ritenute ansiogene attraverso l'utilizzo nei diversi contesti delle abilità (*coping skills*) apprese in seduta.

Le fasi del trattamento

Così come proposto da Furio Lambruschi nel suo libro dedicato alla *Psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva* possono essere individuate alcune fasi attraverso le quali articolare il trattamento per la gestione dell'ansia: la psicoeducazione, il riconoscimento e la gestione delle emozioni, l'identificazione delle distorsioni cognitive, la messa in discussione delle proprie distorsioni cognitive, la prevenzione delle ricadute, l'automonitoraggio e i rinforzi, e, infine, l'esposizione.

Prima fase. La prima fase consiste nella psicoeducazione rivolta sia al ragazzo che al genitore. In questa fase, viene fornita una spiegazione relativa alla natura dell'ansia e si esplicitano i sintomi più frequenti che caratterizzano la tipologia del Disturbo d'ansia di quel particolare bambino. Questa fase iniziale del percorso è di fondamentale importanza in quanto consente la condivisione tra ragazzo, genitore e terapeuta dei pensieri e degli stati emotivi associati all'ansia. Tale condivisione ha la funzione di rassicurare tanto il ragazzo quanto i genitori sul fatto che il disagio sperimentato non è esclusivo del ragazzo stesso ma, piuttosto, costituisce una possibile risposta a determinati momenti di vita o a eventi stressanti, rispetto alla quale

possono essere messe in atto strategie utili a contenerla. Sin dalla fase iniziale dunque è importante che il bambino o l'adolescente non si senta di dover da solo risolvere e gestire il proprio disagio, ma avverta la presenza di una rete di supporto di cui genitori, psicoterapeuta e insegnanti costituiscono i nodi principali. Sempre in questa fase, lo psicoterapeuta, riferendosi ai principi basilari della terapia cognitivo-comportamentale, illustra le modalità più efficaci attraverso le quali intende perseguire l'obiettivo di ridurre sintomi ansiosi e, soprattutto, il loro impatto sulla vita di ogni giorno. Chiarirà dunque la relazione esistente tra pensieri, emozioni e comportamenti specificando come ognuno di essi influenzi l'altro e come cruciale sia modificare le credenze disfunzionali che il ragazzo ha delle situazioni per lui ansiogene.

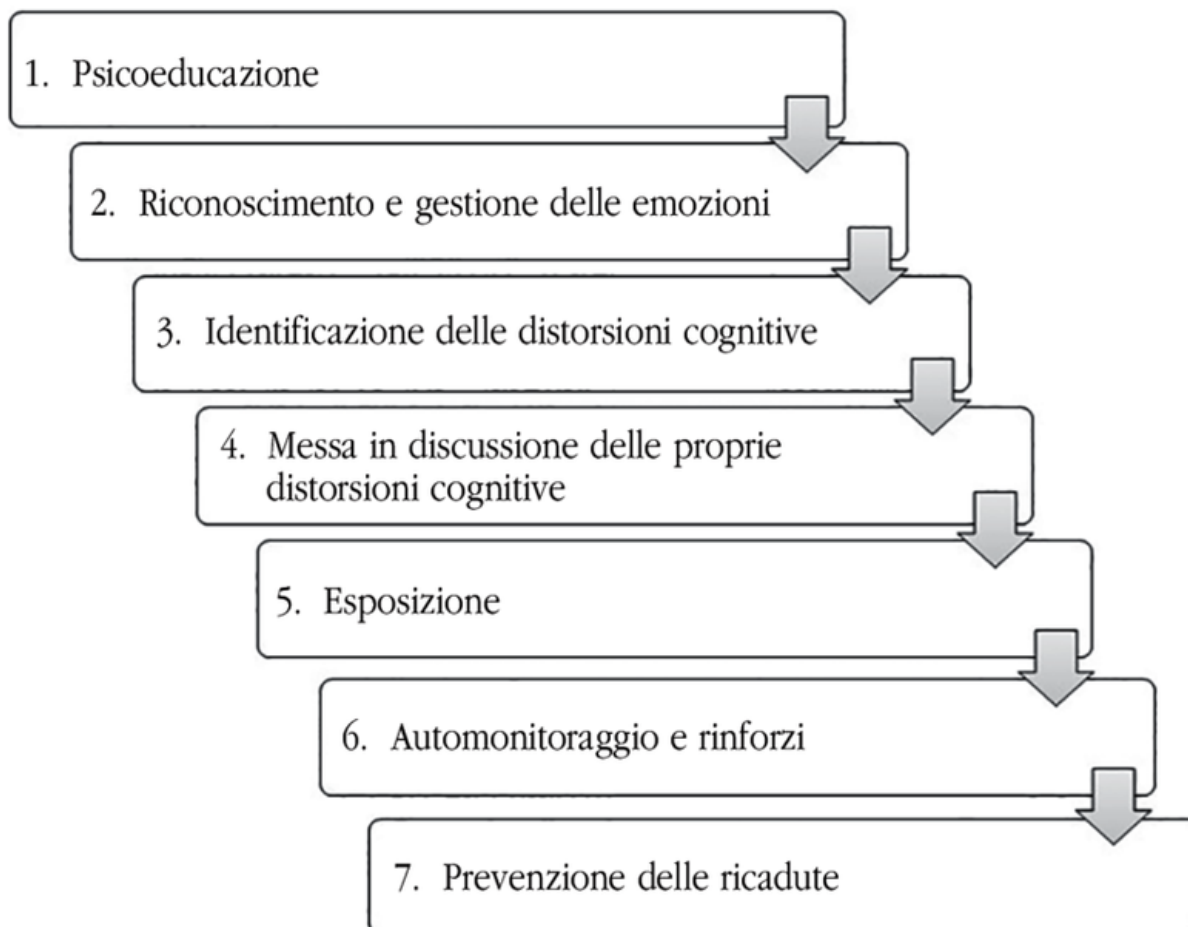


FIG. 5. Le fasi del trattamento CBT per la gestione dell'ansia.

Il colloquio psicoeducativo rivolto ai genitori, oltre a favorire la condivisione e la chiarificazione della problematica correlata alla sintomatologia ansiosa del figlio, ha la finalità di promuovere una più adeguata gestione educativa del bambino attraverso lo sviluppo della sua autonomia nei diversi ambiti di funzionamento e nelle situazioni nuove, la riduzione delle critiche eccessive e l'incoraggiamento a portare a termine un'attività, anche quando egli manifesta la paura di non farcela o il timore di sbagliare. In caso di rifiuto o ritiro scolastico può essere necessaria una psicoeducazione

focalizzata sulla scuola, mediante una continua condivisione e collaborazione con gli insegnanti.

Seconda fase. La seconda fase del trattamento per la gestione dell'ansia prevede un training con il ragazzo basato sul riconoscimento e sulla gestione delle emozioni, opportuno per favorire l'acquisizione di una maggiore consapevolezza delle emozioni provate, nelle situazioni ansiogene, di fronte al supposto pericolo e tali da incidere sulle reazioni da lui attuate. Questo aspetto è fondamentale affinché il ragazzo impari a individuare le modalità più adeguate di gestione degli stati emotivi e dei comportamenti determinati dall'ansia.

Terza e quarta fase. La terza e la quarta fase consistono nell'aiutare il bambino o l'adolescente a identificare e modificare, tramite tecniche di ristrutturazione, tutte quelle convinzioni soggettive e irrazionali implicate nell'insorgenza e nel decorso del Disturbo d'ansia. Dopo aver individuato insieme al terapeuta tali credenze disfunzionali, il bambino deve imparare a modificare il modo errato con cui percepisce gli avvenimenti della realtà circostante, grazie all'apprendimento di strategie che hanno la finalità di diminuire l'ansia.

Quinta fase. Una volta modificate le credenze disfunzionali del bambino circa la situazione ansiogena e, conseguentemente, le reazioni di fronte a essa, è utile esporre il bambino proprio alla situazione ansiogena stessa.

Sesta fase. L'esposizione può essere reale o immaginata, e permette al ragazzo di mettere in pratica le abilità emotive e cognitive acquisite sino a una graduale desensibilizzazione dall'ansia.

Settima fase. Durante la fase finale del trattamento si forniscono indicazioni su come prevenire le ricadute per preparare il bambino e i genitori alle sfide future.

Per riassumere, il trattamento dei disturbi d'ansia in età evolutiva si fonda su alcuni principi basilari. Innanzitutto l'obiettivo è dare ai genitori e al bambino una spiegazione dettagliata del disturbo, informandoli che le situazioni, i pensieri e i comportamenti sono strettamente correlati e si influenzano vicendevolmente. Successivamente lo psicoterapeuta aiuta il bambino a individuare e monitorare i pensieri da cui scaturisce l'ansia. Un aspetto fondamentale riguarda infine l'aiutare il ragazzo a modificare i suoi pensieri distorti e a valutare l'evento ansiogeno in un'ottica differente e più realistica, attraverso una graduale esposizione a esso che gli consenta di diminuire le condotte di evitamento e affrontare la situazione attuale o futura.

Le tecniche cognitivo-comportamentali

Le tecniche impiegate nel trattamento dei disturbi d'ansia sono il rilassamento, l'immaginazione, la ristrutturazione cognitiva, il *problem solving*, e la gestione delle ricompense/rinforzi.

Rilassamento e tecniche immaginative. Il rilassamento è una tecnica psicofisica finalizzata al raggiungimento di uno stato di tranquillità mentale e di distensione muscolare. Consiste in azioni volontarie finalizzate a regolare e gestire gli stati di ansia e di stress. L'obiettivo è dunque quello di alleviare al bambino gli stati di tensione che sperimenta quotidianamente a causa della propria ansia.

Poiché i bambini ansiosi non possiedono la naturale capacità di percepire i segnali indicativi della propria rigidità fisica, molto utili possono essere gli esercizi di tensione-distensione muscolare. Essi consistono nel mettere appositamente sotto massima tensione vari gruppi muscolari e poi distenderli completamente; in questo modo si insegna a riconoscere ogni segno di tensione fisica in qualsiasi distretto corporeo e a utilizzare la percezione di tale tensione come segnale per attivare uno stato di rilassamento. Per rendere più efficace l'apprendimento di tale procedura è consigliabile prevedere un determinato periodo di tempo da dedicare alla fase di addestramento (ricordiamo che il bambino ansioso non ha, almeno inizialmente, un'adeguata consapevolezza dei segnali di tensione provenienti dal proprio corpo) e chiedere al bambino di cominciare a praticare il rilassamento solo su tre gruppi muscolari per seduta, per poi farlo esercitare a casa due volte al giorno. Il training di rilassamento richiede infatti una pratica costante da attuare anche a casa e può essere personalizzato a seconda delle difficoltà e peculiarità del bambino.

Per quanto riguarda le tecniche immaginative, possono essere utilizzate per favorire il rilassamento e diminuire l'insorgenza degli stati ansiosi. Le immagini mentali infatti possono fungere da stimolo ed evocare risposte emotive e comportamentali. Per esempio, nell'ambito degli esercizi di rilassamento, l'immaginazione è un buon ausilio per insegnare al bambino a distendere i vari gruppi muscolari; esempi di immagini mentali che possono facilitare uno stato di distensione sono: un fiume che comincia a scorrere dalla testa e, attraversando tutto il corpo, porta via ogni tensione; un senso di calore che comincia a irradiarsi dall'addome, diffondendosi gradualmente in tutto il corpo facendolo sentire rilassato.

Fra le tecniche immaginative, particolarmente indicata per i bambini fobici è la visualizzazione emotiva proposta da Arnold Lazarus: essa consiste nell'associare ripetutamente l'immagine dello stimolo fobico all'immagine di uno stimolo molto gratificante per il ragazzo. Grazie a questa associazione ripetuta, lo stimolo fobico perde gradualmente il suo carattere ansiogeno, consentendo al bambino o all'adolescente un avvicinamento a esso nelle situazioni di vita reale. Capita spesso con i bambini di ricorrere alla tecnica detta «dell'eroe preferito», che consiste nel chiedere loro di immaginare di affrontare ciò che li spaventa insieme a un eroe o un personaggio preferito. Si tratta innanzitutto di individuare un personaggio preso dalla TV, dal cinema o dai fumetti molto gradito al bambino. Gli si chiede poi di immaginarsi nella situazione temuta costruendo una storia fantastica in cui lui è

il protagonista che, affiancato da questo personaggio, affronta con successo ciò che lo spaventa. Anche rievocare con il bambino come il personaggio preferito di qualche serial televisivo gestisce certe situazioni può rappresentare uno spunto utile affinché bambino e psicoterapeuta individuino strategie condivise di fronteggiamento.

Ristrutturazione cognitiva e «problem solving». Così come proposto da Fabio Celi nel 2015, la ristrutturazione cognitiva è una metodologia terapeutica che punta alla modificazione di quei pensieri negativi che generano ansia nel bambino e nell'adolescente e che possono essere definiti disfunzionali in quanto sulla base di essi egli mette in atto gli evitamenti di cui abbiamo parlato precedentemente e che ne compromettono il funzionamento nei contesti quotidiani. Per ottenere la modificazione dei pensieri disfunzionali lo psicoterapeuta deve innanzitutto aiutare il ragazzo a riconoscere i pensieri che lo fanno stare male, mostrandogli che sono proprio alcune loro caratteristiche a renderli pericolosi: sono esagerati (un conto è pensare «L'interrogazione potrebbe non andare bene», altra cosa è pensare «Sicuramente prenderò un brutto voto, tutti mi derideranno e tornerò a casa triste»), sono dicotomici («O prendo dieci all'interrogazione o sarà un fallimento») e assoluti («L'interrogazione è andata male, tutto quello che faccio è sbagliato»). Sono inoltre caratterizzati da inferenze arbitrarie, per cui da piccoli particolari arrivano a conclusioni generali («La professoressa oggi non mi ha accolto e gratificato, lei sono antipatico, non piaccio a nessuno!»).

Successivamente, lo psicoterapeuta li mette in discussione e cerca di mostrare al paziente quanti errori essi contengano e come sarebbe funzionale pensare in modo diverso.

Nel caso dei disturbi d'ansia la ristrutturazione cognitiva può essere usata per correggere un'interpretazione errata di un sintomo fisico. Se un bambino o un adolescente con Disturbo di panico pensa per esempio che l'aumento del battito cardiaco sia il primo segnale di un infarto che certamente lo porterà alla morte, modificare questo pensiero può contribuire a interrompere il circolo vizioso dell'ansia fatto di conseguenti evitamenti come «Non vado a scuola e non esco con gli amici perché potrei sentirmi male». A tale fine, lo psicoterapeuta procederà innanzitutto mostrando al ragazzo quanto la sua interpretazione del sintomo fisico (aumento del battito cardiaco) sia esagerata (un conto è avere la sensazione che qualcosa non vada, un conto è pensare all'infarto). Quindi, potrà poi procedere con il metterla in discussione («Come fai a essere certo che si tratti di un infarto? Quante sono le probabilità che sia effettivamente così») e proporre interpretazioni più funzionali («Non potrebbe essere solo un sintomo dell'ansia che tendi a provare in quel tipo di situazioni?»).

Accanto alla ristrutturazione cognitiva, la tecnica del *problem solving* può essere utile, nel corso del trattamento, al fine di aiutare il bambino a trovare una vasta gamma di soluzioni nel gestire i problemi legati all'ansia. Il ragazzo infatti viene supportato dallo psicoterapeuta che lo aiuta a

pensare alla situazione ansiogena come a un problema per cui esistono soluzioni possibili. In quest'ottica, la procedura si articola in sei fasi.

1. Il terapeuta innanzitutto guida il bambino o l'adolescente nel riconoscere l'esistenza del problema grazie alla consapevolezza dello stato emotivo negativo provato (*fase di orientamento generale*).
2. Il problema viene definito nell'ottica di individuare gli obiettivi desiderati (*fase di definizione del problema*).
3. Vengono vagliate le varie possibili soluzioni (*fase di individuazione delle soluzioni possibili*).
4. Viene selezionata la soluzione da attuare dopo aver valutato le possibili conseguenze di essa (*fase di presa di decisione*).
5. Viene messa in atto la soluzione scelta (*fase di attuazione della scelta*).
6. Si procede alla verifica dei risultati ottenuti con la soluzione scelta (*verifica dei risultati ottenuti*).

Per rendere più facile la comprensione della procedura facciamo un esempio.

Marco, 10 anni, ha un Disturbo d'ansia generalizzato che si manifesta con ansia prestazionale. In particolare, Marco si preoccupa delle interrogazioni orali a scuola e, un giorno, arriva in seduta preoccupatissimo per l'interrogazione che la

maestra di matematica ha fissato per la settimana successiva. Marco appare anche particolarmente stressato dal fatto di imporsi di dover prendere a tutti i costi un voto molto alto. Con bambini come Marco, lo psicoterapeuta è chiamato a far sì che egli rifletta su come può ottenere una preparazione che lo gratifichi senza tuttavia stressarsi eccessivamente. Sempre nell'esempio di Marco, psicoterapeuta e bambino vaglieranno diverse possibili strategie: pianificare uno studio giornaliero; utilizzare strumenti (ad esempio schemi, mappe) che consentano una memorizzazione migliore e più rapida; studiare insieme a un amico per ripassare e, soprattutto, interpretare come un successo scolastico qualunque voto dalla sufficienza in su. Sulla base delle possibili strategie individuate, psicoterapeuta e bambino sceglieranno insieme quali soluzioni attuare, discutendo delle possibili conseguenze di ognuna di esse. Successivamente è importante far sperimentare al bambino quanto concordato valutando nelle sedute successive l'efficacia di queste strategie.

Gestione dei rinforzi/ricompense. Lo psicoterapeuta cognitivo-comportamentale può utilizzare una serie di tecniche che aiuteranno il ragazzo a mettere in atto con sempre maggiore frequenza comportamenti adeguati in risposta a situazioni potenzialmente ansiogene. Tra queste vi sono il rinforzo positivo, lo *shaping*, la generalizzazione e l'estinzione. Il principio generale che accomuna queste tecniche è quello per cui il bambino o l'adolescente ricevono gratificazioni allo scopo di aumentare la comparsa di alcuni comportamenti.

Il rinforzo positivo, che consiste nel dare al bambino una ricompensa dopo che ha affrontato una situazione da lui temuta, si è rivelato particolarmente utile nel trattamento della fobia scolastica, dei timori notturni, dell'ansia da separazione e dell'isolamento sociale. Infatti, proprio il ricevere il rinforzo positivo aumenterà la tendenza del bambino ad affrontare nuovamente la situazione temuta.

Quando il comportamento che si vuole far mettere in atto al bambino è particolarmente complesso e impegnativo da raggiungere e si prevede non potrà essere raggiunto in breve tempo, si adotta la tecnica dello *shaping*. Essa consiste nel fornire una ricompensa/gratificazione quando il modo di reagire del bambino alla situazione stessa si approssima, anche solo parzialmente, al comportamento desiderato. Per esempio, se un bambino con Fobia scolare riesce a recarsi a scuola ma non riesce a rimanervi per tutto l'orario scolastico, riceverà comunque un rinforzo. Il rinforzo positivo non consiste necessariamente in un oggetto, deve anzi essere scelto basandosi sulle preferenze e sugli interessi del bambino. Infatti, per essere efficiente deve risultare da lui desiderato. La scelta del rinforzo adeguato è quindi fondamentale per la sua efficacia. Tra i più comuni rinforzi positivi troviamo quelli socioaffettivi centrati sullo scambio con l'altro – prevedono per esempio dimostrazioni di affetto o di gratificazione da parte dei genitori o di altre figure di riferimento – e i rinforzi dinamici – che consistono nella possibilità di svolgere attività piacevoli o godere di privilegi prestabiliti. Non va poi dimenticato che determinati sintomi

ansiosi e i conseguenti comportamenti di evitamento sono spesso mantenuti dal soggetto quando altre fonti contribuiscono a rinforzarli. In questo caso è utile procedere con la tecnica di estinzione che consiste nell'eliminare il comportamento ansioso o di evitamento che il bambino attua cercando di evitare qualsiasi tipo di rinforzo ad esso. Un comportamento infatti viene messo in atto solo se comporta conseguenze positive, e non se non sortisce alcun effetto. Pensiamo per esempio al bambino che riceve un maggior numero di attenzioni quando manifesta la propria ansia mostrandosi preoccupato o verbalizzando spesso i propri malesseri fisici. La procedura consente di ottenere una diminuzione delle reazioni timorose eliminando i possibili rinforzi che le incrementano. Si chiederà così a genitori e insegnanti di distogliere l'attenzione da questi comportamenti fino a ignorarli.

TAB. 10. *Le principali tecniche cognitivo-comportamentali utilizzate in età evolutiva*

Tecniche cognitivo-comportamentali	Definizione
Rilassamento	Tecnica psicofisica finalizzata al raggiungimento di uno stato di tranquillità mentale e distensione muscolare.
Tecniche immaginative	Tecniche d'immaginazione mentale che favoriscono uno stato di rilassamento, contrastano l'insorgere dell'ansia e promuovono nuove modalità di apprendimento per affrontare gli eventi.

Tecniche cognitivo-comportamentali	Definizione
Ristrutturazione cognitiva	Metodologia terapeutica che si prefigge l'obiettivo di correggere modalità di pensiero disfunzionali, d'ausilio nel mettere in discussione le convinzioni irrazionali ed errate.
<i>Problem solving</i>	Strumento cognitivo con funzione di insegnare al bambino/adolescente a riconoscere, definire il problema, trovare soluzioni a esso e valutare i risultati derivanti dall'applicazione delle alternative.
Rinforzo positivo	Somministrazione di gratificazioni ogniqualvolta il soggetto si avvicina alla situazione.
<i>Shaping</i>	Procedura attuata fornendo una ricompensa quando il comportamento del bambino si avvicina a quello auspicato. Metodo efficace nei casi in cui prevale l'evitamento.
Estinzione	Tecnica di eliminazione di un comportamento disfunzionale che consiste nell'evitare di rinforzare i comportamenti inadeguati.

Nella tabella 10 riportiamo una sintesi delle principali tecniche cognitivo-comportamentali precedentemente descritte.

Le strategie terapeutiche

Accanto alle tecniche cognitivo-comportamentali appena descritte, lo psicoterapeuta cognitivo-comportamentale ha a

disposizione una serie di strategie che gli consentono di aiutare il ragazzo a ridurre gli evitamenti delle situazioni per lui ansiogene.

Tra queste strategie possiamo citare: il *modeling*, il *role-playing* e l'esposizione.

Il *modeling*. Può essere definito come una modalità di apprendimento basata sull'osservazione di un modello e sull'imitazione del suo comportamento. Per esempio, se lo stesso psicoterapeuta viene percepito come una persona esperta, comprensiva, accogliente e capace di gratificare in maniera obiettiva, può diventare egli stesso un modello efficace per l'apprendimento di pensieri e comportamenti funzionali.

In particolare, esistono due categorie di *modeling*: il *mastery modeling* e il *coping modeling*. Nel primo chi funge da modello mette in atto il comportamento in maniera ideale, senza errori e difficoltà. Nel secondo, invece, colui da prendere come riferimento compie degli errori al fine di porre in rilievo gli ostacoli e le ipotetiche difficoltà che possono insorgere quando si affronta una determinata situazione.

Il *modeling* può essere compiuto nella realtà, mostrato simbolicamente, o attuato tramite una modalità partecipativa. La tipologia di *modeling* simbolica consiste nel far vedere al bambino scene videoregistrate in cui un'altra persona affronta un evento per lui ansiogeno. Il *modeling* nella realtà prevede che il bambino osservi un modello reale (ad

esempio lo psicoterapeuta) mentre fronteggia ciò che lui teme. L'ultimo tipo di *modeling* (partecipativo) è considerato maggiormente efficace, e al bambino viene chiesto di partecipare all'episodio impegnandosi in prima persona nel fronteggiare la situazione ansiogena.

Il role-playing. È una strategia terapeutica nella quale il bambino «prova» alcuni comportamenti in modo da essere in grado di metterli in atto più efficacemente quando si troverà in contesti di vita quotidiana e non terapeutici. Il *role-playing* può essere utilizzato nel contesto della psicoterapia individuale, quindi all'interno dello studio del terapeuta, oppure nell'ambito di terapie di gruppo svolte al fine di insegnare al ragazzo abilità sociali tali da garantire un buon adattamento dello stesso ai contesti di vita. Sia che venga svolto in maniera individuale sia che venga svolto in modalità di gruppo, va sottolineato come sia buona pratica consentire al bambino o all'adolescente di «provare» sia interazioni sociali positive, come il chiedere l'aiuto di un compagno di classe, sia interazioni sociali negative, come l'esercitarsi su come comportarsi in situazioni (ad esempio la ricreazione) in cui si sente «messo in mezzo» e preso in giro dai coetanei. Simulando anche interazioni sociali negative, il bambino può essere aiutato ad acquisire abilità di autocontrollo e di gestione dell'ansia. È fondamentale infatti che durante il *role-playing* lo psicoterapeuta chieda al ragazzo quali sono i pensieri e le emozioni che prova durante l'interazione. Infatti, a partire da questo monitoraggio di pensieri ed emozioni provate in una situazione per il ragazzo potenzialmente

ansigena, come nel caso di un'interazione sociale negativa, è possibile contemporaneamente fornire al bambino le strategie di fronteggiamento di situazioni di questo tipo ma anche procedere con la ristrutturazione cognitiva dei pensieri disfunzionali emersi durante la situazione simulata.

L'esposizione. Spesso usata nel trattamento dei disturbi d'ansia, l'esposizione consiste nell'esporre il bambino alla situazione per lui ansigena o direttamente o per il tramite dell'immaginazione. Il rationale su cui si poggia questa procedura è quello dell'abituazione: si tratta di un processo mediante il quale la risposta comportamentale e sensoriale di una persona diminuisce nel tempo, dopo ripetute esposizioni a un particolare stimolo. In questo modo, il bambino ansioso viene esposto, dapprima gradualmente, a ciò di cui ha paura fino a quando egli si adatta alla situazione senza sperimentare reazioni ansiose. Nell'ambito della psicoterapia cognitivo-comportamentale sull'ansia, questa strategia consente al bambino ansioso di fronteggiare l'ansia utilizzando le abilità apprese nel corso del percorso terapeutico.

TAB. 11. Le principali strategie terapeutiche utilizzate in età evolutiva

Strategie per l'intervento	Definizione
<i>Modeling</i>	Modalità di apprendimento di nuovi comportamenti e competenze tramite l'osservazione di un modello e la sua imitazione.

Strategie per l'intervento	Definizione
Role-playing	Metodologia terapeutica di insegnamento delle abilità, durante la quale il soggetto simula alcuni comportamenti allo scopo di attuarli in maniera più efficace nelle situazioni reali.
Esposizione	Tecnica di esposizione graduale alla situazione temuta o allo stimolo fobico al fine di acquisire abilità di fronteggiamento e gestire l'ansia.

La relazione terapeutica e il lavoro cognitivo-comportamentale con i genitori

La costruzione di una relazione positiva con i genitori è condizione necessaria al superamento del disturbo d'ansia del bambino o dell'adolescente. È molto importante infatti che essi si sentano parte attiva del percorso psicoterapeutico proposto e a tal fine va predisposto per loro uno spazio terapeutico apposito, il *parent training*. Così come l'espressione stessa suggerisce, si tratta di dare al genitore delle istruzioni su come fronteggiare gli stati ansiosi del figlio, affinché l'adulto non metta in atto stili educativi e atteggiamenti che possono rinforzare il sintomo piuttosto che ridurlo. Per esempio, se il genitore di un ragazzo con Disturbo di panico limita l'autonomia del figlio accompagnandolo a scuola, in palestra o alle uscite con gli amici e gli esplicita la paura che in questi contesti possa sperimentare nuovamente i sintomi panicosi, egli non fa altro che mantenere lo stato ansioso del figlio. Questo è un chiaro esempio di *family accommodation*, ovvero l'insieme dei comportamenti disfunzionali che i

genitori assumono al fine di alleviare l'ansia del figlio, finendo invece per rinforzarla. Da qui la necessità di affiancare al lavoro terapeutico individuale con il bambino il lavoro con i genitori, al fine di ottenere una trasformazione delle aspettative e delle credenze disfunzionali che essi posseggono circa il loro comportamento e quello del bambino. Un esempio di credenza disfunzionale potrebbe essere quella per cui il bambino non debba commettere errori nelle proprie prestazioni scolastiche e/o sportive in quanto questo ne pregiudicherebbe la realizzazione futura. Da tale credenza possono quindi derivare atteggiamenti non adeguati, quali richieste prestazionali eccessive con tendenza alla svalutazione di eventuali risultati non ottimali ottenuti dal bambino (si parla di «ipercriticismo»), che contribuiranno alla genesi dei vissuti ansiosi del bambino e al loro mantenimento. Il compito del terapeuta consiste quindi nella messa in discussione di tali credenze disfunzionali. Il terapeuta è chiamato a proporre, in una sorta di dialogo socratico, delle controargomentazioni tra cui: è impossibile che un bambino non abbia la possibilità di commettere errori; non vi sono prove del fatto che un errore pregiudichi la sua realizzazione futura; certi errori sono esperienze che aiuteranno il bambino a commetterne di meno. Le argomentazioni da presentare al genitore devono essere sempre oggettive e devono consentire di smentire quanto creduto. La messa in discussione delle credenze disfunzionali dei genitori è un passo fondamentale e propedeutico al tentativo di indurre un cambiamento di atteggiamento

educativo. Il genitore che impara ad accettare e tollerare gli errori del proprio figlio sarà meno critico nei suoi riguardi e attuerà una modalità di condivisione circa l'eventuale esito negativo di un'interrogazione o di una gara sportiva, centrandosi su cosa fare e come fare per imparare dall'errore compiuto. Accanto alla tecnica cognitiva del dialogo socratico e della messa in discussione, è opportuno addestrare il genitore all'uso di tecniche che gli possano consentire di fungere da co-terapeuta supportando il bambino nell'applicazione nei contesti quotidiani dei metodi acquisiti nel corso delle sedute individuali. Per esempio, nel caso di genitori che presentano anch'essi un elevato livello di tensione emotiva può essere utile insegnare loro il rilassamento. Essi acquisiranno così la stessa tecnica insegnata al bambino e saranno in grado di «partecipare» quando il bambino stesso applicherà il rilassamento a casa.

Il ruolo del neuropsichiatra

Le linee guida AACAP e NICE suggeriscono la psicoterapia cognitivo-comportamentale come intervento di prima scelta per i disturbi d'ansia in età evolutiva. Tuttavia, le stesse linee guida indicano, per i casi in cui il disturbo è severo e in grado di compromettere in maniera significativa il funzionamento del bambino o dell'adolescente, l'introduzione di una terapia farmacologica.

La decisione di iniziare una terapia farmacologica si fonda sul giudizio clinico del neuropsichiatra infantile. Questo

specialista è abilitato a prescrivere il farmaco al bambino o all'adolescente con il consenso dei genitori e dopo averli informati sulle caratteristiche del farmaco, sulle corrette modalità d'uso e su eventuali effetti collaterali.

È importante precisare però che prima di giungere alla conclusione circa la necessità di intraprendere una terapia farmacologica, il neuropsichiatra effettua una valutazione approfondita dello stato mentale che comincia con la raccolta, in presenza dei genitori, delle principali informazioni anamnestiche riguardanti il bambino o l'adolescente. L'anamnesi viene raccolta dal neuropsichiatra nel modo che abbiamo descritto nel capitolo precedente, quindi prestando attenzione alle tappe dello sviluppo psicomotorio e linguistico, all'alimentazione e al ritmo sonno-veglia e soffermandosi sull'inserimento e sull'andamento scolastico, sulle difficoltà riscontrate e sulla vita relazionale sia nel pregresso che al momento attuale.

Di pari passo con la raccolta delle informazioni anamnestiche, il neuropsichiatra osserva l'aspetto esteriore del bambino o dell'adolescente, ovvero l'abbigliamento, il grado di pulizia personale, la postura e la capacità di mantenere il contatto oculare. Di tutti questi aspetti valuta l'appropriatezza rispetto all'età.

Segue l'analisi del comportamento, con l'osservazione e la descrizione di eventuali tic, tremori o ritardo motorio.

Ulteriore parametro da tenere in considerazione è l'eloquio, che comprende: il tono, il volume e il ritmo della voce. Si valuta inoltre se il soggetto tarda qualche secondo prima di rispondere alle domande che gli vengono poste (*latenza di risposta*).

Fondamentale poi è un'accurata osservazione dello stato emotivo del bambino o dell'adolescente, in particolare nei termini di intensità e appropriatezza rispetto al contesto. Parametri di particolare interesse per il neuropsichiatra sono l'umore del ragazzo e i comportamenti che lo esprimono, come la postura, la mimica facciale, il rallentamento motorio o, al contrario, l'aumento dei livelli di attività.

Successivamente sono valutate eventuali alterazioni dei processi di pensiero che, dal punto di vista formale, si distinguono in tendenza alla circostanzialità (risponde alle domande fornendo dettagli di scarsa rilevanza), alla tangenzialità (la risposta non è pertinente alla domanda posta), caratterizzati da fuga delle idee (serie illogica di associazioni) o con insalata di parole (parole pronunciate a caso senza alcuna organizzazione del discorso). Si osserva anche se il soggetto è facilmente distratto da stimoli estranei, se sono presenti verbigerazione (ripetizione di parole isolate per molto tempo), ecolalia (ripetizione di affermazioni o parole dell'interlocutore), povertà di eloquio, blocchi, mutismo, afonia (parlare sussurrando o a voce roca) e se la risposta alle domande viene pronunciata prima della loro formulazione definitiva (diminuzione della latenza di

risposta). I processi di pensiero vengono valutati anche per il loro contenuto, ovvero riferendosi a ciò che il bambino dice. A tal proposito, il neuropsichiatra cerca di comprendere se il bambino presenta fobie specifiche, timori, ossessioni, allucinazioni, deliri, paranoie, idee di persecuzione o se vi è l'idea o addirittura un piano per arrecare del male a sé stessi o agli altri. Vengono poi valutate la cognizione, la memoria recente e remota nonché le risorse intellettuali del bambino come la capacità di calcolare, astrarre o interpretare i proverbi. Si osserva anche se il ragazzo riesce a controllare gli impulsi durante il colloquio e se quindi possiede buone abilità di autoregolazione emotiva e comportamentale. È importante infine comprendere se è consapevole e riconosce le proprie difficoltà o le nega.

Come accennavamo in precedenza, non è detto che una visita neuropsichiatrica si concluda necessariamente con la prescrizione di una terapia farmacologica. Il compito più importante del neuropsichiatra è quello di integrare gli aspetti rilevati e osservati durante la visita con il quadro clinico emerso dalla valutazione testologica, neuropsicologica e psicopatologica condotta. Qualora infatti il neuropsichiatra, sulla base della propria valutazione, non ritenga opportuna una terapia farmacologica, darà l'indicazione per il solo percorso psicoterapeutico, rispetto al quale potrà suggerire delle modifiche, se già avviato, come per esempio l'aumento nella frequenza delle sedute di psicoterapia o l'inserimento di un sostegno alla genitorialità, e prevederà delle visite di controllo per monitorare il decorso del disturbo.

Quando si ricorre alla terapia farmacologica

A oggi, le evidenze scientifiche supportano, per i disturbi d'ansia in età evolutiva, l'uso dei farmaci che inibiscono selettivamente la ricaptazione della serotonina (*Selective Serotonin Reuptake Inhibitors*, SSRI) determinandone una maggiore concentrazione cerebrale. Come è noto, la serotonina è il neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione sia dell'umore che dell'ansia. Questi farmaci sono stati introdotti come antidepressivi, ma si sono rivelati efficaci anche per il trattamento dei disturbi d'ansia. Infatti, in alcuni studi condotti da John T. Walkup e collaboratori nel 2008, sertralina, fluoxetina, fluvoxamina e paroxetina, che appartengono proprio a questa categoria di farmaci, si sono dimostrati efficaci e ben tollerati nei bambini a partire dai 6 anni e negli adolescenti con Disturbo d'ansia.

La sicurezza degli antidepressivi SSRI è stata oggetto di molte discussioni e analisi. La grande maggioranza dei pazienti trattati non ha effetti collaterali di significatività clinica. Alcuni bambini manifestano stanchezza, mal di testa, nausea o sedazione, che spesso scompaiono dopo alcuni giorni di trattamento. In alcuni casi, però, si verificano sintomi di insonnia e agitazione, sia motoria che psichica. La causa di questa attivazione a livello del sistema nervoso autonomo non è chiara, ma è probabilmente da riferirsi a un aumento acuto della trasmissione serotoninergica. Per minimizzare il rischio di tali effetti, si raccomanda di iniziare il trattamento con dosi basse, ad esempio con 25 mg di

sertralina o 10 mg di fluoxetina, e aumentare il dosaggio gradualmente per un periodo di 1-2 settimane.

La durata del trattamento farmacologico dipende dai bisogni di ciascun paziente. In generale, sembra opportuno continuare il trattamento per almeno sei mesi dalla remissione dei sintomi. Questo periodo di tempo dovrebbe consentire il pieno recupero del funzionamento sociale, scolastico e familiare del bambino, recupero che di solito richiede più tempo del miglioramento sintomatico. Se si osserva una ricaduta dei sintomi dopo l'interruzione del trattamento, si dovrebbe effettuare un periodo di trattamento più lungo (circa dodici mesi), prima di tentare un'altra interruzione. In ogni caso, il farmaco va ridotto gradualmente, in un periodo di diverse settimane e con attento monitoraggio.

Da tenere presente infine che non ci sono studi che hanno paragonato direttamente l'efficacia di sertralina, fluoxetina, fluvoxamina e paroxetina tra di loro, e non vi è ragione di ritenerne una superiore all'altra. Nonostante l'evidenza favorevole, nessuno di questi farmaci ha un'approvazione formale dalle autorità regolatorie per venire usato nei disturbi d'ansia in età pediatrica, anche se alcuni di essi sono stati approvati per uso pediatrico con altre indicazioni. Così, per esempio, la fluoxetina è approvata negli Stati Uniti per il trattamento del bambino e adolescente con depressione maggiore o con Disturbo ossessivo-compulsivo, e la sertralina e fluvoxamina per il Disturbo ossessivo-compulsivo. Pertanto,

da un punto di vista regolatorio, il loro impiego nel bambino con Disturbo d'ansia è da considerare *off-label*, ovvero un utilizzo che esula dalla licenza d'uso del farmaco per una serie di parametri quali l'età, le indicazioni, il dosaggio e la via di somministrazione. Sulla base di ciò è necessario prevedere incontri di monitoraggio costanti e ravvicinati con il neuropsichiatra infantile che prescrive il farmaco; ciò consentirà una migliore gestione di eventuali effetti indesiderati e l'individuazione precoce di aspetti sintomatici che possono richiedere modifiche del dosaggio o addirittura del principio attivo utilizzato.

Alcuni consigli pratici per genitori e insegnanti

Il ruolo dei genitori

Per un bambino o un adolescente che deve imparare a fronteggiare la propria ansia è indispensabile avere genitori che si relazionano con lui mantenendo un atteggiamento empatico e supportivo. Abbiamo già sottolineato che, la maggior parte delle volte, i ragazzi sono in forte difficoltà quando devono descrivere il proprio disagio poiché si sentono inadeguati e, soprattutto, «diversi» dai propri coetanei.

Ma cosa possono fare nello specifico i genitori? I genitori di bambini e adolescenti ansiosi sono chiamati ad aiutare i propri figli a esprimere le paure e le preoccupazioni che vivono quotidianamente, a spiegare loro che cosa è l'ansia e a supportarli infine nel riconoscerla e fronteggiarla.

Per far sì che i ragazzi riescano a esprimere le proprie paure e preoccupazioni, il genitore può raccontare di una situazione in cui ha notato nel figlio segni di ansia. Gli chiederà così cosa ha provato, cosa temeva e come si è comportato. A questo punto, può essere utile rassicurare il ragazzo dicendogli che

l'ansia appartiene alla gamma delle emozioni negative che una persona può provare e che è quindi «normale» sperimentarla, soprattutto quando un evento o uno stimolo appaiono minacciosi.

Con un linguaggio semplice e adeguato al suo livello di sviluppo, il bambino o l'adolescente ansioso va aiutato a comprendere che l'ansia non è sempre pericolosa ma anzi adattiva quando prepara ad affrontare eventi realmente pericolosi o stimola a fare il massimo in determinate situazioni (per esempio prepararsi per un esame e/o parlare in pubblico).

È opportuno che il genitore dia informazioni specifiche al bambino o all'adolescente sulla natura e sui meccanismi dell'ansia. Così, se il ragazzo riferisce sintomi fisici come mal di testa o mal di pancia lo si può aiutare a capire che essi sono il modo in cui l'ansia, in quanto risposta fisiologica attraverso la quale il corpo segnala un pericolo, si manifesta. I genitori dovrebbero inoltre spiegare in maniera chiara che l'ansia può attivarsi anche in assenza di un vero allarme o in risposta al semplice pensiero di un'eventuale minaccia e che, seppur vissuta con estremo fastidio, ha una durata limitata nel tempo. Infine, i genitori dovrebbero «accogliere il disagio» senza mostrarsi a loro volta preoccupati o spaventati dai sintomi ansiosi del ragazzo ma anzi dovrebbero dargli suggerimenti su come gestirli.

Soprattutto i bambini infatti sono altamente responsivi alle emozioni dei genitori e usano quelle emozioni per valutare la

pericolosità o meno di una situazione e/o di uno stimolo. Insomma, vedere il proprio papà o la propria mamma calmi li aiuterà a essere calmi a loro volta! È fondamentale infine ricordare che l'atteggiamento dei genitori non deve essere mai giudicante né svalutante rispetto all'ansia dei figli.

Ma perché parlare con i propri figli dell'ansia è importante?

Innanzitutto perché dare un nome a ciò che si prova e comprendere come funziona non può che tranquillizzare il bambino o l'adolescente.

Subito dopo aver spiegato al bambino cos'è l'ansia, è importante aiutarlo non solo a riconoscere i sintomi con i quali si manifesta ma anche a individuare le preoccupazioni e i timori che la generano. Per esempio, nel caso di un bambino con Disturbo d'ansia sociale, può essere utile ricordare una festa di compleanno di un amichetto (situazione ansiogena) nel corso della quale il bambino ha sperimentato sintomi somatici (ad esempio nausea o mal di pancia) con associati pensieri minacciosi (ad esempio «Mi giudicheranno non adeguato, rideranno di me e farò brutta figura»).

Per aiutare il bambino a individuare i sintomi dell'ansia si possono utilizzare varie strategie: a un bambino piccolo si può chiedere di disegnare un corpo e indicare in quale parte sente crescere l'ansia; con un adolescente invece può bastare porre la domanda diretta «Cosa senti?», o proporgli una lista di sintomi fisici tipici legati all'ansia in modo che possa individuare quelli che prova.

Il passo successivo consiste nel rendere il ragazzo consapevole delle limitazioni che l'ansia sta determinando nella sua vita. Gli si può chiedere per esempio di immaginare come sarebbe la sua vita se da un momento all'altro l'ansia sparisse e di riflettere dunque su quante cose, allo stato attuale, non riesce a fare per colpa dell'ansia. Supportare il proprio figlio rendendolo consapevole delle limitazioni nel quotidiano dovute all'ansia è un passaggio fondamentale che il genitore dovrà compiere per costruire la motivazione necessaria affinché egli accetti i percorsi di valutazione e terapia che eventualmente seguiranno.

Dal punto di vista pratico, i genitori possono assumere loro stessi degli atteggiamenti che aiuteranno i figli a gestire gradualmente l'ansia in maniera sana e funzionale. A tal proposito è opportuno innanzitutto diminuire le rassicurazioni, così da aiutare il bambino a gestire meglio l'incertezza. I bambini e gli adolescenti ansiosi infatti hanno bisogno di chiedere continue rassicurazioni, in quanto per loro i genitori sono la figura principale cui chiedere spiegazioni sul mondo e sentono il bisogno di essere sicuri che tutto quello che stanno facendo o che sta succedendo è giusto e adeguato. Chiedendo rassicurazioni il bambino o l'adolescente ansioso cerca di convincersi che gli eventi non sono così minacciosi come li percepisce. Tuttavia, più il genitore soddisfa il bisogno di rassicurazione e maggiori diventano le richieste da parte del bambino. Viene così a innescarsi un circolo vizioso che allevia momentaneamente l'ansia ma la mantiene a lungo termine. Questa modalità non

è funzionale perché trasmette al bambino il messaggio di dover cercare protezione e chiedere aiuto, ostacolando la costruzione di un senso di autonomia e indipendenza.

Un genitore, infatti, non può assicurare al bambino che non verrà mai preso in giro dai coetanei per qualcosa ma può esprimergli la fiducia nel fatto che lui potrà gestire con successo la situazione. Lo si incoraggia così a non richiedere costantemente rassicurazioni ma a valutare in maniera oggettiva l'effettiva minacciosità delle situazioni da lui temute e ad assumere diverse prospettive al fine di accettare e gestire lo stato ansioso.

È importante che tutta la famiglia concordi sul fatto di evitare le rassicurazioni. I genitori possono rispondere alle preoccupazioni riportate dal figlio con un atteggiamento centrato sul *problem solving*, ovvero ragionando insieme a lui su come gestire la situazione, affrontando le difficoltà e valutando quali strategie attuare per far diminuire l'ansia. Quando il bambino non richiede più rassicurazioni, è importante congratularsi con lui perché è stato capace di fronteggiare l'ansia autonomamente. Infatti, quando il bambino o l'adolescente riuscirà a smettere di basarsi sulle rassicurazioni dei propri genitori per «sentire» di star gestendo l'ansia, acquisirà un senso di indipendenza e competenza. Proprio per promuovere quest'ultimo, i genitori dovrebbero quindi incoraggiare i figli a partecipare alle attività che tendono a evitare, per esempio ragionando insieme sugli aspetti positivi del prendervi parte e concordando le modalità

che assicurino la partecipazione con livelli di ansia inferiori e «più gestibili». Non dimentichiamo infatti che il bambino e l'adolescente ansiosi tenderanno a evitare le situazioni ansiogene, adottando una strategia di evitamento che consente di ottenere una diminuzione dell'ansia a breve termine ma che manterrà interamente la rappresentazione della situazione in senso minaccioso impedendo loro di sperimentare la capacità di farvi fronte.

Riprendendo la situazione della festa di compleanno, si può ragionare con il bambino sulla possibilità che egli ha di incontrare i compagni di classe, passare del tempo e divertirsi con quelli con i quali si trova meglio o partecipare a un determinato gioco per lui piacevole che sarà proposto alla festa; ancora si potrà dare un'«àncora» al bambino concordando un orario di rientro anticipato o dandogli la possibilità di chiamare il genitore durante la festa qualora sentisse di non riuscire a gestire l'ansia.

Favorire la partecipazione alle attività, anche a quelle vissute come più ansiogene, consente di aiutare il bambino ad accrescere l'autoefficacia, affrontare le paure e sperimentare nuove modalità per farvi fronte. Nel caso in cui il bambino del nostro esempio riuscisse a partecipare alla festa di compleanno o a qualsiasi altra situazione sociale, sarebbe importante premiarlo riconoscendone l'impegno anche se il risultato in una prima fase fosse parziale. Quindi, per esempio, se il bambino è riuscito a rimanere tutto il tempo alla festa ma ha avuto bisogno di rivolgersi al genitore in una

sola occasione, va premiato e gratificato per l'impegno mostrato e per l'«avvicinamento» all'obiettivo finale di gestione della situazione senza bisogno di alcun supporto.

SUGGERIMENTI PRATICI



FIG. 6. Un esempio di comunicazione efficace genitore-bambino ansioso.

- Limitare la possibilità che il bambino assista a reazioni di eccessiva ansia da parte di qualche altro bambino o adulto.
- Se siete genitori ansiosi o avete qualche fobia particolare, cercate di controllarvi in presenza del bambino.
- Cartoni animati o fiabe che all'apparenza possono apparire innocui, per un bambino di 3, 4 o 5 anni possono essere terrorizzanti.

- Con la crescita il bambino può essere esposto con gradualità a situazioni da lui temute, mostrandogli che in realtà non si tratta di eventi pericolosi. Durante l'esposizione è utile cercare di evocare in lui sensazioni piacevoli antagoniste dell'ansia. In base all'età e al livello di sviluppo alcuni accorgimenti possono essere: parlargli con dolcezza, coccolarlo, fargli tenere il suo giocattolo preferito, offrirgli un gelato.

- Evitare di biasimare o svalutare il bambino per la sua ansia. Si può far notare invece che alcune preoccupazioni sono infondate e che non è insolito essere preoccupati per determinati eventi o situazioni.

- Può essere utile fare ricorso all'umorismo, scherzando sulle ansie del bambino ma facendo attenzione a non deriderlo. Ciò che vogliamo è far sì che il bambino sdrammatizzi sull'evento senza sentirsi ridicolo.

Il ruolo della scuola

Sono diversi i modi attraverso i quali gli insegnanti possono sostenere in maniera adeguata i bambini e gli adolescenti con Disturbo d'ansia. A scuola l'ansia insorge a causa della paura di non riuscire a tollerare un eventuale insuccesso, di non raggiungere un rendimento sufficiente, di deludere le attese genitoriali e di non sentirsi accettati dal gruppo classe. In particolare, i ragazzi possono manifestare eccessiva preoccupazione e ansia per le verifiche o le interrogazioni orali, ripetuta ricerca di approvazione da parte degli

insegnanti, difficoltà a entrare in classe la mattina e difficoltà di concentrazione con mancato completamento dei compiti assegnati. Nei casi più gravi, l'estremo timore di sbagliare e di sentirsi al centro dell'attenzione li induce a rifiutare la partecipazione a qualsiasi attività didattica.

È essenziale innanzitutto che gli insegnanti accolgano le paure e le preoccupazioni riportate dagli alunni senza minimizzare o, al contrario, sopravvalutare; ciò fa sentire i bambini e gli adolescenti compresi e non giudicati. È molto importante inoltre che gli insegnanti stabiliscano una collaborazione stretta con le famiglie e gli altri professionisti coinvolti nel progetto terapeutico costruito attorno al bambino. La condivisione con la famiglia e gli altri operatori di obiettivi e strategie permetterà di lavorare in un'unica direzione. In linea generale, sarebbe importante che l'approccio degli insegnanti seguisse alcuni punti ben precisi, tra cui: ridurre le richieste, facilitare la partecipazione, incoraggiare l'interazione all'interno della classe, sottolineare i successi piuttosto che i fallimenti evitando qualsiasi commento sarcastico rispetto alla performance e premiare i risultati raggiunti.

Può essere opportuno che i docenti modulino le richieste, vale a dire riducano la mole dei compiti assegnati a casa, forniscano indicazioni più chiare e riorganizzino il modo in cui vengono svolte le prove in classe. Ad esempio, per quanto concerne la struttura delle verifiche, si può pensare di trasformare le domande aperte in quesiti a risposta multipla e

può essere utile prestabilire delle interrogazioni per venire incontro alle esigenze dell'alunno.

Gli insegnanti possono inoltre favorire e motivare l'interazione del bambino o adolescente ansioso con il resto della classe proponendo attività di gruppo che ne valorizzino i punti di forza. Così, nel caso di un bambino ansioso rispetto alla propria prestazione e inibito dalla paura di poter essere preso in giro dai coetanei, l'insegnante può esplicitare davanti agli altri una sua particolare capacità o un suo punto di forza, consentendogli così di percepire che una sua caratteristica positiva viene riconosciuta da altri all'interno di un contesto sociale.

Nel prossimo paragrafo dedicheremo spazio a ciò che la scuola può fare nel caso di bambini o adolescenti con Disturbo d'ansia sociale. Abbiamo scelto questo disturbo in quanto rappresenta a oggi una delle principali cause di rifiuto scolastico o addirittura abbandono scolastico in età evolutiva.

SUGGERIMENTI PRATICI

- Porre attenzione ai successi piuttosto che ai fallimenti, premiando gli sforzi compiuti.
- Durante le ore di lezione, se l'ansia diventa ingestibile, consentire al bambino di lasciare l'aula, permettendogli di aspettare l'abbassamento dell'ansia in uno spazio protetto e sotto sorveglianza di un adulto.

- Preferire valutazioni scritte a quelle orali, consentendo in caso fosse necessario un tempo maggiore per l'esecuzione del compito.
- Modificare situazioni stressanti. Ad esempio nei momenti di dibattito in classe porre domande a risposta chiusa oppure interrogare il bambino da solo senza la presenza di altri bambini.
- Supportare il bambino nell'interazione con i compagni di classe, prevedendo piccole attività di gruppo non competitive. Rimodulare le richieste scolastiche, riducendo la quantità di compiti assegnati, fornendo indicazioni chiare e semplici sullo svolgimento e predisporre in calendario momenti di verifica concordati con l'alunno.

Il Disturbo d'ansia sociale: cosa può fare l'insegnante?

A scuola i bambini e gli adolescenti con Disturbo d'ansia sociale hanno paura di commettere errori, di parlare o agire in modo stupido, di essere esclusi dai coetanei o di compiere errori davanti agli altri. Molto preoccupati di ricevere giudizi negativi, spesso si vergognano di quei sintomi come la sudorazione, il tremore, la difficoltà a parlare che essi manifestano per esempio nel corso di un'interrogazione, una recita o banalmente durante la ricreazione. Essi si bloccano perché non riescono a colloquiare e a esporsi di fronte ai compagni; motivo per cui non partecipano alle attività di gruppo o di discussione collettiva. Finiscono così per chiedere

ai genitori, in maniera sempre più decisa, di non mandarli a scuola.

Questi ragazzi presentano una bassa autostima e molteplici difficoltà anche di tipo cognitivo, alcune delle quali precedentemente citate per le altre tipologie di disturbi d'ansia, come le difficoltà di apprendimento e di concentrazione nello svolgimento dei compiti assegnati dalle maestre in classe o per casa, associate a frequenti vuoti di memoria durante le verifiche e le interrogazioni. Considerato quanto detto sin qui, diventa cruciale il ruolo svolto dagli insegnanti: essi possono collaborare con la famiglia sin da quando il bambino manifesta i primi segni di rifiuto della scuola. L'obiettivo deve essere quindi quello di favorire la continuità scolastica nel caso di bambini che fanno molte assenze o addirittura promuovere il ritorno a scuola nei casi di abbandono scolastico. Insegnanti, genitori e ragazzo possono così concordare un piano volto a facilitare un rientro graduale, ad esempio attraverso la scelta iniziale dei giorni e delle fasce orarie in cui tornare, anche per un tempo minimo, per poi passare a tempi di permanenza sempre maggiori.

Nei casi in cui il ragazzo, pur essendo entrato a scuola, manifesti livelli di ansia non facilmente gestibili, gli insegnanti possono farlo uscire dalla classe e dargli la possibilità di raggiungere, sotto la loro supervisione, o sotto quella di altri operatori, un luogo concordato in precedenza, percepito come «sicuro» (ad esempio recarsi a colloquiare con

un determinato insegnante) e dove con una certa probabilità i livelli di ansia diminuiranno.

Durante le verifiche si consiglia di lasciare più tempo a disposizione al ragazzo in quanto l'ansia prestazionale influisce sull'attenzione, sul recupero mnemonico delle informazioni e sulla performance. Gli insegnanti devono sempre essere consapevoli di queste difficoltà, evitare i giudizi negativi, la focalizzazione su eventuali errori dello studente e il richiamo in presenza di tutta la classe.

Il Disturbo d'ansia sociale spinge il bambino o l'adolescente ad allontanarsi dai compagni di classe, talvolta sino all'isolamento totale. Gli insegnanti devono allora cercare di favorire la partecipazione del ragazzo ad attività di gruppo che rafforzino il senso di collaborazione reciproca e ne aumentino la percezione circa le proprie possibilità di essere accettato e inserito all'interno del gruppo classe. Gli sforzi del ragazzo, sia dal punto di vista didattico che relazionale, o semplicemente i suoi tentativi di rimanere a scuola nonostante l'ansia, vanno premiati ed elogiati. I rinforzi positivi, come gratificazioni o valutazioni positive, conferiscono valore all'impegno attuato dall'alunno e sono fondamentali per promuovere in lui una ulteriore conoscenza dei suoi punti di forza e contribuire ad ottenere una buona riuscita e il conseguente benessere scolastico.

Così come la famiglia, anche la scuola può divenire un contesto in cui sentirsi accettati e accolti con fiducia!

Falsi miti e corrette informazioni

Vorremmo concludere riportando alcuni tra i miti più frequenti raccolti e proposti dall'Anxiety and Depression Association of America (ADAA). La raccolta, presente sul sito <https://adaa.org/understanding-anxiety/myth-conceptions>, si rivolge a chi soffre di ansia. Noi la riportiamo adattandola sulla base della nostra esperienza con l'età evolutiva, cercando di fare chiarezza sui falsi miti e sulle corrette informazioni relativamente a questi disturbi.

- Durante un attacco di panico molto grave puoi svenire o perdere il controllo. In realtà durante un attacco di panico la pressione tende ad aumentare leggermente, pertanto è improbabile che tu possa svenire. Lo svenimento è associato infatti a un improvviso calo della pressione sanguigna che non si manifesta nel corso di un attacco di panico.
- *Se hai un disturbo d'ansia, è importante evitare lo stress e le situazioni che ti fanno sentire «ansioso».* È vero che lo stress non aiuta, ma ricorda che evitare l'ansia tende a rafforzarla. Agire come se fossi fragile ed evitare i rischi nella quotidianità potrebbe farti sentirti demoralizzato. Ricorda che puoi essere ansioso ma puoi fare comunque tutto ciò che devi fare.
- *L'ansia eccessiva è una caratteristica intrinseca della persona e per questo imm modificabile.* Al contrario, l'ansia eccessiva si può e si deve curare quando intacca significativamente il benessere della persona. La terapia può aiutarti a ridurre la

preoccupazione e la sofferenza e ad apprendere diverse modalità di gestire i tuoi pensieri negativi, indipendentemente dal tuo temperamento e da quanto tempo le preoccupazioni eccessive sono state presenti nella tua vita.

- *Una scorta infinita di rassicurazioni compassionevoli da parte della famiglia e degli amici e un aiuto per evitare lo stress «curano» il disturbo d'ansia in chi ne soffre.* Hai bisogno di maggiore aiuto, non è sufficiente la sola riduzione dello stress. Potresti avere bisogno di affrontare le tue paure, di conoscere meglio i tuoi sintomi, di smettere di evitare le cose che maggiormente ti preoccupano, di imparare a tollerare alcune esperienze o di cambiare il modo in cui pensi e ti comporti rispetto alle altre persone. Gli amici o i familiari potrebbero inavvertitamente farsi prendere dalla necessità di rassicurarti e favorire così il persistere delle tue paure impedendoti di affrontarle. Sarebbe più utile incoraggiarti, in modo gentile ed empatico, ad affrontare l'ansia e i dubbi, piuttosto che a evitarli.
- *Le cause dei disturbi d'ansia sono normalmente radicate nell'infanzia, quindi una terapia efficace deve concentrarsi su quel periodo della tua vita.* Anche se esperienze negative precoci possono avere un ruolo nei disagi emotivi vissuti nelle fasi di vita successive, non sempre le «radici» dell'ansia vanno cercate nell'infanzia. Devi sapere che esiste una predisposizione genetica, ovvero: avere familiari con disturbi d'ansia accresce il rischio di poterne soffrire, ma la

manifestazione del disturbo dipende da una combinazione tra fattori genetici, condizioni ambientali e tratti individuali.

- *I farmaci sono l'unico trattamento nei disturbi d'ansia.* I farmaci SSRI possono essere efficaci. Tuttavia, soprattutto in età evolutiva se ne raccomanda la prescrizione solo per i bambini e adolescenti in cui il Disturbo d'ansia limita fortemente la capacità di svolgere le normali attività quotidiane come andare a scuola, praticare uno sport o passare del tempo con i coetanei. La ricerca scientifica evidenzia infatti come per i casi di disturbi d'ansia lieve la psicoterapia cognitivo-comportamentale debba essere la terapia di prima scelta, vista la sua efficacia.

Conclusioni

Cari lettori,

che siate psicologi, psicoterapeuti, pediatri, neuropsichiatri, genitori o insegnanti, con questo libro abbiamo voluto raccontarvi come si manifesta e come si affronta l'ansia nei vostri ragazzi, che siano pazienti, alunni o i vostri figli. Tutto quello che avete letto deriva dalle nostre ricerche, dall'avere come guida, per le nostre decisioni cliniche e terapeutiche, la letteratura scientifica sull'argomento e, ancora più importante, dall'aver incontrato, nel nostro lavoro quotidiano presso l'Unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Bambino Gesù di Roma, bambini e adolescenti accompagnati dalle loro famiglie.

Vi abbiamo raccontato innanzitutto che l'ansia non è una cosa solo da grandi ma è un'emozione di per sé normale e prevedibile in determinati momenti dello sviluppo del bambino. Per esempio, paure quali quella del buio o di allontanarsi dal papà e dalla mamma sono abbastanza comuni durante l'infanzia e non devono preoccupare i genitori. In alcuni casi, però, queste ed altre paure possono diventare patologiche perché si manifestano in maniera intensa, durano a lungo, sono molto frequenti e, soprattutto,

impediscono al bambino e al ragazzo di affrontare serenamente i vari impegni quotidiani (come la scuola, lo sport, le uscite con gli amici ecc.). In questi casi abbiamo parlato di disturbi d'ansia e di come essi rappresentino il disturbo psichiatrico più comune durante l'infanzia.

Attraverso le storie dei «nostri» bambini vi abbiamo mostrato la vita quotidiana di chi soffre di questo disturbo. Le storie di Greta, Elisa e Michela raccontano i disturbi d'ansia dei più piccoli – come il Disturbo d'ansia da separazione, il Mutismo selettivo e la Fobia specifica – gli incontri con Marco, Claudio, Matteo, Marta e Alessandro ci hanno, invece, consentito di raccontarvi i disturbi d'ansia dei più grandi, come il Disturbo d'ansia sociale, il Disturbo di panico, l'Agorafobia, il Disturbo d'ansia generalizzata e la Fobia scolare. Al di là delle categorizzazioni abbiamo visto che durante l'infanzia i segnali di ansia più frequenti sono i sintomi somatici come mal di pancia o mal di stomaco e mal di testa. Possono poi manifestarsi forti preoccupazioni circa la propria sicurezza e soprattutto quella dei propri cari, richieste continue di dormire con i genitori, frequenti incubi notturni e richieste di rassicurazione costanti. In adolescenza, invece, riscontriamo spesso un forte rifiuto a frequentare regolarmente la scuola, nervosismo e preoccupazione quando si è fuori casa o difficoltà nel parlare e nell'incontrare persone nuove e, infine, difficoltà di addormentamento o risvegli precoci. Nella nostra pratica clinica quotidiana, spesso i genitori di un bambino o adolescente cui diagnosticiamo un

disturbo d'ansia ci chiedono: «Perché?», «Quale è la causa?», «È colpa nostra?».

In questo libro ci siamo soffermati a spiegare come i disturbi d'ansia siano il risultato dell'interazione tra fattori genetici, temperamentali e ambientali.

Abbiamo quindi raccontato come oltre all'ereditarietà, un ruolo importante è giocato dal temperamento del bambino, ovvero la disposizione di base, presente in ciascuno di noi sin dalla nascita, che influenza il modo in cui esprimiamo e regoliamo le nostre emozioni, il nostro tono dell'umore e la propensione alle relazioni sociali. Abbiamo quindi visto che i bambini e gli adolescenti che hanno un temperamento inibito, quindi con scarsa apertura alle relazioni sociali e all'espressione delle emozioni, sono più esposti al rischio di non riuscire a gestire stati emotivi negativi come l'ansia. Nella stessa misura, alcuni fattori ambientali – come la presenza di genitori ansiosi, centrati sull'eccessivo controllo e sulla critica – non favoriscono lo sviluppo di un'autonomia quotidiana nel bambino e lo espongono al rischio di sviluppare un disturbo d'ansia. Anche l'essere vittima di eventi traumatici (in particolare abusi, maltrattamenti, gravi esperienze di bullismo) ha un ruolo significativo nell'ansia del bambino e dell'adolescente. Insistere sull'eziologia multifattoriale dei disturbi d'ansia in età evolutiva ci è sembrato utile a liberare i genitori dai sensi di colpa che spesso provano. Ricordiamo inoltre che, nonostante la presenza di fattori di rischio, non tutti i bambini e non tutti gli adolescenti svilupperanno un

disturbo d'ansia. Esistono infatti anche dei fattori di protezione – le buone capacità cognitive, una buona autostima e, in ultimo, ma fondamentale, un buon livello di integrazione nel gruppo dei pari – che possono proteggere il benessere psicologico del bambino o dell'adolescente aumentandone le capacità di fronteggiare eventuali eventi di vita stressanti.

Chi può contribuire allo sviluppo e al mantenimento dei fattori di protezione nel bambino? Sicuramente la famiglia e la scuola. Da qui la necessità di individuare e trattare l'ansia del bambino e dell'adolescente tenendo conto dei contesti, familiare e scolastico, in cui egli è inserito. Fortunatamente è cresciuta nel corso del tempo l'attenzione al benessere psicologico dei bambini e questo ha portato a un aumento delle richieste di consultazione specialistica. I genitori, infatti, o di propria iniziativa o su segnalazione degli insegnanti, si rivolgono a noi chiedendo di valutare la presenza di un disturbo e di essere aiutati a fronteggiarlo. Rispetto al passato, dunque, è maggiore la consapevolezza circa l'aiuto che figure come le nostre (neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta) possono dare nella cura del disagio psicologico in età evolutiva.

Le modalità con cui i disturbi d'ansia si manifestano non cambiano nel tempo, ma a modificarsi sono i fattori stressanti che possono facilitarne l'insorgenza. Per esempio, negli ultimi anni l'eccessiva pressione scolastica ha contribuito alla comparsa di stati d'ansia nei bambini e nei ragazzi già

vulnerabili. O ancora, l'uso precoce e non ben regolato delle nuove tecnologie (come tablet e smartphone) favorisce la creazione di una rete sociale «virtuale» limitando, quindi, le possibilità di sperimentare il confronto diretto e la condivisione di attività concrete. Viene meno quindi quel «sostegno sociale», considerato protettivo ai fini del benessere psicologico, che agisce attraverso il feedback e la sensazione di essere oggetto di amore e di cure, di essere stimati e apprezzati e di far parte di una rete di comunicazione e di obblighi reciproci. Questo sostegno può essere fornito dalla cerchia familiare, dagli amici o dalle persone che appartengono alle varie realtà sociali della comunità, come le associazioni o i gruppi di aggregazione sia formali che informali. Prendere coscienza dell'aumento dei fattori stressanti, e di quali abbiano un peso particolare sul singolo bambino o adolescente che incontriamo, è per noi fondamentale anche ai fini dell'intervento terapeutico che andremo ad adottare.

È questo il messaggio fondamentale di questo piccolo libro: l'ansia può essere gestita, i disturbi d'ansia possono essere trattati e si può imparare a fronteggiarli!

Bisogna accettare che in alcune fasi della crescita anche i nostri ragazzi possano sperimentare momenti di disagio psicologico che può esprimersi con la presenza di stati ansiosi. In questi casi, vanno messi da parte sensi di colpa, la paura di mettersi in discussione come genitori e il timore di un eventuale trattamento psicoterapico o psicofarmacologico.

Riconoscere precocemente il disagio, *promuovere* strategie educative appropriate, *attuare* interventi tempestivi e calibrati sull'età e il livello di sviluppo del bambino sono passi fondamentali nella presa in carico e nell'efficacia del trattamento di un disturbo d'ansia in età evolutiva e sono le parole con cui vogliamo chiudere questo nostro piccolo contributo.

Per saperne di più

Il libro nasce dall'idea di presentare la tematica dell'ansia in età evolutiva, una problematica molto diffusa che, come si è visto, accomuna in maniera differente bambini e adolescenti, comportando molteplici difficoltà che vanno a influire sui loro contesti di vita. Sono state prese in considerazione le esperienze cliniche e le concettualizzazioni derivate dal contributo di alcuni studiosi del panorama scientifico nazionale e internazionale con l'obiettivo di offrire un approfondimento necessario a comprendere più da vicino quando insorge e si manifesta il disturbo, e soprattutto come i genitori e i professionisti del settore possono essere d'aiuto al bambino o all'adolescente per fronteggiare la problematica.

Qui di seguito presentiamo brevi introduzioni dei principali testi utilizzati, la cui scelta non è casuale e rispetta il filo conduttore degli argomenti affrontati.

Si è deciso innanzitutto di descrivere cos'è l'ansia riferendoci al contributo di Joseph Ledoux. L'autore, nel libro *Ansia. Come il cervello ci aiuta a capirla*, Milano, Raffaello Cortina, 2016, pone l'accento sull'epoca in cui viviamo, caratterizzata da una prevalenza significativa di persone che soffrono d'ansia e di attacchi di panico. Il neuroscienziato

sottolinea le analogie e le differenze tra paura e ansia e distingue chiaramente l'ansia ritenuta normale da quella patologica. Tuttavia egli ha il merito di aver trattato e approfondito i meccanismi neurali a fondamento dell'ansia e della paura proponendoci quindi un collegamento tra quanto accade nel nostro cervello in situazioni di percepita minaccia e le nostre reazioni comportamentali.

Al fine di descrivere i criteri, accettati dalla comunità scientifica, che consentono al clinico di differenziare tra le semplici condizioni di disagio e l'ansia patologica ci siamo riferiti al *DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, Raffaello Cortina, 2014, messo a punto nel 2013 dall'American Psychiatric Association (APA). Il manuale diagnostico e statistico è l'attuale sistema di classificazione dei disturbi mentali, aggiornato alla quinta edizione (DSM-5). Per poter poi descrivere dettagliatamente le principali manifestazioni dell'ansia in età evolutiva il nostro riferimento nello specifico è stato anche *L'esame diagnostico con il DSM-5 per bambini e adolescenti*, Milano, Raffaello Cortina, 2014, riferito all'età evolutiva.

Per ciascun Disturbo d'ansia in età evolutiva abbiamo raccontato la storia di bambini o adolescenti incontrati nella nostra esperienza clinica quotidiana. Abbiamo pensato fosse così più semplice per il lettore comprendere cosa significhi convivere con un Disturbo d'ansia durante l'infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza. In questo caso, il nostro riferimento è stato il manuale di Fabio Celi e Daniela Fontana

dal titolo *Psicopatologia dello sviluppo. Storie di bambini e psicoterapia*, Milano, McGraw-Hill Education, 2015. Il manuale pone il lettore a contatto con la realtà psicopatologica dell'età evolutiva mediante la descrizione di storie e incontri terapeutici, dai quali emerge in primo piano il vissuto emotivo di bambini e adolescenti e dei loro genitori.

L'eziologia del disturbo d'ansia viene argomentata facendo riferimento alla ricerca condotta da Ronald M. Rapee ed esposta nell'articolo *Preschool Environment and Temperament as Predictors of Social and Nonsocial Anxiety Disorders in Middle Adolescence*, in «Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry», 53, 3, marzo 2014, pp. 320-328. L'autore sostiene che l'insorgenza del disturbo derivi dall'interazione tra fattori genetici, fattori ambientali e fattori temperamentali.

Miriam A. Schiele da parte sua considera l'infanzia come il periodo soggetto a una maggiore vulnerabilità a causa della capacità del cervello di svilupparsi e modificarsi con le esperienze. L'autrice, insieme a K. Domschke, in *Epigenetics at the Crossroads between Genes, Environment and Resilience in Anxiety Disorders*, in «Genes, Brain and Behavior», 17, e12423, doi.org/10.1111/gbb.12423 trasmette l'importanza delle risorse emotive e comportamentali del soggetto nel contrastare gli eventi di vita stressanti e prevenire l'insorgenza dei disturbi d'ansia.

Per quanto concerne l'assessment psicopatologico, le strategie terapeutiche, le fasi del trattamento e le tecniche

cognitivo-comportamentali per i disturbi d'ansia in età evolutiva, consigliamo i testi di Furio Lambruschi (a cura di), *Psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva. Procedure di assessment e strategie psicoterapeutiche*, Torino, Bollati Boringhieri, 2014; e di Philip Kendall e Mario Di Pietro, *Terapia scolastica dell'ansia: guida per psicologi e insegnanti*, Trento, Erickson, 1995. Il primo, a partire da un'accurata classificazione dei disturbi mentali, valorizza gli ambiti applicativi, clinici e di ricerca a seguito del lavoro svolto con bambini e adolescenti che presentano un quadro psicopatologico (con particolare riferimento alle procedure di *assessment* e agli interventi psicoterapeutici). Il secondo enfatizza le analisi sperimentali che dimostrano la validità e l'efficacia dell'intervento terapeutico per i disturbi d'ansia ideato da Philip Kendall. Il volume fornisce strumenti pratici utili sia a neuropsichiatri infantili e psicologi, sia a coloro che operano nel contesto scolastico. È essenziale anche per gli insegnanti acquisire conoscenze sulla natura dei disturbi d'ansia allo scopo di giungere a una maggiore comprensione della problematica e dei bisogni espressi dall'alunno.

Per concludere, altrettanto fondamentali sono i contributi di Antonella Montano, Roberta Rubbino e Fortunata Salvaguardia nell'opuscolo da loro curato: *I disturbi d'ansia in età evolutiva*, Roma, Istituto A.T. Beck, 2017. Le autrici definiscono le caratteristiche dell'ansia patologica con l'obiettivo di fornire ai genitori una guida per la conoscenza del disturbo e consentire loro di rapportarsi con il figlio in maniera adeguata e funzionale alla diminuzione dell'ansia.

Ringraziamenti

In questo libro abbiamo voluto raccontare la nostra esperienza clinica quotidiana con bambini e adolescenti che presentano un disturbo d'ansia. Abbiamo incontrato loro e le loro famiglie nell'Unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il primo ringraziamento, dunque, va proprio al nostro Ospedale che in questi anni ci ha consentito di creare un'équipe specialistica composta da neuropsichiatri infantili e psicoterapeuti con il fine di individuare tempestivamente l'insorgenza dei disturbi d'ansia nei ragazzi e di guidare il successivo trattamento.

Un ringraziamento va anche ai colleghi, con i quali ogni giorno lavoriamo condividendo osservazioni cliniche ma anche storie di bambini e adolescenti, e a Maria Giovanna Schiavone e Maria Cristina Tata per il supporto nella redazione di questo libro.

Infine, il ringraziamento più profondo va ai ragazzi e alle famiglie che incontriamo ogni giorno, che si affidano alle nostre cure e che ci consentono di dare loro voce tramite la scrittura di testi come questo.